

VI(H)SIBLES.

*Un recorrido inmersivo por las heridas
y reconstrucciones que dan forma a las
vivencias del VIH en Chile.*

Autor: Augusto Reyes

Profesores guía: Sergio Majluf &
Manuel Gallardo

ABSTRACT | RESUMEN

VI(H)SIBLES es un proyecto que aborda la persistencia del estigma y la desinformación en torno al VIH en Chile, situándose desde una perspectiva cuir que reconoce tanto la violencia simbólica como las formas de resistencia que emergen en las comunidades disidentes. A pesar de los avances biomédicos, persisten imaginarios que asocian el virus a prácticas consideradas desviadas, reforzando narrativas moralizantes que han contribuido al miedo, la exclusión y la patologización de ciertos cuerpos.

La investigación articula referentes provenientes de la salud pública, el activismo, las disidencias sexuales y el diseño social y audiovisual, integrando un proceso de etnografía audiovisual mediante entrevistas en profundidad a personas que viven con VIH. Estos testimonios permiten comprender el estigma desde su dimensión emocional, política y afectiva, visibilizando experiencias normalmente ausentes en el discurso institucional.

A partir de este análisis se formula una propuesta instalativa que utiliza tecnologías inmersivas, proyecciones interactivas y diseño espacial para construir un dispositivo narrativo. La instalación busca traducir las vivencias recogidas en una experiencia sensorial que tensione los imaginarios tradicionales y evidencie las limitaciones de las campañas comunicacionales basadas en el miedo o la moralización.

El proyecto propone así un enfoque alternativo de comunicación y sensibilización, centrado en la cercanía, la escucha y la afectividad, con el objetivo de contribuir a una comprensión más empática y situada del VIH en el contexto chileno contemporáneo.



Figura 1. Diagrama de Venn. Elaboración propia.

PALABRAS CLAVE: VIH, ESTIGMA SOCIAL, NUEVOS MEDIOS, DISEÑO AUDIOVISUAL.

MOTIVACIÓN PERSONAL

Quienes convirtieron la vulnerabilidad en resistencia.

Desde mi formación y mi cercanía con la cultura cuir, he desarrollado un interés constante por las problemáticas que atraviesan a las disidencias sexo-genéricas. Este espacio no solo ha sido un lugar de pertenencia, sino también una comunidad que resiste, crea y se reinventa a pesar de sus propias grietas; un territorio roto por la violencia histórica, pero profundamente rica en afectos, creatividad y cuidado colectivo.

En ese mismo entorno he sido testigo de las exclusiones que enfrentan las personas que viven con VIH, evidenciando cómo el estigma persiste incluso en comunidades que deberían ser refugio. Esta contradicción, entre la libertad que buscamos y las heridas que cargamos, me impulsa a trabajar desde el diseño para visibilizar lo que tantas veces se ha mantenido en silencio.

Creo en la importancia de dejar de ocultarse en una sociedad donde la libertad está constantemente en riesgo. Por eso, este proyecto nace como un acto de resistencia queer: una apuesta por narrativas más empáticas, informadas e inclusivas, que permitan mirar el VIH desde la dignidad y no desde el miedo.

ÍNDICE

1. Introducción	04	
1.1. Ámbitos de estudio		
2. Marco teórico	05	
2.1. VIH en Chile		
2.2. Estigma hacia PVVIH		
2.3. Campañas comunicacionales		
2.4. Diseño y Nuevos medios		
2.5. Estado del arte		
2.6. Área de innovación tecnológica		
3. Formulación del proyecto	42	
3.1. Problemática		
3.2. Hallazgos		
3.3. Oportunidad de diseño		
3.4. Objetivos		
4. Análisis de usuario	47	
4.1. Usuario objetivo		
4.2. Arquetipo		
5. Metodología	50	
5.1. Metodología general		
5.2. Carta Gantt		
5.4. Alianzas estratégicas		
5.5. Marco ético		
5.6. Convocatoria y guía de entrevistas		
6. Desarrollo proyectual	58	
6.1 Eje narrativo		
Matriz de análisis cualitativo		
Pilares narrativos		
Construcción del relato		
6.2. Eje expositivo		
Herida / Cicatriz		
Recorrido		
6.3. Eje interactivo / tecnológico		
Flujos de interacción		
Sensores		
Comportamiento del sistema		
7. Lenguaje visual del proyecto	72	
7.1. Códigos formales.		
7.2. Identidad gráfica		
7.3. Desarrollo audiovisual		
8. Implementación	89	
8.1. Producción de rodajes		
8.2. Postproducción		
8.3. Desarrollo interactivo		
9. Propuesta expositiva	93	
9.1 Descripción de la instalación		
9.2. Etapas		
9.3. Planimetría general		
9.4. Detalles funcionales		
9.5. Renders		
10. Viabilidad	101	
10.1. Costos de implementación		
10.2. Viabilidad		
11. Conclusiones	107	
11.1. Reflexiones		
12. Agradecimientos	108	
13. Bibliografía	109	
14. Anexos	112	

INTRODUCCIÓN

En Chile, el VIH continúa siendo un virus profundamente estigmatizado, no solo por su dimensión biomédica, sino por las narrativas sociales que históricamente lo han vinculado a identidades y prácticas consideradas fuera de la norma. A pesar de los avances científicos y la disponibilidad de tratamientos eficaces, persisten altos niveles de desinformación sobre sus formas de transmisión, lo que alimenta prejuicios, miedo y exclusión hacia las personas que viven con el virus (PVVIH). Este fenómeno se inscribe en una matriz cultural y política donde el cuerpo seropositivo, especialmente aquel que se identifica con disidencias sexo-genéricas, sigue siendo leído como una amenaza moral al orden dominante.

Frente a este escenario, surge la necesidad de tensionar los lenguajes visuales e institucionales con los que se ha narrado el VIH en el país. La presente investigación se sitúa desde una experiencia cuir y los procesos de resistencia colectiva que han configurado formas afectivas y políticas de habitar la diferencia, entendiendo que los imaginarios del VIH no solo se construyen desde la salud pública, sino también desde la cultura, el miedo y la memoria comunitaria.

Durante el desarrollo, el proyecto integró una metodología de carácter cualitativo basada en entrevistas en profundidad a personas que viven con VIH, construyendo una etnografía audiovisual que permitió identificar las emociones, tensiones y silencios que atraviesan sus vivencias.

A partir de estos testimonios se desarrolló una matriz de análisis por ejes temáticos (diagnóstico, estigma, cuerpo, apoyo y futuro) que orientó la construcción de un guion narrativo y la definición de los pilares conceptuales del proyecto.

El estudio resultó en una propuesta de diseño basada en nuevos medios, que explora cómo la interacción, el lenguaje audiovisual y el espacio pueden contribuir a la sensibilización social. La instalación, estructurada en dos etapas llamadas Herida y Cicatriz, utiliza pantallas, sensores y dispositivos espaciales para traducir las vivencias recogidas en un relato inmersivo que articula fragmentación, vulnerabilidad, contención y reconstrucción. Esta aproximación busca alejarse de los discursos patologizantes y de las representaciones estereotipadas, proponiendo un espacio afectivo donde las experiencias de PVVIH puedan ser comprendidas desde la dignidad y la complejidad que les han sido históricamente negadas.

Así, este proyecto no solo responde a una inquietud personal, sino a una necesidad social de visibilizar aquello que ha permanecido silenciado, habilitando nuevas formas de mirar y comprender el VIH desde el diseño, la colaboración y la resistencia cuir.

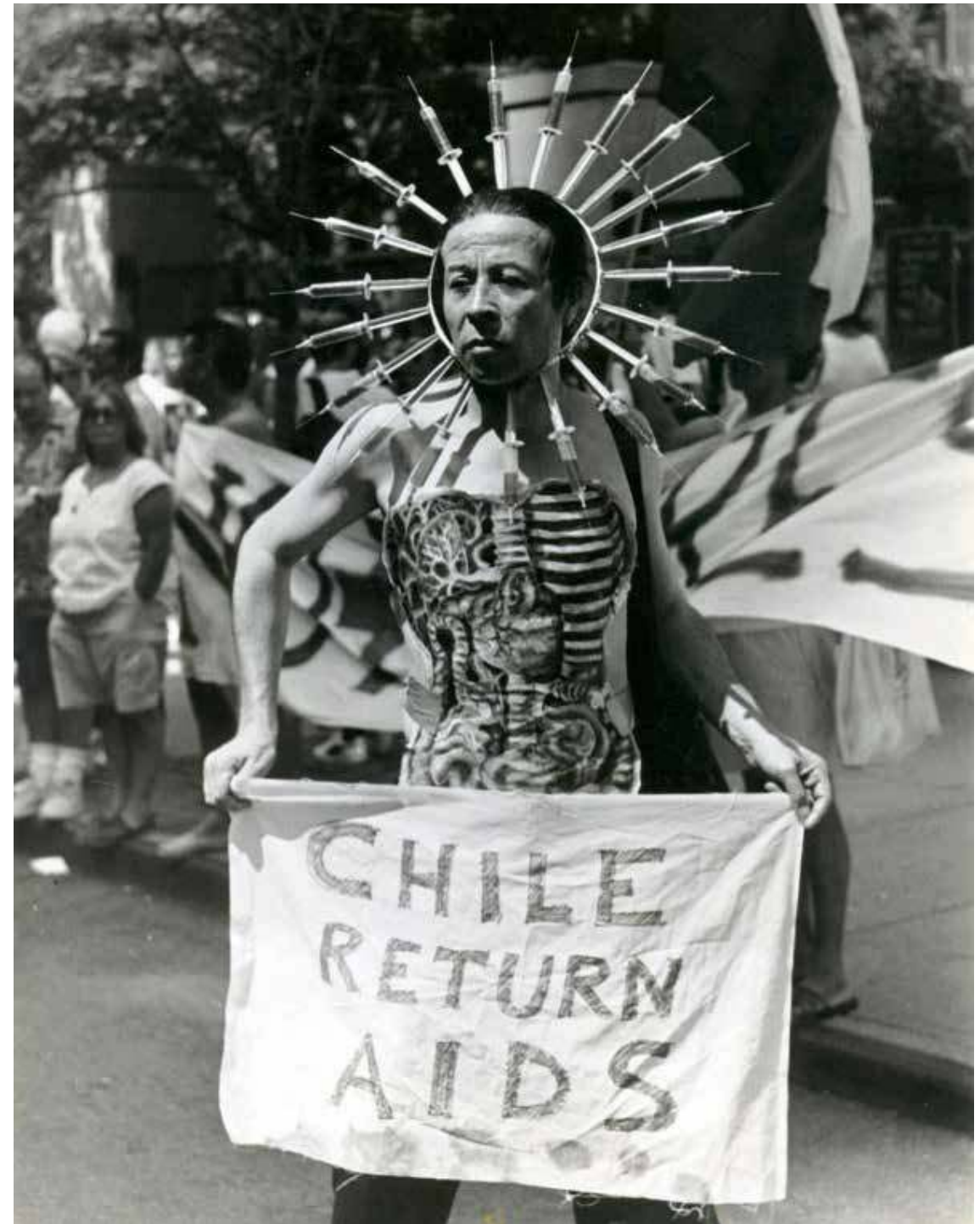


Figura 2. Alacranes en marcha. Gabriela Jara. 1994

MARCO TEÓRICO

VIH EN CHILE

Virus de la Inmunodeficiencia Humana

VIH, es un retrovirus que infecta las células del sistema inmunitario destruyendo o dañando sus funciones, lo cual lleva a una reducción de este, traduciéndose como inmunodeficiencia.

El sistema inmune se define como una Red compleja de células, tejidos, órganos y las sustancias que estos producen, que ayudan al cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades. (National Cancer Institute, s.f.)

El VIH ataca principalmente a las células T CD4 positivas y los macrófagos, ambos componentes clave del sistema inmunitario celular ya que al haber mayor presencia de estos se traduce de manera positiva en el sistema inmunitario, mientras que al haber una menor cantidad de células se presenta una mayor vulnerabilidad en el sistema inmune.

Se considera deficiente el sistema inmunitario al momento que pierde su capacidad de contrarrestar las infecciones y enfermedades, por lo cual, una persona que vive con VIH es mucho más vulnerable a una mayor cantidad de infecciones y cánceres. Las enfermedades asociadas a una inmunodeficiencia grave se pueden considerar como infecciones oportunistas ya que, se aprovechan de un sistema inmunitario debilitado. (UNAIDS, s.f.)

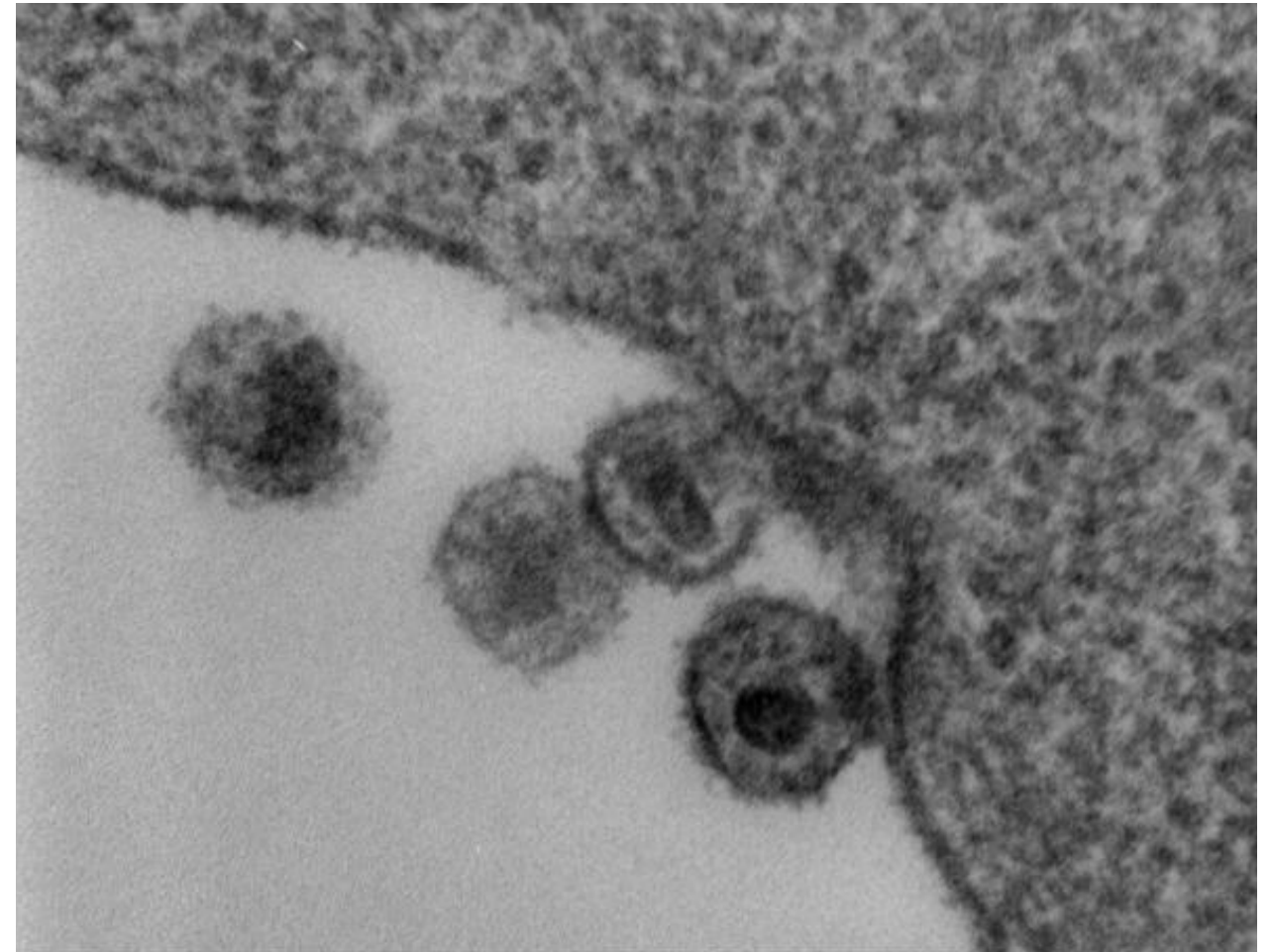


Figura 3. Células infectadas con VIH. NISENET. 2024

SIDA

Acrónimo para Síndrome De Inmunodeficiencia Adquirida es un término que se utiliza en las fases más avanzadas de la infección por VIH, se caracteriza por la aparición de alguno de los cánceres o infecciones oportunistas potencialmente mortales, las cuales se aprovechan de la debilidad del sistema inmune.

El SIDA fue una característica que definió los primeros años de la epidemia del VIH antes de que aparecieran los tratamientos antirretrovirales (TAR).

Al día de hoy, la mayoría de las personas que viven con VIH no presentan SIDA al haber un mayor uso de tratamiento con TAR.

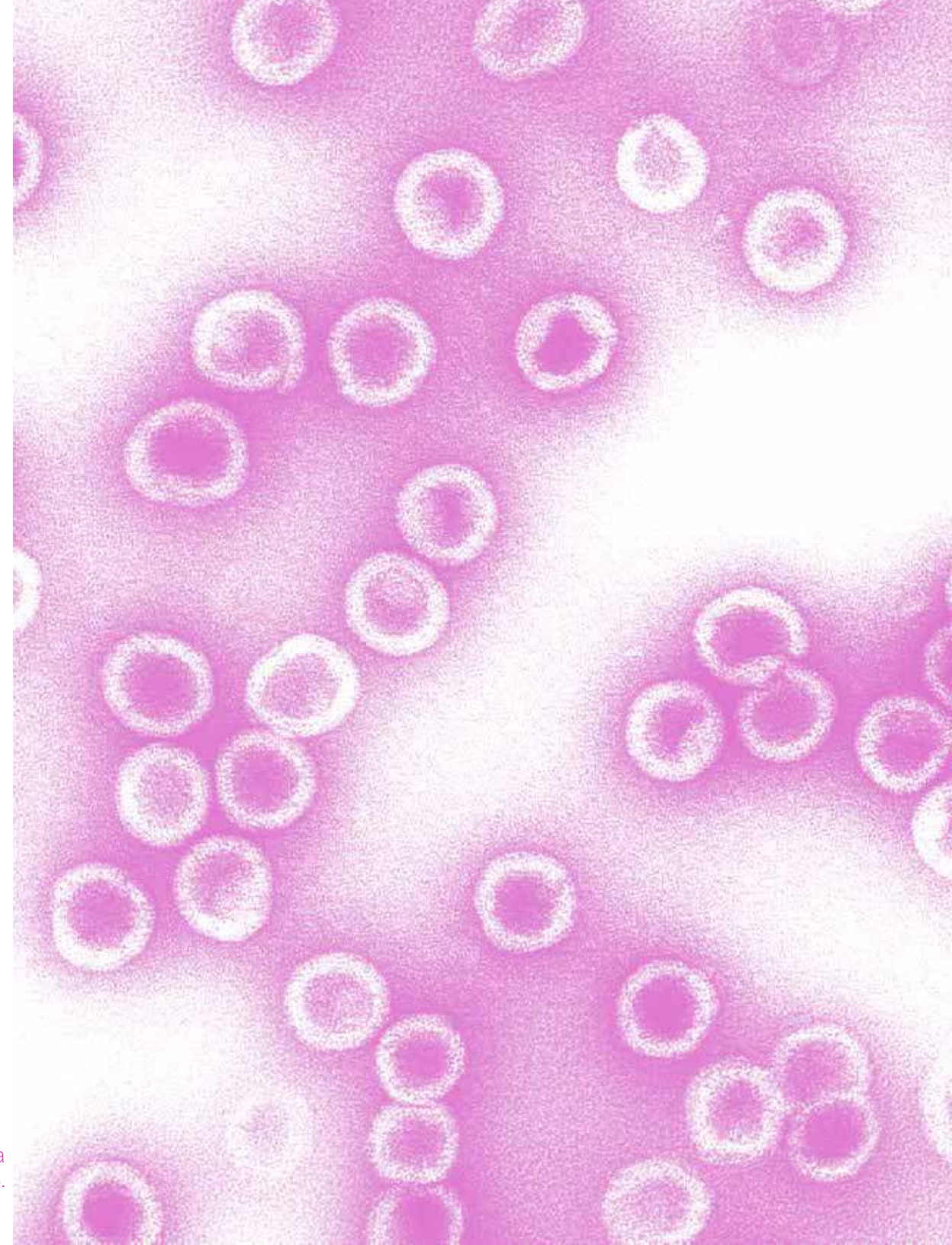
La probabilidad de que una persona sea diagnosticada una infección avanzada por el VIH, la cual se considera que se presenta en personas con un recuento de linfocitos T CD4 inferior a 200 copias y quienes tienen una enfermedad definitoria de SIDA, es mayor en personas con infección no diagnosticada por el virus, aquellas que tienen un diagnóstico tardío y en quienes nunca han seguido o han interrumpido su tratamiento TAR.

(OMS, s.f.)

INFECCIONES OPORTUNISTAS

- Tuberculosis
- Neumonía
- Hongos
- Toxoplasmosis
- Cáncer
- Sarcoma de Kaposi
- Meningitis
- Infecciones digestivas

Figura 4. Micrografía de electrones VIH en etapa madura, CDC/Dr. Edwin P. Ewing, Jr. 1985.



Transmisión del VIH

ITS:

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) se propagan principalmente por contacto sexual sin haber una barrera de protección, también algunas pueden transmitirse durante el parto natural y por medio de sangre o productos sanguíneos infectados, estas pueden ser provocadas por bacterias, virus o parásitos.
(OMS, s.f.)

El Virus de Inmunodeficiencia Humana se considera como una ITS al tener distintas maneras de transmisión, principalmente el traspaso de fluidos corporales como sangre, leche materna, semen y secreciones vaginales, también es posible la transmisión vía parto natural.

En la sociedad generalmente aún se encuentra una gran desinformación acerca de las maneras de transmisión del virus, lo cual solo aporta a la estigmatización y discriminación hacia PVVIH.

Existe posibilidad de transmisión:



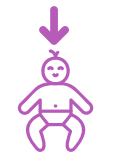
Contacto sexual sin protección



Contacto sanguíneo



Agujas usadas y no esterilizadas



Transmisión vertical: parto natural

No existe posibilidad de transmisión:



Abrazos



Besos



Sudor



Estornudos



Compartir utensilios



Picaduras de insecto

Lenguaje adecuado

Al momento de hablar de VIH y las personas que viven con el virus, es necesario informarse sobre distintas terminologías, tratamientos disponibles y tener una comunicación empática y respetuosa, de esta manera, evitamos que el estigma y la discriminación hacia PVVIH sigan aumentando y logramos combatir la desinformación que se encuentra en la sociedad general.

Terminologías:

Transmisión: causada por un agente infeccioso que sobrevive fuera del cuerpo humano muy pocos minutos, lo que hace prácticamente imposible que infecte a otras personas a través del medio ambiente, agua, alimentos o animales portadores. Por otro lado cumplen todo su ciclo vital (nacen, se reproducen y mueren) dentro del cuerpo humano.

Contagio: Es aquella causada por un agente infeccioso que puede sobrevivir fuera del cuerpo humano, es decir, en el medio ambiente (agua, aire, alimentos, etc...) o dentro de un animal portador durante períodos de tiempo prolongados, y que otro individuo puede adquirir a través del contacto con cualquiera de estos medios. Este agente infeccioso contagioso cumple parte de su ciclo vital fuera del cuerpo humano.

(Apoyo Positivo, s.f.)

Seropositivo: Persona que tiene anticuerpos del VIH.

Seronegativo: Persona que no tiene anticuerpos del VIH.

Pareja serodiscordante: Pareja la cual una persona es seropositiva y otra seronegativa.

Serovisible: Persona que tiene anticuerpos del VIH y es abierta con su diagnóstico públicamente.

Terapias antirretrovirales TAR:

Consiste en un tratamiento en formato de pastilla que se toma diariamente para mantener el nivel del virus en la sangre como indetectable. El año 2019 la OMS confirmó que si una PVVIH mantiene un nivel indetectable, no transmite el virus.

(OMS, 2019)

INDETECTABLE = *INTRANSMISIBLE*

Tratamientos disponibles

TAR: Combinación de medicamentos utilizados para tratar la infección por VIH. Ayuda a reducir la carga viral a niveles indetectables, lo que mejora la salud de la persona y previene la transmisión.

PreP: Uso de medicamentos antirretrovirales por personas sin el virus de VIH para reducir su riesgo de contraer la infección. En Chile, la implementación del PreP en el sistema público se inició el 2019.

PEP: Uso de medicamentos antirretrovirales después de una posible exposición al VIH para prevenir la infección. La norma para su uso en casos de violencia sexual fue actualizada e incluida en el plan GES, pero sigue siendo poco accesible para la mayoría de los chilenos por su alto costo.
(Ferrer Campos, 2024)



Contexto nacional

A pesar de los avances médicos en las últimas cuatro décadas a nivel mundial, los cuales han disminuido exponencialmente el riesgo y los casos de transmisión de VIH, la situación en Latinoamérica y, específicamente en Chile, ha sido diferente ya que se ha reportado como el país con mayor incidencia del continente de infecciones por VIH en la última década.

El artículo “Situación epidemiológica de VIH a nivel global y nacional: Puesta al día” publicado por el Comité Consultivo de VIH de la Sociedad Chilena de Infectología menciona que: “A diferencia del resto del mundo, América Latina presenta una tendencia de alza en las nuevas infecciones y Chile registra un aumento de 35% en nuevos casos durante los últimos 10 años”. (Blamey et al., 2024)

Se estima que 83.000 personas vivían con VIH hasta el año 2022, siendo las poblaciones clave más afectadas las personas transgénero y hombres que tienen sexo con hombres (HSH), lo cual se calcula como el 93% de los casos totales de PVVIH en el país. (Blamey et al., 2024)

Estos datos abren distintas preguntas acerca de cómo y por qué ha fallado el sistema de salud en Chile en respecto al VIH y la poca eficacia que ha habido para prevenir su transmisión.

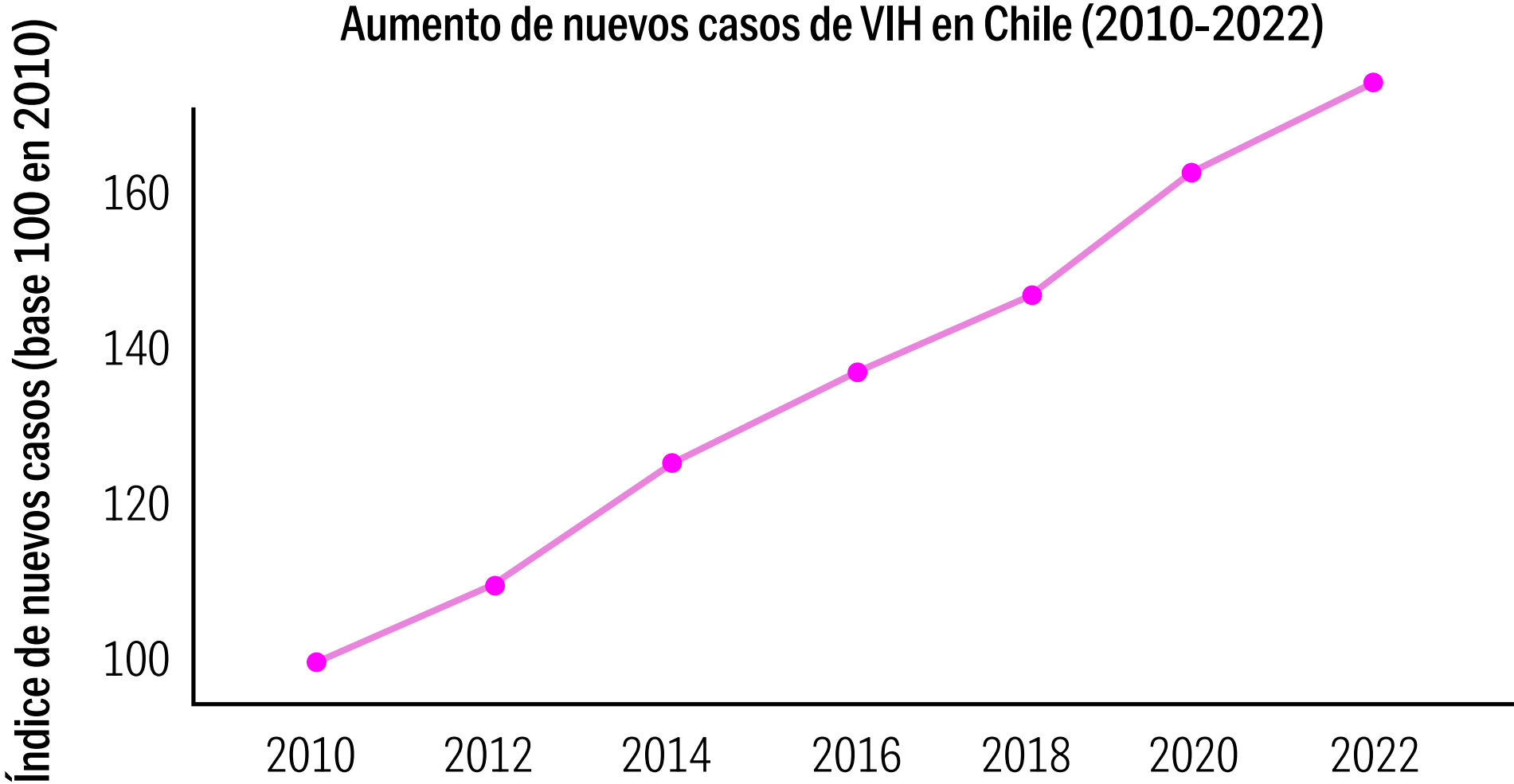


Figura 5. Aumento de casos. Elaboración propia.

Políticas de prevención

En Chile la falta de políticas de prevención es el principal factor del mal manejo de la epidemia del VIH en nuestro país. Entre el año 2010 y 2020, el gobierno de Chile invirtió solamente 15 millones de dólares en la prevención, contrario a los 686 millones de dólares invertidos en tratamientos para personas que ya viven con el virus. Gracias a este manejo, una significativa cantidad de pacientes con VIH ha podido lograr una supresión virológica, pero no se ha podido reducir la curva de nuevas infecciones.

(Ferrer Campos, 2024)

Hay un déficit en nuestro país cuando se trata de educación sexual integral (ESI), no existe un acceso amplio para hacerse tests de diagnóstico, la disponibilidad de tratamientos como PreP es baja y no han habido campañas comunicacionales efectivas en su prevención, estos factores, que son esenciales para prevenir nuevos casos según el plan 2030 de ONUSIDA para erradicar la epidemia del VIH, afectan exponencialmente el crecimiento de casos positivos en nuestro país.

Inversión en VIH en Chile (2010-2020)

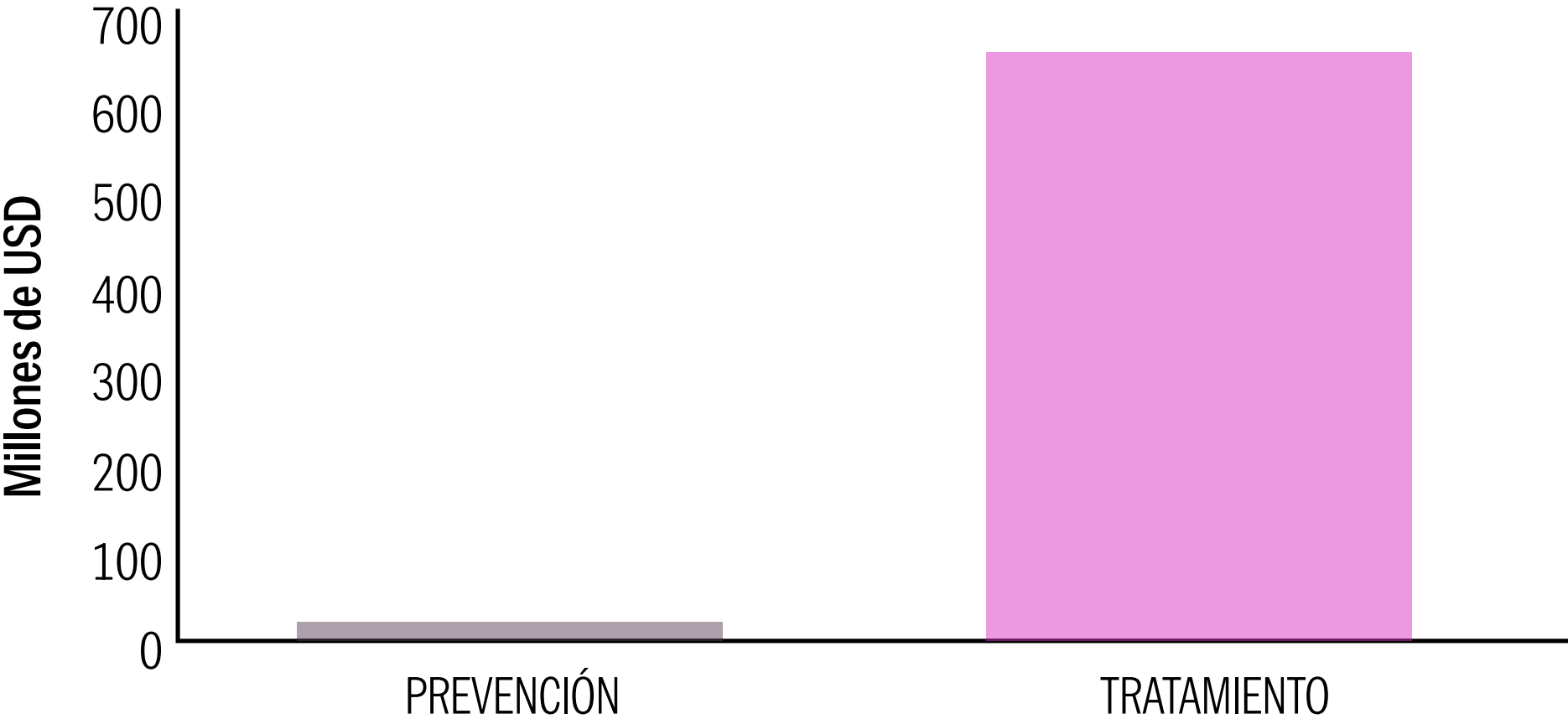


Figura 6. Inversión en Chile. Elaboración propia.

Fallas específicas

Poca investigación:

El artículo 4 de la ley 19.779 establece que el Estado tiene la obligación de impulsar la investigación científica sobre el VIH para promover prevención, tratamiento y cura. Pero cuando la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) fue cuestionada acerca de la cantidad de proyectos relacionados con el virus en los últimos 40 años, se reportó un total de 16 investigaciones entre el año 2000 y el 2022, un número que se puede considerar preocupante y desalentador. Se invirtió un total de \$727.835.000 en un período de 21 años entre 16 grupos de investigadores, lo cual se puede promediar como una inversión de \$2.360.716 por grupo de investigación anualmente. (Ferrer Campos, 2024)

Legislación desactualizada y centralizada:

La misma ley mencionada anteriormente, establece que el test de VIH es confidencial y voluntario con consentimiento escrito, si bien busca proteger la identidad de las personas, esta acción se ha convertido en una barrera para el diagnóstico temprano, el decreto 158/04 por el MINSAL exige que todos los casos diagnosticados en el país sean confirmados en un único laboratorio en el Instituto de Salud Pública (ISP) en Santiago. Este sistema centralizado ha demostrado ser ineficiente y causa retrasos en la notificación de diagnóstico para personas que viven en otras regiones del país, lo que a su vez retrasa el tratamiento ya que solo los casos confirmados por el MINSAL pueden recibir terapia. (Ferrer Campos, 2024)

La auditoría de la Contraloría General reportó que 15.835 personas confirmadas como portadoras de VIH entre 2010 y 2019 no fueron notificadas. Un número no menor, preocupante y que demuestra una falla grave dentro del sistema de salud en Chile. (Contraloría General de la República de Chile, 2021)

Discriminación y estigma:

La Organización Mundial de la Salud afirma que si no se combaten el estigma y la discriminación relacionados con el VIH, el mundo no alcanzará el objetivo de poner fin al sida como amenaza para la salud pública en 2030.

En una entrevista realizada a 5 HSH y 5 mujeres trans seropositivas en Chile, dictada por Alessandra Scher, se concluye que el estigma y discriminación es un tema muy prevalente en la sociedad Chilena, influyendo directamente en las vidas de las personas entrevistadas, manifestándose en una manera de marginación, creando barreras sociales y estructurales, además de poner en riesgo a las personas frente al virus por una falta de oportunidades. (Scher, 2016)

A pesar de los avances en respecto a diversidades sexuales en los últimos años, la comunidad LGBTIQ+ sigue siendo discriminada y estigmatizada, la característica conservadora y machista de la sociedad Chilena, además de una falta de información sobre la diversidad sexual, perpetua esta trato y marginalización de los que no concuerdan con las pautas sociales sobre relaciones sexuales y normas de género estrictas.

ESTIGMA HACIA PVVIH

Imaginarios sociales

Estigma social

Se refiere a individuos que tienen algún atributo no aceptado por la sociedad, lo que por consecuencia lleva a una categorización, discriminación y exclusión de la persona que los diferencia del resto.

Estigma internalizado

Se relaciona con el deterioro del autoconcepto y la autoestima, basándose en la inferencia o percepción que tiene el individuo frente a las conductas producidas por el estigma social.

(Lombó Fragueiro, C. 2021).

Entre sus efectos negativos se encuentra la baja autoestima, un sentimiento de desvalorización y la depresión.

(Barrientos et al., 2012).

Estigma y discriminación

En Chile, es común que las disidencias sexo-genéricas tengan vivencias relacionadas con estos conceptos, según MOVILH el año 2024 a partir de la Segunda Encuesta Nacional sobre Diversidades y Discriminación, se revelaron datos preocupantes que afectan a personas LGBTIQ+

**80,9% DE LA POBLACIÓN LGBTIQ+
HA RECIBIDO DISCRIMINACIÓN EN CHILE.**

entre estos reportes se encuentran burlas o insultos, obstáculos para expresarse libremente, agresiones psicológicas, amenazas, agresiones físicas, obstáculos para acceder a servicios o productos ofrecidos por instituciones públicas y privadas y también abuso sexual.

El panorama no es muy alentador al momento de analizar los datos actuales, pero al mismo tiempo se puede ver una resistencia de parte de la comunidad LGBTIQ+, ya que en la encuesta se reportó que las personas cada vez tienen menos miedo de visibilizar su orientación sexual o identidad de género.

El cuerpo del SIDA y representación en medios de comunicación

Los autores Augusto Obando y Olga Vasquez describen la construcción social del “cuerpo del SIDA”, la cual se vió por primera vez con la aparición del primer paciente positivo por VIH en Chile en el año 1984, el cual fue presentado como un sujeto particular de peligro asociado a la pandemia global, los autores mencionan que aquellos que sufren del estigma social no logran incluirse en el modelo impuesto en la sociedad, su ser es preso por una construcción cultural que lo limita. (Obando Et al., 2020).

La construcción del estigma hacia PVVIH fue generada ante la novedad del virus, por la falta de información acerca del tema a partir de un discurso social producido por múltiples protagonistas como la medicina, los medios de comunicación, los gobiernos, las entidades no gubernamentales, individuos y colectividades.

Luego del primer caso de un paciente en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, en el año 1981, ante la preocupación colectiva y la angustia de la sociedad acerca de este nuevo virus, los medios comunicacionales se dedicaron a reproducir y agudizar las alarmas emitidas por los sistemas de salud, generando un contenido poco informado, compuesto de un lenguaje estereotipado y con prejuicio, actuar que logró llegar a medios de comunicación en todo el mundo y, Chile no fue la excepción.

El estigma en nuestro país en un principio se basaba en una idea de que quienes “sufrían” de este nuevo virus no lograba encajar en el modelo impuesto socialmente de un país que se consideraba como “rico, moderno y poderoso”, para la sociedad un cuerpo que se consideraba enfermo y contagioso, el cual era asociado a conductas inapropiadas como la sodomía, no encajaba con las percepciones que habían frente a lo que se consideraba como “normal”.



Figura 7. Grupo manifestándose en la parada del orgullo en Nueva York. 1983. Mario Suriani.



Figura 8. Noticia publicada tras la muerte del primer caso de SIDA en Chile. La Tercera. 1984.

Con la aparición del primer caso de SIDA en Chile el año 1984, medios comunicacionales como La Tercera y Las Últimas Noticias agudizaron las alarmas de los sistemas de salud y siguieron un patrón similar a los medios de comunicación en el resto del mundo, mezclando enunciados científicos con estereotipos y prejuicios. La utilización constante de mensajes cargados de juicios de valor como describir el SIDA como “Cáncer gay” junto a una imagen de la espalda del primer sujeto con Sarcoma de Kaposi lograron convertir la problemática en un símbolo de especularización y estigma. Identificando al cuerpo seropositivo como alguien que debiera ser “evitado y reconocido”.

(Obando Et al., 2020)

La prensa de la época, la cual se encontraba afín de un régimen militar, estuvo marcada por la falta de información verídica frente al virus, sus formas de transmisión y manifestación en las personas que lo portaban, lo cual produjo la difusión de información tendenciosa, que relacionaba el virus con grupos y prácticas mal vistas: Homosexuales, drogadictos y hemofílicos.

(Moggia, 2022).



Figura 8,9. Arriba: titular La Tercera. Abajo: titular Las Últimas Noticias. 1984.

PASADO Y PRESENTE

Historia LGBTIQ+ en Chile

Para entender la situación actual frente a la discriminación hacia disidencias sexo-genéricas es necesario hacer un recorrido y un análisis de la historia en nuestro país, al ser una problemática que ha ido mutando a lo largo de las últimas décadas y, que ha sido influenciada por distintos factores externos.

Raíces y la situación antes de la dictadura:

Con la colonización y la imposición de la iglesia cristiana en el territorio se censuraron ideologías al momento de transferir la moral cristiana al asociar la corporalidad a la genitalidad y verlo en oposición al espíritu o alma, considerando lo “impuro” como originado en el cuerpo.

La iglesia comenzó a utilizar el concepto de “sodomía” para normar las corporalidades y definir lo que era “moral” e “inmoral”, lo cual llevó a la penalización de la sodomía por parte de los estados latinoamericanos como forma de castigo hacia las personas que realizaban prácticas contra la moral eclesiástica, la cual principalmente se centró en homosexualidades masculinas.

A medida que la historia avanza el panorama no mejora, entre la década de los años 30 y 70, en Chile el Servicio Nacional de Salud y la Brigada de Delitos Sexuales definieron a las disidencias sexo-genéricas como “problemas de salud moral y social” y “desviaciones sociales”.

La implementación de leyes discriminatorias por parte del estado como el artículo 373: “ultrajes a las buenas costumbres” que se utilizaban en contra del travestismo y el trabajo sexual callejero, fueron aportando y alimentando a la discriminación y estigma frente a la comunidad LGBTIQ+ en el país. (Carvajal, 2019)

Discriminación y violencia en la dictadura de Augusto Pinochet

Actualmente existe una discusión acerca de si en la dictadura del régimen militar entre los años 1973 y 1990 hubo casos de persecución y represión hacia personas disidentes ya que no existen registros historiográficos que lo documenten, pero sí hay evidencia en la prensa y testimonios de personas que afirman haber vivido violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra la población LGBTIQ+.

En el libro “La Manzana de Adán” de la fotógrafa Paz Errázuriz y la periodista Claudia Donoso (1990), que reúne testimonios e imágenes de travestis recolectadas entre 1984 y 1988, se demuestra la detención de un grupo de travestis y hombres homosexuales en Valparaíso al interior de un barco que se encontraba varado y algunas detenciones de travestis por parte de fuerzas militares en un prostíbulo.

Durante la dictadura se mantuvieron las prácticas discriminatorias existentes anteriormente a través de formas de acoso policial y marcos legales represivos, penalizando el travestismo, la prostitución callejera y aquellos que eran considerados como “raros” a través de detenciones realizadas durante redadas y rondas especialmente antes del toque de queda.

(Carvajal, 2019).

El discurso militarista y patriarcal que se vió de manera dominante en el país durante la dictadura significó un refuerzo de ideologías conservadoras y heteronormativas a través de una exacerbación de las identidades viriles y la defensa de la ideología de una familia heterosexual y patriarcal, lo cual justificaba la discriminación hacia la comunidad LGBTQI+ tanto del estado como de la sociedad civil.

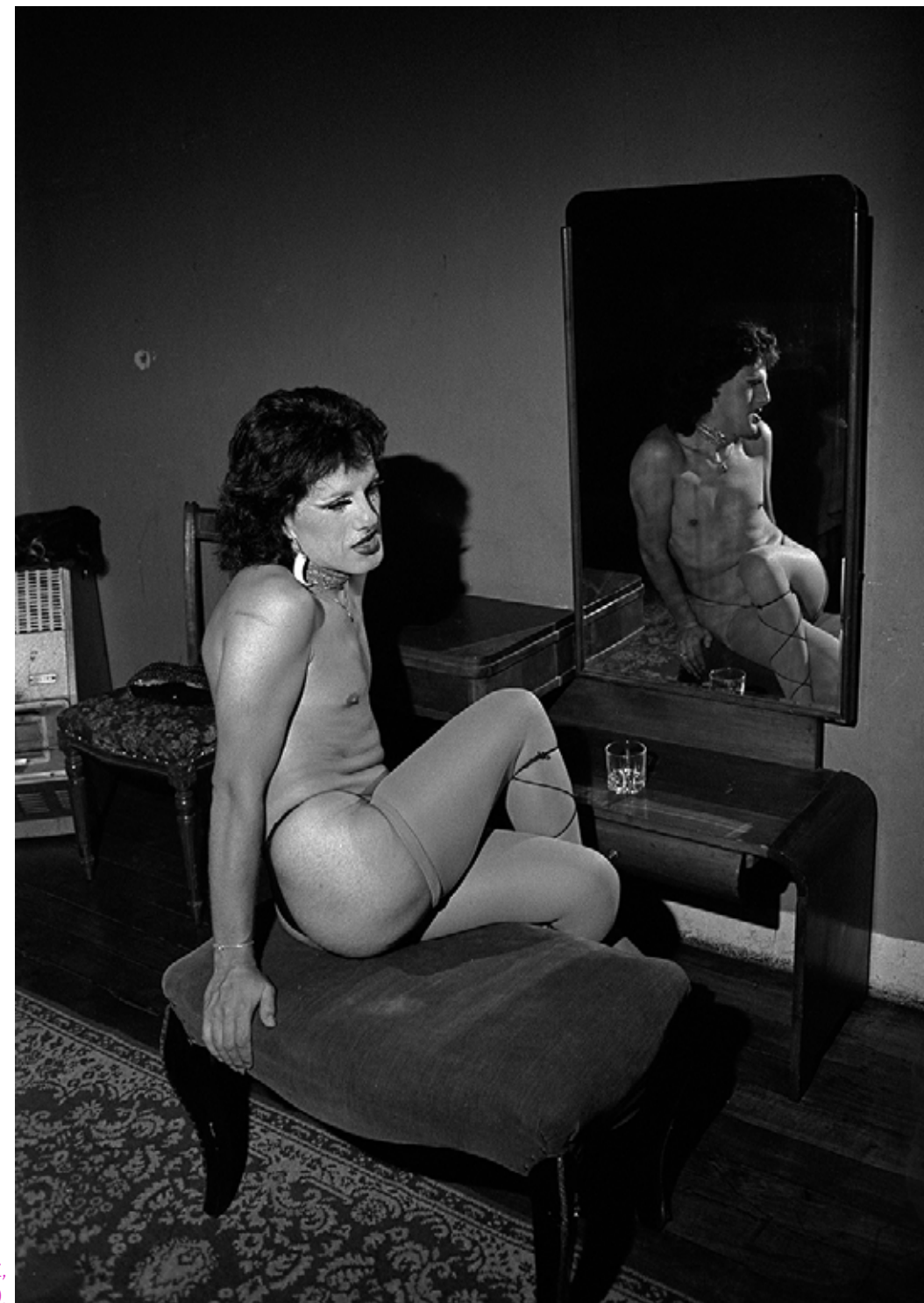


Figura 10. “La manzana de adán”. Paz Errázuriz, Claudia Donoso. 1990.

Estigma y discriminación en la transición democrática

Con el fin de la dictadura en Chile, la violencia sistemática y social hacia las disidencias sexo-genéricas seguían muy presentes ya que, a pesar del comienzo de la democracia, en el país persistieron los discursos heteronormados y patriarcales como consecuencia del impacto en la percepción social gracias al régimen militar. La penalización de la sodomía y las ofensas al pudor, la moral y las buenas costumbres siguieron vigentes, lo cual dio el pie a la continuación de la criminalización y persecución hacia la comunidad LGBTIQ+ en los años 90, resultando en violencia policial, negligencia estatal e impunidad hacia los crímenes de odio, afectando principalmente a personas trans.

Con el comienzo de este nuevo período en Chile, surgieron diferentes problemáticas planteadas por los grupos LGBTIQ+ ya que, aún no existía una penalización o políticas antidiscriminatorias, la violencia y criminalización social e institucional seguía presente de una manera muy fuerte y el contexto en los años 90 a partir de la crisis del VIH/SIDA se dio de una manera agresiva para estos grupos, además se vio una reaparición de discursos patologizantes y estigmatizantes por parte de los medios y fuentes médicas.

El autor Oscar Contardo el año 2011 en su libro “Raro: Una historia gay en Chile”, cuenta que para los últimos sectores mencionados, la homosexualidad se ligaba a la rebeldía, lujuria e Infecciones de Transmisión Sexual, específicamente al VIH/SIDA, la cual mundialmente era reconocida como el “cáncer gay”. En la época las autoridades del país asociaban el virus a grupos de riesgo como prostitutas y homosexuales, dejando de lado la posibilidad de transmisión hacia otra categorización de personas, con la finalidad de evitar un pánico en la sociedad por la falta de investigación sobre el virus.



Figura 11. Movimiento de liberación homosexual en marcha por los derechos humanos. Iris Colil, 1992.

El panorama a principios del siglo XXI

A comienzos del siglo XXI la discriminación continúa siendo una problemática presente diariamente en la vida de las personas disidentes sexo-genéricas, la derogación de la ley 19.617, que penalizaba las relaciones sexuales consentidas en privado entre hombres mayores de 18 años, significó un progreso pero aún hacía falta un mayor esfuerzo por parte del estado para evitar la discriminación, por lo que algunas organizaciones, entre ellas el MOVILH, comenzaron a movilizarse y a demandar la protección de la comunidad LGBTIQ+.

Si bien se podría interpretar que el panorama en la época se encontraba mejor, aún existía una persistencia frente al estigma social que había hacia la homosexualidad, en una encuesta realizada por el diario La Nación el año 2000 los resultados arrojaron que el 55% de la población chilena no estaba de acuerdo con que aparecieran personajes homosexuales en la televisión por “dar un mal ejemplo” y un 43,6% opinaba que la homosexualidad debería haberse mantenido prohibida por ser una práctica que va “en contra de la naturaleza”. (Garrido & Barrientos, 2018)

La lucha y visibilidad que buscaba el MOVILH a principios del 2000 intensificaron los debates sobre la discriminación y en este punto ya no solo estaba cerrado hacia los homosexuales, sino que el debate comenzó a abrirse y a incluir a minorías étnicas, población migrante, personas con discapacidad y personas que viven con VIH, especialmente luego de la primera marcha por el orgullo gay (2001), la cual intensificó las discusiones e impulsó el planteamiento de una ley que estableciera medidas contra la discriminación en el año 2005 la cual luego se convertiría en la Ley Zamudio en el año 2012.



Figura 12. Marcha del orgullo. MUMS. 2004.

Presente

La situación que aborda la discriminación y el estigma frente a PVVIH en Chile desde el año 2010 en adelante sigue siendo un tema muy relevante al seguir habiendo obstáculos significativos, si bien el estado ha impulsado algunas estrategias y políticas para disminuir los casos de transmisión y la discriminación, aún se encuentran fallas dentro del sistema que afectan directamente a personas que viven con el virus y la comunidad LGBTIQ+.

En Chile se ha visto un incremento en nuevos casos por VIH desde el año 2010 que difiere de las tendencias mundiales, algunas de las acciones que se han realizado por parte del estado son la implementación universal de la terapia TAR la cual se encuentra respaldada por la Ley de Garantías Explícitas en Salud (GES) y que según un informe del año 2022,

se estimó que el 74% de las PVVIH estaban en tratamiento, herramienta que se ha demostrado eficaz para evitar la transmisión a terceros. El año 2019 se implementó el programa de Profilaxis Pre Expositiva (PreP) en el sistema público pero se ha reportado que la oferta es escasa en el país. (Blamey et al., 2024)

Si bien estas acciones por parte del estado significan un progreso frente a la prevención del VIH, sigue habiendo una falta de políticas eficaces, en la última década se reportó una baja inversión de prevención en comparación con la inversión que se ha destinado al tratamiento, lo cual contribuye al aumento de casos.



CAMPAÑAS COMUNICACIONALES

Cómo se ha abordado en el país

El artículo 2 de la ley 19.766 establece que el ministerio de salud deberá desarrollar prácticas de prevención y educación dirigidas al público general, con énfasis a los grupos más vulnerables.

Según ONUSIDA el año 2021, uno de los desafíos más importantes para detener la epidemia del VIH/SIDA es a través de la deconstrucción del estigma hacia las personas que viven con el virus, una de las recomendaciones dirigidas a todos los gobiernos pide:

“Reforzar el papel del sector educativo como vía de acceso a la prevención, la detección y el tratamiento del VIH, y acabar con la estigmatización y la discriminación, además de abordar los factores sociales y estructurales que perpetúan la desigualdad y aumentan el riesgo de contraer el VIH”. (UNAIDS, 2021)

A partir del actual plan que se planteó por parte ONUSIDA para lograr erradicar mundialmente la epidemia del VIH, para el año 2030 se espera que menos del 10% de las personas que viven con el virus experimenta estigma y discriminación. Actualmente existe una herramienta diseñada y respaldada por la ONU para medir los niveles de estigma que hay en el mundo de manera controlada, pero lamentablemente Chile no ha comenzado el proceso de implementación de este sistema, siendo uno de los pocos países del continente sin una estimación oficial.

Se reporta que el gobierno de nuestro país realizó 21 campañas de prevención del VIH entre el año 1991 y el 2022, hay algunos años en los que hay ausencia de campañas preventivas y, en los años que sí se han realizado, no duran mucho más de 4 meses.

La falta de campañas efectivas y de larga duración deja un mensaje peligroso a la población: que el VIH no es un problema relevante a prevenir. Es a partir de estos datos que se puede concluir que las campañas preventivas han sido escasas y han recibido poca atención. (Ferrer Campos, 2024)

“ MENOS DEL 10% DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIRUS DEBERÍAN EXPERIMENTAR ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN PARA EL AÑO 2030 ”

Análisis de campañas

A continuación se presenta un análisis de 8 campañas gubernamentales preventivas del VIH/SIDA en las últimas dos décadas, enfocado en realizar una descripción general de cada campaña y su eficacia al momento de su masificación, basado en investigaciones que analizaron sus propósitos, público y su rol en la historia, además tomando en cuenta su contexto histórico para comprender de mejor manera el impacto que generaron y su eficacia comunicacional de manera crítica:

Tú decides (2001):



Figura 13. Campaña preventiva VIH. MINSAL. 2001.

Descripción:

Esta campaña se enfocó en exponer las maneras de prevenir el VIH, con llamados a la abstinencia sexual, la fidelidad y el uso correcto del preservativo. Mostrando acciones cotidianas entre parejas heterosexuales.

Efectividad comunicacional:

La campaña tiene un mensaje claro al momento de informar sobre la prevención, pero si bien los llamados eran lo considerado correcto para la época, invitar al espectador a practicar la abstinencia sexual y la fidelidad son mensajes que actualmente no son considerados métodos de prevención adecuados. La falta de diversidad en la campaña demuestra la invisibilización que aún existía hacia la comunidad LGBTIQ+ en el país.

Frente al SIDA, yo tengo una postura (2004):



Figura 14. Campaña preventiva VIH. MINSAL. 2004.

Descripción:

Se elude al uso del preservativo para prevenir la transmisión, utilizando a figuras públicas de la televisión nacional de la época para que el mensaje sea más cercano para la población. Su objetivo fue confrontar a la población frente a la incongruencia de su conducta, llamado que se construyó sobre el supuesto de que la población ya manejaba información sobre el VIH, pero no existían estudios que respaldaran este punto.

Efectividad comunicacional:

Si bien hay diferentes posturas frente a la efectividad comunicacional, su enfoque confrontacional y culpabilizador no logró el cambio de conductas deseado y la falta de investigación previa sobre el real conocimiento de la población representó una deficiencia mediática en el diseño de la campaña. Cabe destacar que se ve un progreso por haber sido un mensaje “atrevido” para la época, alejándose de los mensajes de instituciones conservadoras quienes en su momento consideraron la campaña como “antimoral” al mostrar la sexualidad de manera tan explícita, por otra parte, organizaciones LGBTIQ+ criticaron el mensaje en el borde inferior al asumir que no hay riesgo de transmisión para quienes tienen una pareja sexual exclusiva. (Ferrer et al., 2009)

La consejería es un derecho (2008):



Figura 15. Campaña preventiva VIH. MINSAL. 2008.

Descripción:

Se plantea a la población la posibilidad de buscar apoyo por parte del ministerio, introduciendo públicamente la consejería. Su objetivo principal fue dar a conocer a la población chilena los medios de apoyo en torno al VIH/SIDA, para así aclarar dudas y brindar información a quienes lo necesitaran.

Efectividad comunicacional:

Si bien las fuentes investigadas no mencionan la campaña de este año, basándose en los análisis previos y el contexto en el cual se realizó esta, se podría considerar que el mensaje se transmite de buena manera, generando mayor confianza en la población al momento de buscar ayuda.

Para prevenir el SIDA puedes decidir (2009):



Figura 16. Campaña preventiva VIH.
MINSAL, 2009.

Descripción:

Se enfocó en mostrar métodos de prevención recomendados en la época, buscando llegar a todo el público, el ministro Álvaro Erazo afirmó que la campaña apunta a incentivar la realización del diagnóstico del VIH y se buscó evidenciar los tratamientos y exámenes garantizados por el AUGE. (EMOL, 2009)

Efectividad comunicacional:

Tiene un mensaje claro y enfocado, la mención del plan AUGE por primera vez fue algo importante para mostrar al público. un estudio de la BCN estima que la mayoría de las personas que recordaron la campaña la describieron como “informativa, educativa, directa y cercana”. (Lampert, 2019)

Quien tiene SIDA. Desde ahora, tú
tendrás el sida en mente (2010):



Figura 17. Campaña preventiva VIH.
MINSAL. 2010.

Descripción:

Campaña preventiva que consistía de una serie de videos y una página web informativa, se utilizó un lenguaje y visualidad confusa y poco seria buscando transmitir un mensaje en base al humor, también fue duramente criticada por enfocarse solo en el SIDA y no en el VIH. Se consideró que ignoraba a las personas homosexuales o que daba poco énfasis en el uso del preservativo.

Efectividad comunicacional:

La campaña fue inefectiva, el mensaje es ambiguo, el lenguaje utilizado es erróneo. Por parte de la opinión pública, oposición y oficialismo (excluyendo a MINSAL) fue calificada como “ineficaz, mala, superficial”. La decisión de evitar temas “valóricos” comprometió la efectividad del mensaje al no abordar de forma adecuada los factores de riesgo y los grupos vulnerables. (Masarelli V, 2010)

El VIH no mata, tu miedo al examen sí (2012):



Figura 18. Campaña preventiva VIH. MINSAL. 2012.

Descripción:

Busca acabar con el miedo colectivo frente al examen de VIH, utiliza un lenguaje claro y hace un llamado a testearse para obtener un diagnóstico a tiempo.

Efectividad comunicacional:

A partir de este punto comienza a haber un lenguaje adecuado al momento de hablar del virus, además, es primera vez que el mensaje es frente al VIH y no al SIDA, pero se sigue haciendo un llamado a la abstinencia como método de prevención. Si bien no se encontraron datos que hablen sobre su impacto en la población, se puede apreciar el intento de desvincular el VIH de la fatalidad y enfatizar la importancia de la detección temprana del virus.

VIH/SIDA, mientras más lo ignoramos, más fuerte se hace (2017):



Figura 19. Campaña preventiva VIH. MINSAL. 2017.

Descripción:

Esta campaña intenta generar conciencia a la población acerca del virus, buscando reposicionar la importancia del VIH/SIDA como una problemática de salud pública relevante y aludiendo a la prevención con preservativo mencionando también otras ITS. Fue la primera campaña en incluir una mayor diversidad de cuerpos, expresiones de género y etnias. Contó con la participación de diversas mesas de la sociedad civil, incluyendo la Mesa Nacional de Pueblos Indígenas en VIH/SIDA, Derechos Humanos y Salud. (MINSAL, 2019)

Efectividad comunicacional:

El mensaje es directo y se logra comprender de buena manera, el hecho de mencionar otras ITS es un aspecto positivo y se ve una diversidad de personas en los carteles, desde inmigrantes, pueblos originarios y corporalidades disidentes, ampliando su público general. Se valoró su enfoque inclusivo y la participación de la sociedad civil. (MINSAL, 2017)

Una de estas personas puede tener VIH, y tienes 10 segundos para descubrirlo (2019):



Figura 20. Campaña preventiva VIH. MINSAL. 2019.

Descripción:

El ministerio de salud quiso realizar una campaña con el objetivo de “aumentar la pesquisa” según el ministro Emilio Santelices, ya que se reportaba que las campañas realizadas durante los últimos 10 años no habían tenido impacto en disminuir las tasas de contagio o en aumentar la cantidad de tests que se practican. Fue llamada como “la campaña del terror” y llegó al punto de que la Corte Suprema tuvo que acoger un recurso de protección contra el MINSAL por criminalizar a las PVVIH.

Efectividad comunicacional:

La campaña no tuvo una buena recepción por parte del público y distintas organizaciones, fundaciones como IGUALES criticaron la campaña como “un error”, el activista Victor Robles sostuvo que la campaña abusa con rostros de personas, planteando un terrorífico desafío y, el Movimiento por la diversidad sexual (MUMS) aseguró que el ministerio seguía sin encontrar el rumbo. (Ferrer, 2018)

DISEÑO Y NUEVOS MEDIOS

Rol de la disciplina

Es importante hablar del rol del diseño como medio comunicacional para abordar problemáticas interdisciplinarias y analizar el rol del diseñador de una manera tanto ética como funcional.

La disciplina del diseño tiene un rol consciente socialmente en la transformación y la construcción de la cultura material, con la misión de promover un mensaje responsable y respetuoso con el entorno y el público al que busca llegar, por lo que al momento de tratar la temática del estigma hacia las personas que viven con VIH, el diseño podría llegar a tomar un rol importante para lograr visibilizar y/o cambiar una percepción social frente al problema.

Al momento de diseñar, es importante centrarse en el usuario y sus necesidades, hay que realizar un estudio previo de la problemática para entender y comprender de buena manera qué es lo que hay que realizar para cumplir con la necesidad del usuario, de esta manera, el medio en el que se quiere comunicar logra ser efectivo y genera un impacto en la percepción del receptor.

Se propone abordar el diseño desde una mirada etnográfica, la cual se destaca por lograr entender al usuario desde su propia experiencia personal. La etnografía, según Guber (2001), busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de los sujetos sociales para entender las prácticas y sus motivos, en una descripción e interpretación que sea fiel a los sujetos, por lo que una investigación de este tipo junto con la disciplina del diseño sería pertinente al momento de formular un proyecto que aborde la temática principal.

Etnografía audiovisual

La etnografía audiovisual busca comprender la cultura o vivencias del sujeto de estudio con la diferencia de que suma la imagen audiovisual como recurso para construir y relatar datos, interpretando y dando a conocer una realidad social y cultural a través de técnicas fotográficas, audiovisuales o gráficas.

Para lograr la realización de una etnografía audiovisual de buena manera es necesario tener un dominio de lenguaje visual y la utilización de recurso gráficos, por lo que se podría considerar que esta técnica de estudio tiene una gran relación con la disciplina del diseño.

Métodos cinematográficos

Direct Cinema: Opera como una forma de observación no participante.

Cinema Verité: Opera como una forma de observación activa.

Cine participativo: Opera desde un paradigma crítico e integra a la comunidad en el proceso.

Cine deconstructivo Evocativo: Profundiza las subjetividades del realizador, la comunidad y el espectador, dándole un sentido más connotativo.

Nuevos medios

Según el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, describe a los nuevos medios como formas de expresión visual y de comunicación que, mediante el uso de tecnologías, adoptan un enfoque crítico, experimental o innovador. Estas tecnologías redefinen los medios como herramientas creativas y artísticas, destacando su capacidad para explorar nuevos lenguajes y expandir los límites de las prácticas tradicionales. (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2023).

En el estudio dirigido por Kuhail, M.A. ElSayary, A. Farooq, S. y Alghamdi, A. “Exploring Immersive Learning Experiences” el año 2022, se evidenció que el uso de experiencias inmersivas como método de educación **ayuda a los receptores a visualizar e interactuar con conceptos a través de una experiencia realista, logrando el desarrollo de habilidades que normalmente son más difíciles de desarrollar con métodos pedagógicos tradicionales.**

Se plantea el diseño de Nuevos Medios como una solución que permite al espectador interactuar directamente con el relato, potenciando la conexión emocional con el público y facilitando una reflexión crítica sobre la problemática.



Figura 21. Moodboard de interacciones inmersivas. Elaboración propia.

ESTADO DEL ARTE

Análisis de referentes

REFERENTES INTERNACIONALES		MEDIO								OBJETIVO					
		AFICHE	INTERVENCIÓN	VIDEO	EXPOSICIÓN	FOTOGRAFÍA	INTERACCIÓN	INFOGRAFÍA	TESTIMONIOS	VISUALIZACIÓN DE DATOS	INFORMAR	PREVENIR	EXPONER	ACOMPañAR	REFLEXIONAR
CONCEPTUAL	LIFE IN MY SHOES PENTAGRAM		●		●	●	●		●		●		●		○
	NÚMEROS QUE HABLAN FUNDACIÓN HUESPED	●	●		●		●		●	●	○	○	○		○
	SILENCE = DEATH ACT UP	●	●			●	●				○	○	○	○	○
	PARIS IS BURNING JENNIE LIVINGTON			●					●		○		●		○
	ESTADISTICAS VIVAS FUNDACIÓN HUESPED	●	●	●				●	●	●	○		●		○
FORMAL	NAMES, AIDS MEMORIAL QUILT CLEVE JONES		●		●		●		●	●	○		●	○	○
	AUTOIMMUNE MARCOS SERAFIN			●	●	●			●	●			●		○
	AS MUCH AS I CAN JOHN SCHMIDT			●	●		●		●		○		●	○	○

Adaptación de cuadro de referentes según el modelo creado por Sebastián Moscoso, Taller Inaugurar.

Relevante para el proyecto.

CONCEPTUAL

REFERENTES NACIONALES

MEDIO

OBJETIVO

CHILE TIENE SIDA MNBA, CHILE														
LO QUE EL SIDA SE LLEVÓ YEGUAS DEL APOCALIPSIS														
CAMPAÑAS PREVENTIVAS MINISTERIO DE SALUD, CHILE														
CAMPAÑA 2023 JEVIH														
VIVO CON VIH, Y ESTOY BIEN AFH CHILE														
ESTA ES MI CARA ANGÉLICA CABEZAS PINO														
DIÁLOGOS VIRALES UN CUERPO EN EXPANSIÓN														
HABLAR DE VIH ONG AMARANTA														

Relevante para el proyecto.

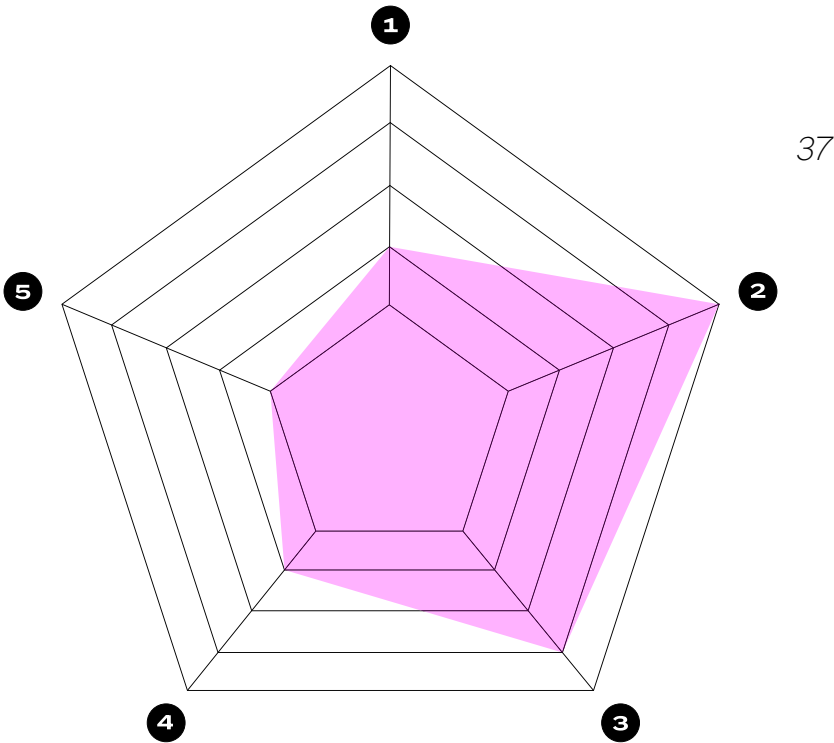
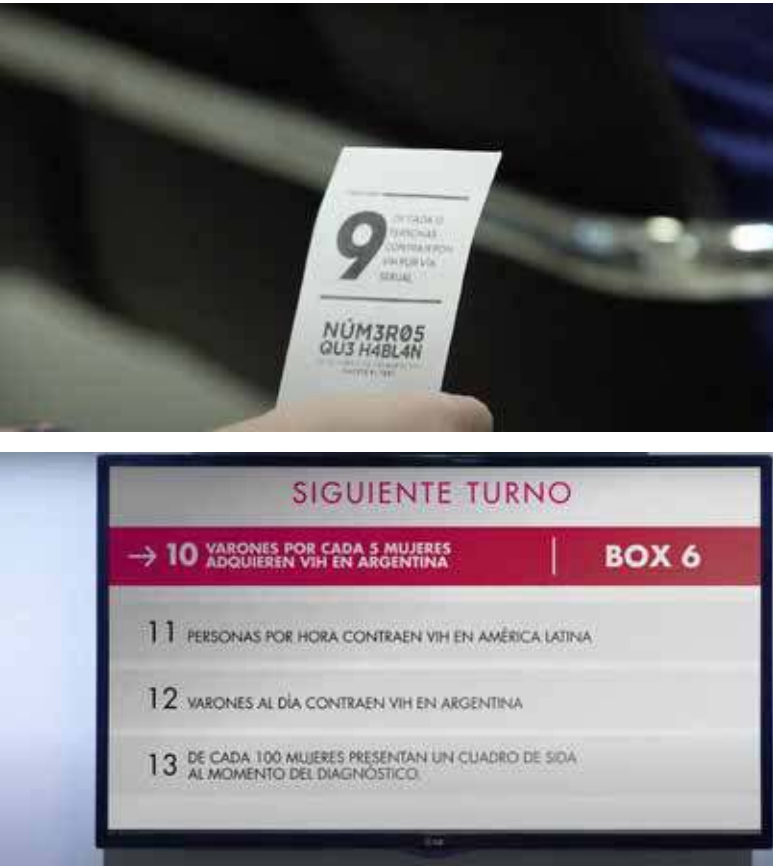
Análisis de referentes

Criterios de análisis: Radar araña.

- 1 **Función emotiva:** Capacidad de expresar emocionalidad en el usuario.
- 2 **Función apelativa:** Capacidad de incitar o motivar a realizar una acción.
- 3 **Memorabilidad:** Difícil de olvidar por el usuario, ya sea por su ejecución o su mensaje.
- 4 **Dificultad:** Grado de dificultad en el desarrollo del proyecto.
- 5 **Función representativa:** Capacidad de representar las vivencias de PVVIH.

Números que hablan Fundación Huésped, 2016.

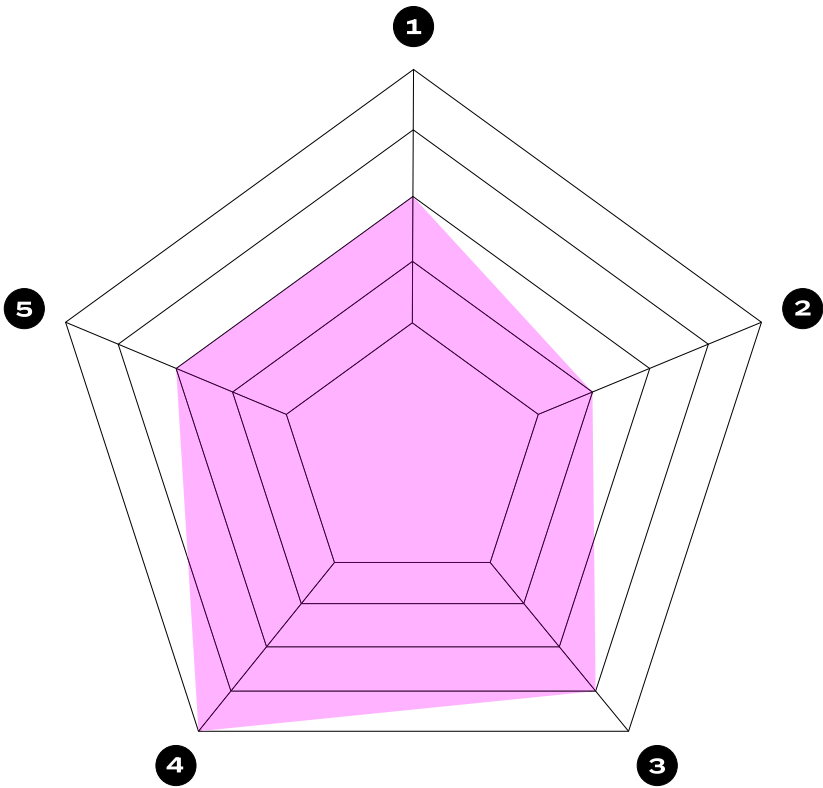
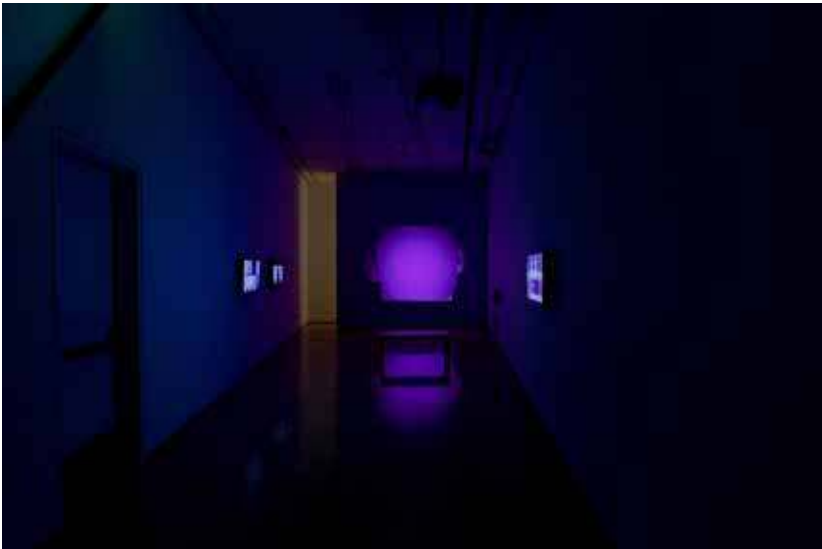
Acción de testeo masivo en Argentina, donde las personas que se acercaban a realizarse sus exámenes médicos se les entregó un ticket de turno con cifras reveladoras sobre la situación epidemiológica actual. La activación contó con la difusión de un spot y piezas gráficas digitales.



Autoimmune

Marcos Serafim, 2020.

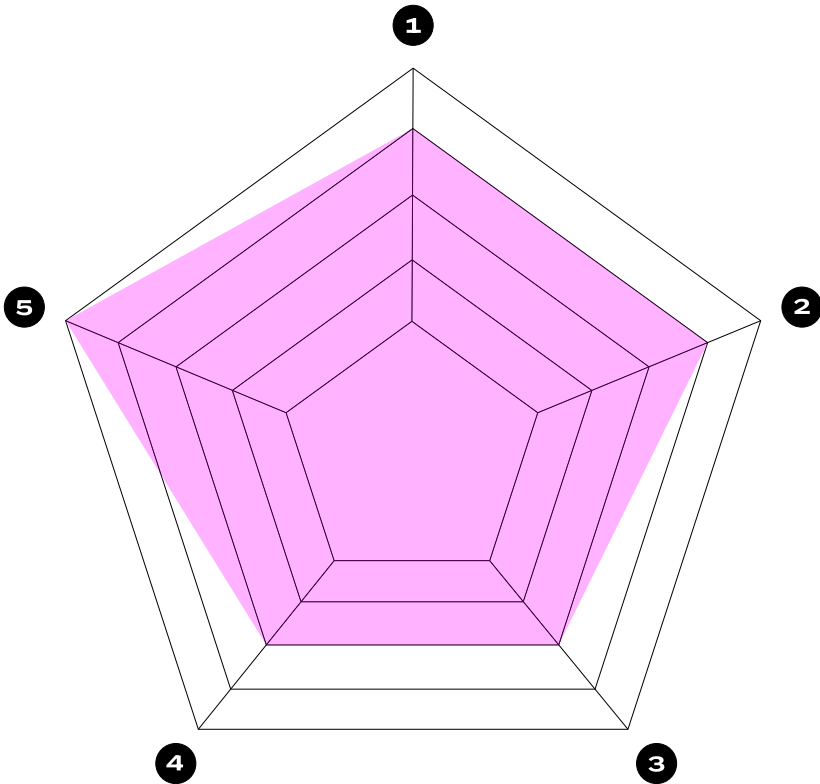
Instalación de video que explora el legado de la crisis inicial del SIDA en la era pre-terapia antirretroviral. Su objetivo principal es exponer las distorsiones de los hechos y la verdad que caracterizaron esta crisis, señalando la existencia de un “motor necro-político apoyado por los medios y la tecnología”.



Campaña 2023

JEVIH, 2023.

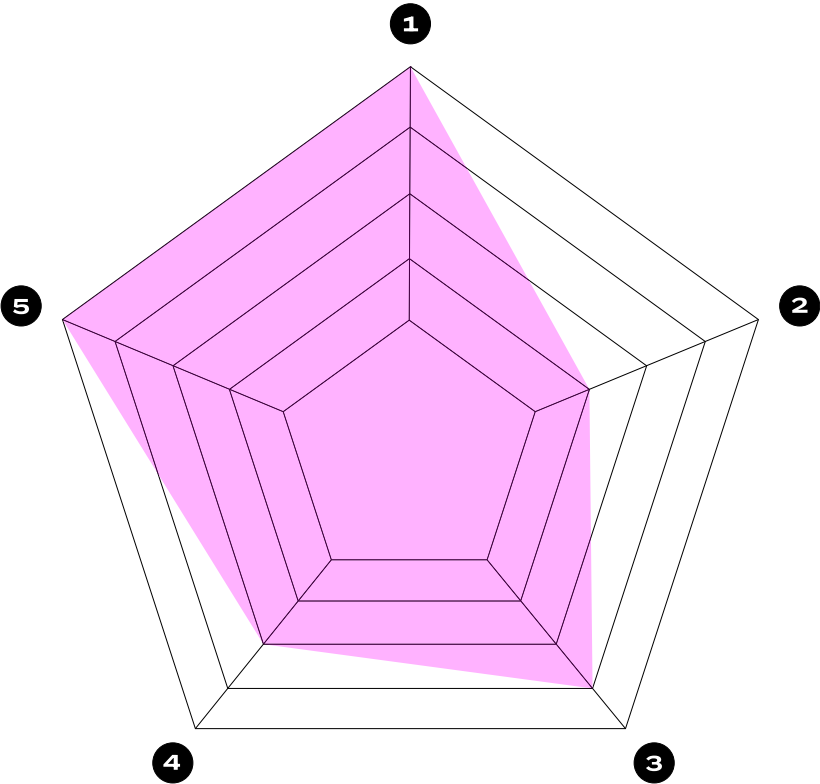
Colección de videos y gráficas digitales que hablan de experiencias de PVVIH en Chile con actores seropositivos. El material habla desde las vivencias personales acerca de lo que es vivir con VIH en Chile, abarcando desde el diagnóstico hasta la aceptación y acompañamiento.



Esta es mi cara

Angélica Cabezas, 2018.

investigación interdisciplinaria que combina métodos de la Antropología y las Artes a través de un documental, busca exponer cómo los hombres que viven con VIH en Chile construyen significado sobre su enfermedad en un contexto que limita sus oportunidades de dar sentido a sus experiencias, abordando el estigma asociado al VIH en Chile. El proyecto intenta contestar el discurso público sobre el VIH y normalizar la experiencia de vivir con el virus, promoviendo un diálogo más amplio.



[VI(H)SIBLES] [ESTADO DEL ARTE]



ÁREA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Tecnologías que articulan la experiencia

El rol del cuerpo en el medio

El cuerpo no aparece como un elemento externo, sino como parte central del medio. La presencia física del espectador constituye un componente activo del dispositivo: su movimiento, su distancia y su modo de habitar el espacio influyen directamente en cómo se despliega el contenido audiovisual. Desde la perspectiva de los nuevos medios, el cuerpo no solo observa, sino que participa en la construcción de sentido, transformando la experiencia a medida que se desplaza o se aproxima a cada eje.

Su función no es únicamente activar sensores, sino tensionar aquellas zonas donde la visibilidad histórica del VIH ha quedado marcada por silencios, temores o imaginarios distorsionados. Al involucrar al espectador en la interacción, se propone un recorrido donde la corporalidad opera como un puente entre lo personal y lo testimonial, habilitando un tránsito simbólico hacia lo visible.

Sensores de distancia y proximidad

Dentro de las tecnologías utilizadas en los nuevos medios, los sensores de distancia y proximidad permiten establecer vínculos directos entre el cuerpo y el comportamiento del material audiovisual. Aunque se inscriben en el plano técnico, su presencia incide también en la narrativa, porque definen cómo se accede al contenido y qué transformaciones se activan en función de la relación corporal del espectador con el entorno.

El sensor ultrasónico HC-SR04, por ejemplo, registra la distancia entre el cuerpo y un punto de lectura. Esa información se traduce en variaciones visuales que pueden alterar la claridad, la intensidad o el ritmo de la imagen, permitiendo trabajar con estados donde acercarse o alejarse modifica la forma en que se interpreta el contenido.

Por otra parte, los sensores PIR detectan presencia sin medir dirección ni distancia, activando eventos puntuales que pueden manifestarse como sonidos, capas visuales o acciones en tiempo real. Su lógica es binaria: anuncian que un cuerpo está ahí y desencadenan un proceso que depende estrictamente de esa presencia.

Ambos tipos de sensores pueden converger en un solo microcontrolador, como Arduino UNO, que centraliza los datos y los envía a softwares como TouchDesigner para traducirlos en comportamientos audiovisuales. Este flujo técnico permite que la corporalidad no sea un elemento decorativo, sino una fuerza que interviene, condiciona y complejiza la experiencia dentro del medio.

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

PROBLEMÁTICA

Existe una **persistencia del estigma y la desinformación** sobre el VIH en Chile, alimentada por imaginarios moralizantes, fallas históricas en campañas de comunicación del Estado y la **invisibilización de las vivencias reales de personas que viven con VIH** (PVVIH).

Este estigma opera tanto en la **sociedad general como dentro de la misma comunidad LGBTIQ+**, donde persisten prejuicios sutiles e internalizados.

HALLAZGOS

Las personas jóvenes seronegativas de la misma comunidad LGBTQ+, quienes debieran tener mayor sensibilidad, **siguen reproduciendo prejuicios sutiles, silenciosos, normalizados, que afectan emocionalmente a quienes viven con VIH.**

OPORTUNIDAD DE DISEÑO

Surge la oportunidad de diseñar una experiencia inmersiva e interactiva, coherente con los códigos culturales, afectivos y estéticos de la comunidad, que **visibilice estas vivencias, tensiones estos estigmas y habilite espacios de reflexión y cuestionamiento personal.**

OBJETIVOS

Objetivo general

Incentivar el cuestionamiento personal y la reflexión crítica sobre los prejuicios no reconocidos hacia personas que viven con VIH dentro de la comunidad LGBTIQ+, mediante una experiencia inmersiva que visibilice y tense los estigmas intracomunitarios desde una perspectiva situada y afectiva.

Objetivos específicos

- 1. Analizar las manifestaciones de estigma, desinformación y prejuicios** sutiles presentes dentro de la comunidad LGBTIQ+, a partir de testimonios y casos reales de personas que viven con VIH.
- 2. Desarrollar estrategias narrativas, visuales y sensoriales que representen de manera crítica y afectiva** las vivencias de PVVIH, integrando tecnologías propias de los nuevos medios.
- 3. Diseñar una instalación inmersiva que articule interacción, espacialidad y lenguaje audiovisual** para generar una experiencia que confronte, movilice y promueva la reflexión del público frente al estigma intracomunitario.

ANÁLISIS DE USUARIO

USUARIO OBJETIVO

El que no se cuestiona

Usuario objetivo

El usuario corresponde a personas jóvenes de entre 20-35 años, pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ y seronegativas, que presentan cierto nivel de sensibilidad frente al VIH, pero igualmente reproducen estigmas sutiles e internalizados. Se trata de un perfil que reconoce la relevancia del tema, pero cuya comprensión se articula desde imaginarios heredados, desactualizados o basados en suposiciones que no han sido cuestionadas.

Si bien no ejercen discriminación explícita, sí presentan conductas y creencias que perpetúan estigmas culturales, tales como el miedo al contagio en situaciones cotidianas, el uso de un lenguaje incorrecto o la evitación del tema por considerarlo incómodo.

Usuario co-creador

PVVIH sin importar su edad, la presencia de este usuario no opera como una fuente de información aislada, sino como un agente activo dentro del proceso creativo, orientando la definición de ejes temáticos, la estructura del guión y las decisiones formales que articulan la instalación.

Su participación, entendida desde un enfoque colaborativo y ético, sostiene la base conceptual del proyecto y habilita un espacio de co-creación donde el diseño se construye a partir del encuentro entre experiencia vivida y reflexión estética.

48

ARQUETIPO

Se presenta un arquetipo de usuario basado en el modelo del psiquiatra, psicólogo e investigador Carl Gustav Jung, quien propone 12 arquetipos según la personalidad predominante, tomando como referencia el estudio de arquetipos de usuario planteada por Sofía Sixtina en su memoria de título “CIUDAD VIHVA”:

EL NO INFORMADO — EVERYMAN —



Estado emocional frente a vivencias de PVVIH: Indiferente

Nivel de estigma: ● ● ● ○ ○

Nivel de información que maneja sobre VIH: ● ● ○ ○ ○

Fase de cambio inicial en respecto a vivencias de PVVIH (según el modelo de Prochaska y Diclemente): Pre-contemplativa

Everyman: Alguien que actúa desde la cotidianeidad, la pertenencia y el deseo de encajar. Su sombra, el Huérfano, aparece en la forma de miedos silenciosos, dudas no expresadas y resistencia a profundizar en aquello que puede resultar incómodo. Esta tensión lo convierte en un usuario ideal para ser interpelado desde una experiencia que revele y desactive estigmas internalizados.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA GENERAL

Cómo se desarrolla

La metodología del proyecto combina diseño centrado en las personas, etnografía audiovisual y recursos propios de los nuevos medios. Este enfoque permite abordar el VIH desde una perspectiva situada, integrando dimensiones afectivas, técnicas y espaciales en un mismo proceso de diseño.

El proyecto se inicia con entrevistas en profundidad a personas que viven con VIH, quienes participan como usuarios co-creadores. Sus testimonios no solo aportan contenido, sino que orientan decisiones conceptuales y estéticas, convirtiéndose en el eje que estructura la narrativa de la instalación. A partir de estas conversaciones, se elabora una matriz de análisis cualitativo que identifica emociones, tensiones y representaciones recurrentes, organizándose en ejes temáticos que guían las cápsulas audiovisuales.

En paralelo, se definen las interacciones mediante sensores de distancia, sensores PIR y captura de silueta, integrados a través de Arduino y procesados en TouchDesigner. Estas tecnologías no se conciben como adornos interactivos, sino como herramientas que permiten vincular la presencia corporal del espectador con la experiencia, generando variaciones visuales o sonoras que dialogan con los relatos recogidos. El proceso incorpora un marco ético basado en el consentimiento informado, la protección de identidades y el uso respetuoso de los testimonios. La intención es evitar representaciones distantes o extractivas, construyendo una obra que surge desde la colaboración y el reconocimiento de las experiencias relatadas.

Finalmente, el diseño espacial y material de la instalación se desarrolla de forma iterativa, ajustándose según los objetivos comunicativos del proyecto y las posibilidades técnicas. La metodología se convierte así en un recorrido que transforma los testimonios en una experiencia inmersiva que articula cuerpo, imagen y afectividad.

ETAPA 1

Investigación

- Levantamiento preventivo y búsqueda de alianzas estratégicas

ETAPA 2

Levantamiento de contenido

- Convocatoria
- Grabación de testimonios
- Feedback de entrevistados

ETAPA 3

Desarrollo data

- Análisis cualitativo
- Matriz de análisis ejes temáticos
- Definición narrativa audiovisual
- Definición eje espacial

ETAPA 4

Propuesta de diseño

- Conceptualización
- Selección y edición material bruto
- Integración de la interacción con el medio
- Planimetría y render montaje

ETAPA 5

Implementación instalación

- Materialidad
- Fichas técnicas
- Costos
- Viabilidad

CARTA GANTT

VI(H)SIBLES.	SEMINARIO					PROYECTO DE TÍTULO				
MES TAREA	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ESTUDIO Y ÁMBITOS DE TRABAJO										
ANÁLISIS TEÓRICO										
HALLAZGO Y PROBLEMÁTICA										
ALIANZA Y ÉTICA										
CONVOCATORIA Y ENTREVISTAS										
ANÁLISIS CUALITATIVO										
POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL										
INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA										
DIRECCIÓN CREATIVA										
DEFINICIÓN DE INSTALACIÓN										
MATERIALIDAD Y FICHAS TÉCNICAS										
MATERIAL GRÁFICO										

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Vinculación con el medio

Fundación Chile Positivo

El desarrollo del proyecto contó con la colaboración de Fundación Chile Positivo, organización dedicada a la prevención, educación y acompañamiento en torno al VIH. Su participación fue fundamental para asegurar un proceso ético, informado y respetuoso, tanto en la construcción del contenido como en el vínculo con las personas entrevistadas.

La fundación dispone de una red de más de 800 voluntarios seropositivos y seronegativos, lo que permitió acceder a perfiles diversos y pertinentes para el proyecto. A través de su equipo, se gestionó la convocatoria inicial y se facilitaron contactos directos, logrando concretar entrevistas con participantes que cumplieran con los criterios definidos. Además, pusieron a disposición su espacio físico para realizar las grabaciones, ofreciendo acompañamiento emocional a los entrevistados y apoyo para la conducción de las conversaciones.

La alianza incluyó también la revisión y validación del consentimiento informado, así como la orientación en protocolos éticos específicos para proyectos que trabajan con experiencias sensibles. Durante el proceso, la fundación aportó recomendaciones metodológicas, entre ellas la posibilidad de aplicar cuestionarios breves antes y después de la experiencia expositiva para evaluar impacto reflexivo y niveles de empatía.

En términos de difusión, Chile Positivo colaboró mediante la publicación del proyecto en sus redes sociales, ampliando su alcance y visibilizando la convocatoria de participantes. Finalmente, la organización manifestó su disposición a acompañar la muestra mediante un stand informativo durante la exposición, reforzando la dimensión educativa y comunitaria del proyecto.

La alianza estratégica con Chile Positivo permitió desarrollar una propuesta que integra responsabilidad ética, pertinencia social y una mirada situada del VIH, fortaleciendo así la calidad y legitimidad del proyecto.



MARCO ÉTICO

Consentimiento

El proceso de consentimiento informado se desarrolló con acompañamiento de Fundación Chile Positivo, asegurando que cada participante comprendiera el objetivo del proyecto, el uso de su testimonio y las condiciones de resguardo de su identidad.

Antes de cada entrevista se presentó un documento formal donde se explicaban los alcances de la participación, el tipo de registro que se realizaría (audio y/o video) y las posibilidades de anonimización o aparición visible en el material final.

La firma del consentimiento fue completamente voluntaria y cada persona tuvo espacio para resolver dudas, detener la entrevista en cualquier momento o solicitar la eliminación de su testimonio si así lo deseaba. Se resguardó la privacidad mediante la edición del material y el almacenamiento seguro de los archivos originales, garantizando confidencialidad y respeto hacia las experiencias compartidas.

Este proceso permitió trabajar con un marco ético claro, acorde al carácter sensible del proyecto y a la naturaleza colaborativa de los relatos.

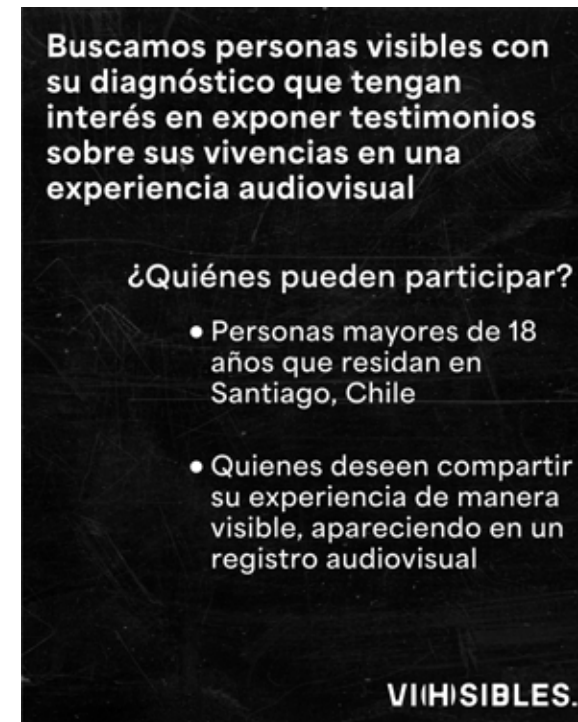
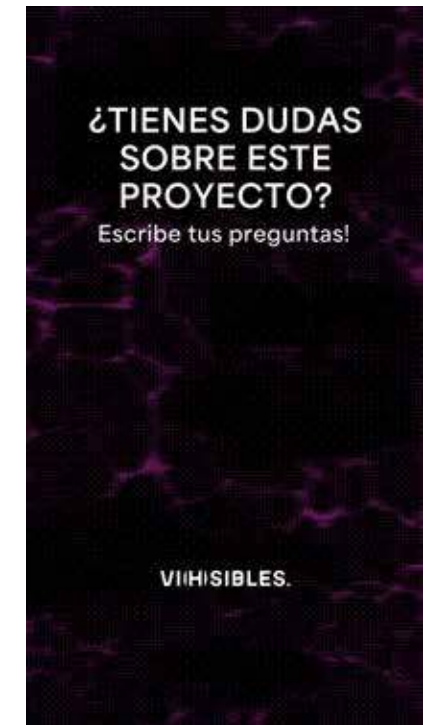
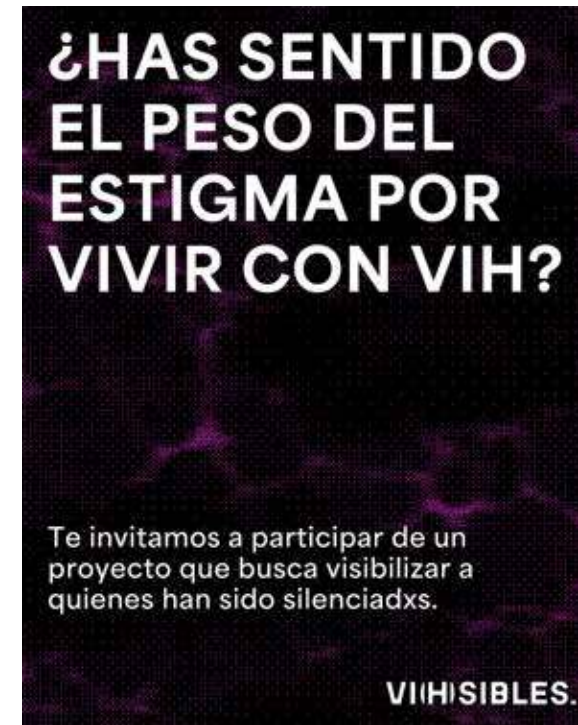
CONVOCATORIA

La convocatoria de participantes se realizó mediante dos vías principales: una articulada junto a la Fundación Chile Positivo y otra gestionada directamente a través de la cuenta del proyecto en Instagram (@vihsiblescl). Ambas estrategias permitieron llegar a personas serovisibles interesadas en compartir sus experiencias de manera voluntaria y acompañada.

En primera instancia, Chile Positivo difundió el llamado a través de sus redes y su red interna de voluntarios, ampliando el alcance de la convocatoria y facilitando contactos directos. Esta difusión incluyó publicaciones e historias en sus plataformas digitales, donde se explicaban los objetivos del proyecto, los criterios de participación y la posibilidad de aparecer visiblemente en un registro audiovisual. Gracias a este apoyo, se logró convocar a dos participantes y recibir orientación sobre perfiles potenciales.

Paralelamente, se realizó una convocatoria independiente mediante publicaciones y gráficas diseñadas específicamente para redes sociales. Estas piezas comunicaban de manera clara y respetuosa el sentido del proyecto, los requisitos de participación y las garantías éticas del proceso. Donde también se logró convocar a dos participantes.

La combinación de estas dos estrategias permitió generar una convocatoria más amplia, abierta y situada, articulada desde el respeto, la transparencia y el acompañamiento. Gracias a ello, se logró concretar un grupo de 4 entrevistados que participaron de forma voluntaria y consciente, aportando relatos significativos que constituyen el núcleo del proyecto.



Guía de entrevistas

El proceso de entrevistas constituyó la primera etapa central del proyecto y permitió construir el material testimonial que da origen a la propuesta audiovisual. Para ello, se elaboró un cuestionario compuesto por 18 preguntas abiertas diseñadas a partir de la investigación teórica y del análisis previo sobre estigmas, imaginarios y experiencias vinculadas al VIH.

Las preguntas se organizaron en torno a cuatro grandes temáticas: diagnóstico y primeras emociones, experiencias de apoyo cercano, situaciones de estigma y discriminación, y relación con el cuerpo, el deseo y los procesos de aprendizaje a lo largo del tiempo.

Cada pregunta fue redactada con el objetivo de facilitar respuestas amplias y narrativas, permitiendo que las personas entrevistadas describieran sus vivencias desde su propia perspectiva y ritmo. El orden del cuestionario fue estructurado para acompañar una conversación fluida, iniciando por temas más descriptivos y avanzando progresivamente hacia aspectos más sensibles, considerando el impacto emocional que algunos relatos pueden implicar. De esta manera, las entrevistas se desarrollaron como un diálogo guiado más que como un cuestionario rígido, privilegiando el cuidado y la comodidad de cada participante.

Antes de su aplicación, el cuestionario fue revisado junto a la Fundación Chile Positivo y validado por el primer participante convocado. Ambas revisiones permitieron ajustar el tono, claridad y pertinencia de las preguntas, asegurando que el contenido fuese respetuoso, comprensible y adecuado para el contexto emocional de las personas que viven con VIH. Este proceso garantizó que las entrevistas se desarrollaran con un marco ético sólido y con una estructura que facilitara la expresión personal de cada entrevistado.

DESARROLLO PROYECTUAL

EJE NARRATIVO

Construcción del relato

Transcripción e integración de testimonios

Luego del proceso de entrevistas, se realizó la transcripción completa de cada conversación, registrando tanto el contenido verbal como los silencios, pausas y matices que permitían comprender la dimensión afectiva de los relatos. Este material constituyó la base para el análisis posterior, permitiendo trabajar de manera cercana y respetuosa con las experiencias compartidas.

Para organizar el volumen de información, se incorporaron herramientas de procesamiento de lenguaje natural, utilizando GPT-5 como apoyo en la sistematización inicial del material. Esta asistencia permitió identificar patrones discursivos, palabras recurrentes y posibles agrupaciones temáticas.

Su rol fue exclusivamente complementario, facilitando la exploración preliminar de los datos y ofreciendo una lectura amplia que luego fue revisada, interpretada y ajustada manualmente.

Todas las decisiones conceptuales, incluyendo la selección de fragmentos, la categorización temática y la construcción narrativa, fueron realizadas desde el criterio autoral del proyecto, resguardando la fidelidad y la sensibilidad de los testimonios.

Matriz de análisis

A partir de este proceso mixto, se definieron 5 ejes temáticos transversales en cada entrevista en base a una matriz de análisis cualitativa, que permite organizar los relatos según las emociones, tensiones y experiencias más recurrentes.

La matriz de análisis se desarrolló como una herramienta para organizar, sintetizar y traducir los testimonios en decisiones concretas de diseño audiovisual.

El primer paso consistió en identificar extractos que expresaran emociones, tensiones o experiencias que se repetían entre diferentes participantes. Estos fragmentos se registraron en la matriz junto a una breve descripción de su contenido y de su relevancia dentro del relato. Este ejercicio permitió reconocer patrones narrativos que dialogaban entre sí, aun cuando provenían de personas con distintos contextos de vivencia, logrando definir los 5 ejes temáticos.

Cada síntesis se tradujo en un eje temático, acompañado de una descripción breve y un fundamento testimonial que justifica su existencia a partir de las experiencias relatadas. Esta justificación se construyó citando los testimonios más representativos o aquellos que aportaban matices esenciales para comprender la dimensión emocional del eje. De esta manera, la matriz mantiene la coherencia entre lo que se dice y la forma en que se transforma en contenido audiovisual.

1. **El Diagnóstico:** relatos que describen el momento del diagnóstico, caracterizado por confusión, miedo, incertidumbre y la sensación de quiebre con la vida cotidiana.
2. **Estigma y silencio:** experiencias vinculadas a prejuicios sociales, discriminación explícita o microestigmas, así como dinámicas de ocultamiento y distancia simbólica.
3. **Cuerpo y vulnerabilidad:** percepciones sobre la relación con el propio cuerpo, la intimidad, el deseo y los procesos de autoconocimiento que surgen a partir del diagnóstico.
4. **Apoyo y contención:** relatos donde aparecen redes de acompañamiento, afectividad y cuidado, fundamentales para resistir el impacto social y emocional del estigma.
5. **Futuro y reescritura:** reflexiones vinculadas a aprendizajes, resignificaciones personales y la posibilidad de proyectarse más allá del diagnóstico.

Pilares narrativos

El guión narrativo organiza los cinco ejes temáticos definidos en la matriz en dos grandes etapas: HERIDA y CICATRIZ. Ambas funcionan como marcos emocionales y conceptuales que permiten estructurar el recorrido del espectador dentro de la instalación. La narrativa no se plantea como un relato lineal, sino como una sucesión sensorial que avanza desde la tensión inicial hacia un espacio de contención y proyección futura.

HERIDA

- El diagnóstico
- Estigma y silencio
- Cuerpo y vulnerabilidad

CICATRIZ

- Apoyo y contención
- Futuro y reescritura

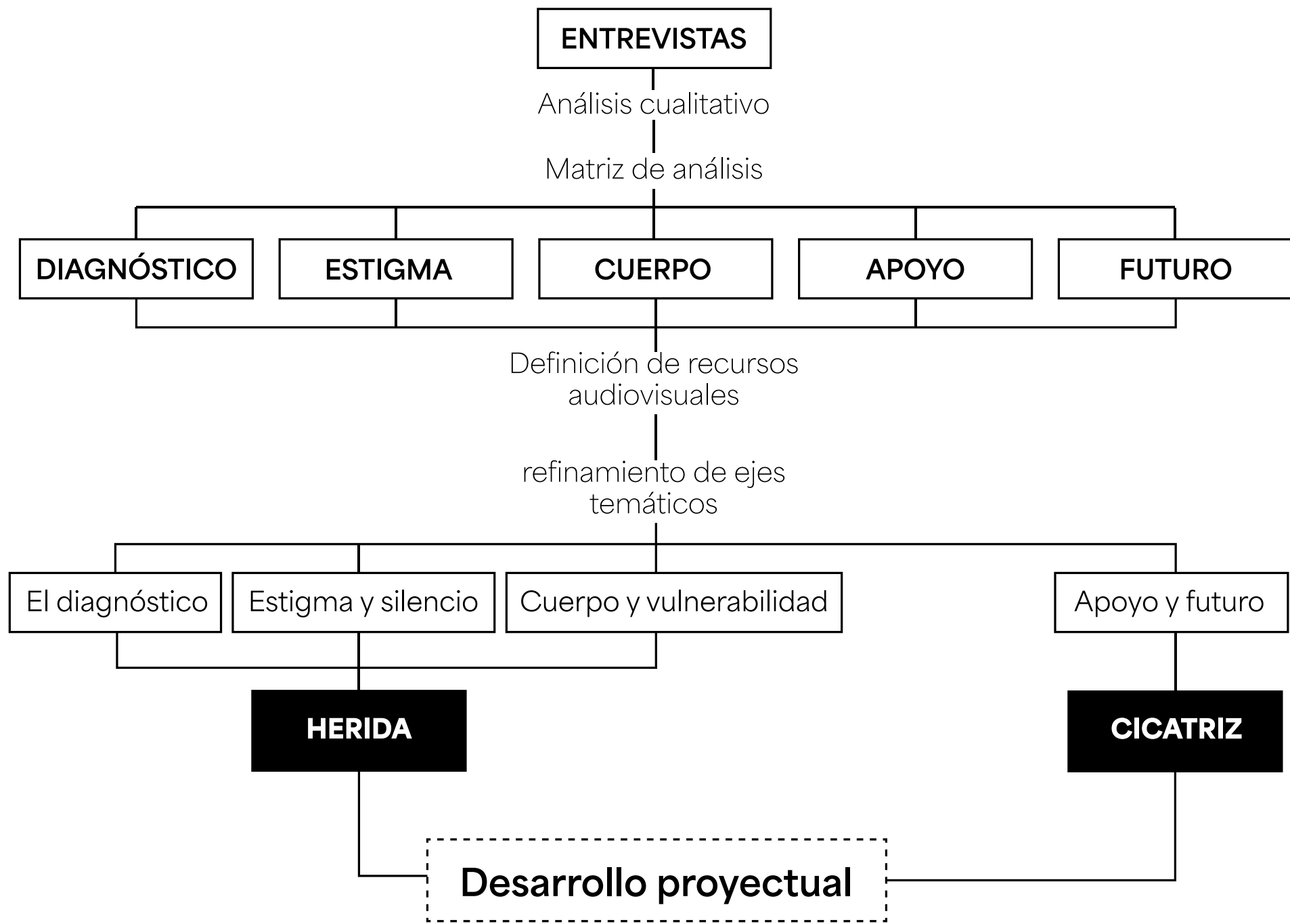


Figura 22. Mapa de definición narrativa. Elaboración propia.

HERIDA: Diagnóstico - Estigma - Cuerpo

Reúne los ejes vinculados a la confusión, el miedo y las tensiones que emergen en la experiencia seropositiva. Esta etapa se construye desde un lenguaje fragmentado y atmosférico que refleja el impacto emocional descrito por los entrevistados. La intención de HERIDA es situar al espectador en un estado de confrontación inicial, interpelándolo desde la vulnerabilidad, la inestabilidad y el silencio.

1. El diagnóstico.

Narrativa: distorsiones, variaciones de nitidez y cambios abruptos de claridad visual reflejan la confusión del diagnóstico. El ritmo es irregular e inestable, evocando la sensación de enfrentarse a una realidad difícil de comprender.

Interacción: el sensor ultrasónico modifica la imagen según la distancia del espectador. Si se acerca, la imagen gana claridad; si se aleja, vuelve a fragmentarse.

Intención comunicativa: Provocar una inmersión emocional inicial y un punto de entrada, dar el paso de tránsito hacia lo visible, busca que el espectador experimente el desorden sensorial y emocional del diagnóstico y la vulnerabilidad ante lo desconocido.

2. Estigma y silencio.

Narrativa: Visualidad estable que se ve interrumpida por interferencias, cortes abruptos o capas superpuestas. El contenido parece avanzar, pero se traba, se suspende o se distorsiona, representando la presencia persistente del estigma.

Interacción: Un sensor PIR activa el contenido únicamente cuando el espectador entra en la zona, pero no permite intervenir. El espectador solo puede contemplar la experiencia; no puede modificarla ni suavizar. Este gesto enfatiza que el estigma opera sobre el sujeto independientemente de su voluntad.

Intención comunicativa: Evidenciar cómo el estigma irrumpe como una fuerza externa que condiciona la vida cotidiana, incluso en quienes creen haber superado o entendido el VIH, es un paso hacia un aspecto inminente en la vida de una PVVIH, generando una incomodidad en el espectador.

3. Cuerpo y vulnerabilidad.

Narrativa: desenfoques suaves, siluetas que aparecen parcialmente y capas visuales que se revelan a través del movimiento corporal. La atmósfera es íntima y frágil, con un ritmo más introspectivo que los ejes anteriores.

Interacción: la presencia detectada por un sensor PIR activa la cámara, que registra la silueta del espectador. Esta silueta funciona como una ventana que permite visualizar fragmentos del testimonio, estableciendo un vínculo directo entre el cuerpo que observa y la experiencia relatada.

Intención comunicativa: Explorar cómo el cuerpo se vuelve un territorio donde conviven deseo, miedo, vergüenza y autoconocimiento, invitando al espectador a reconocerse en esa vulnerabilidad compartida.

CICATRIZ: Apoyo - Futuro

Reúne los ejes que emergen después de la tensión inicial, asociados a procesos de acompañamiento, aprendizaje y reconstrucción personal. Su narrativa es más estable, clara y pausada, invitando a una lectura afectiva del VIH que no se centra en el dolor, sino en la continuidad de la vida y la agencia de quienes la habitan.

1. Apoyo y contención.

- Narrativa:** Imágenes claras, tonos cálidos y transiciones fluidas conforman un espacio visual acogedor. El ritmo baja para permitir la escucha y la permanencia.
- Interacción:** No existe interacción directa. El contenido se reproduce de manera estable, generando un espacio de descanso frente a la tensión previa.
- Intención comunicativa:** Transmitir la importancia de las redes afectivas como apoyo frente al estigma, mostrando el valor del acompañamiento desde una perspectiva sensible y cercana.

2. Futuro y reescritura.

- Narrativa:** Imágenes estables, luz constante y movimientos suaves que proyectan calma. La construcción audiovisual busca un tono de claridad y cierre, guiando hacia una lectura más amplia del VIH como experiencia continua y no como sentencia.
- Interacción:** Al igual que en el eje anterior, no se activa ninguna interacción. El contenido invita a una observación tranquila y reflexiva, cerrando la experiencia desde la calma.
- Intención comunicativa:** Instalar una mirada que reconozca la agencia de quienes viven con VIH, subrayando la posibilidad de reescribir la propia historia más allá del diagnóstico.

EJE EXPOSITIVO

Cómo se mostrará

HERIDA.

Herida corresponde al primer tramo del recorrido dentro de la instalación, ubicado en las alas externas de la estructura con forma de cruz. Esta etapa aborda el tránsito inicial entre el diagnóstico, el estigma y la relación con el cuerpo, explorando el impacto emocional y social del VIH desde la vulnerabilidad, el miedo y el silencio. Visualmente, se presenta como un espacio frío, duro e incómodo, donde la materialidad expuesta, esquinas rígidas, cableado visible y superficies metálicas, refuerzan una estética brutalista que enfatiza la crudeza del tema.

En cada eje temático se dispone una pantalla LED vertical acompañada de sensores y una pantalla secundaria con texto. La elección de la verticalidad proviene del estudio de referentes y busca generar una instancia más íntima y directa con los testimonios. Cada eje está diseñado para ser utilizado por una sola persona a la vez, permitiendo que el espectador se enfrente individualmente al relato y establezca un vínculo personal con la imagen y la voz. Esta disposición configura un espacio de reconocimiento e intimidad donde el cuerpo del espectador se vuelve parte de la lectura sensorial del estigma.

CICATRIZ.

Cicatriz se sitúa en el interior de la estructura y reúne los ejes de apoyo y futuro, proponiendo un desplazamiento desde la dureza inicial hacia la afectividad, la reconstrucción y la esperanza. En esta etapa, el espectador ingresa al corazón de la instalación, relacionándose de manera directa con el relato en un ambiente que invita a la calma y la reflexión.

Visualmente, el espacio se manifiesta mediante claridad, un ritmo visual más pausado y una iluminación cálida que funciona como afirmación de existencia y dignidad. A diferencia de Herida, aquí no existe interacción directa: el espectador deja de “intervenir” y pasa a observar, permitiendo que el silencio opere como un cierre de ciclo, ya no como censura, sino como un gesto de paz.

El módulo interior está pensado como un lugar cómodo y acogedor, donde las personas pueden recostarse para contemplar las visuales proyectadas. Con una capacidad máxima de tres personas, se configura un espacio íntimo de contemplación afectiva. Cicatriz busca concluir la experiencia desde la serenidad y la humanidad, mostrando que la vida con VIH continúa más allá del diagnóstico y abriendo un horizonte de futuro posible y sin miedo.

Referentes de instalación

Los referentes de instalación reunidos en esta sección sirven para comprender cómo distintos artistas han abordado la relación entre espacio, cuerpo y visualidad en experiencias inmersivas.

Estas obras ofrecen estrategias sobre montaje, uso de pantallas, disposición espacial, iluminación y formas de habitar la obra, elementos clave para el diseño de HERIDA y CICATRIZ, permitiendo reflexionar sobre cómo la instalación puede modular estados afectivos, orientar el tránsito del espectador y sostener una experiencia que combina contemplación, interacción y presencia física.

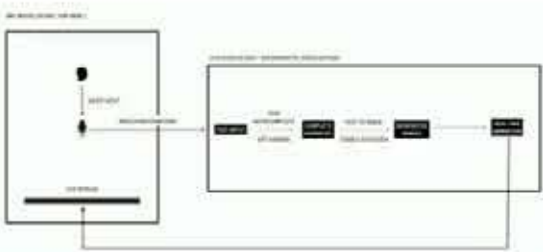
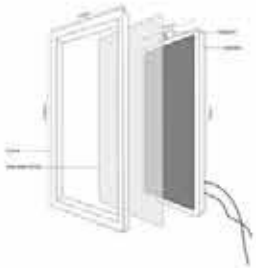
REFERENTES TÉCNICOS: HERIDA



Total recall (1987) - Gretchen Bender.



Mirror Ritual (2020) - Nina Radjić.



ReCollection (2024) - Weidi Zang.



Arcoparlantes (2024) - Almendra Diaz.



REFERENTES TÉCNICOS: CICATRIZ



La obra originalmente se proyectó sobre el techo de una iglesia barroca en Venecia.

El año 2024 hubo una adaptación en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, donde se utilizaron 5 pantallas colgantes acompañadas de cojines y colchones para que los espectadores pudieran observar la obra desde el suelo.



Homo sapiens sapiens (2005) - Pipilotti Rist.



Esta instalación utiliza una gran pantalla circular y espejos en el cielo para crear la ilusión del sol, creando una atmósfera cálida donde los espectadores podían recostarse y contemplar la obra.



The weather project (2003) - Tate Modern.

Recorrido

El recorrido propone un tránsito emocional que guía al espectador a través de distintas formas de acercarse al VIH y a los relatos que lo sostienen.

Cada desplazamiento activa un cambio perceptivo, en las primeras etapas, la cercanía a las pantallas modifica el comportamiento de la imagen, que fluctúa entre la nitidez y la distorsión según la posición del cuerpo en el espacio. Esta interacción convierte la presencia física del espectador en un elemento que tensiona los testimonios, haciendo visible cómo la mirada externa incide en la forma en que estas vivencias se exponen.

Al avanzar hacia el interior de la instalación, el cuerpo abandona esa lógica de intervención directa y adopta una postura más contemplativa, invitándose a recostarse y sostener la mirada hacia un plano audiovisual elevado que concentra la etapa final. El recorrido funciona como una coreografía silenciosa donde caminar, detenerse o recostarse transforma la relación con la imagen y habilita distintos estados emocionales.

No se trata de un camino lineal, sino de un proceso sensorial que evoluciona desde la inquietud hacia la calma, desde la fragmentación hacia la recomposición.

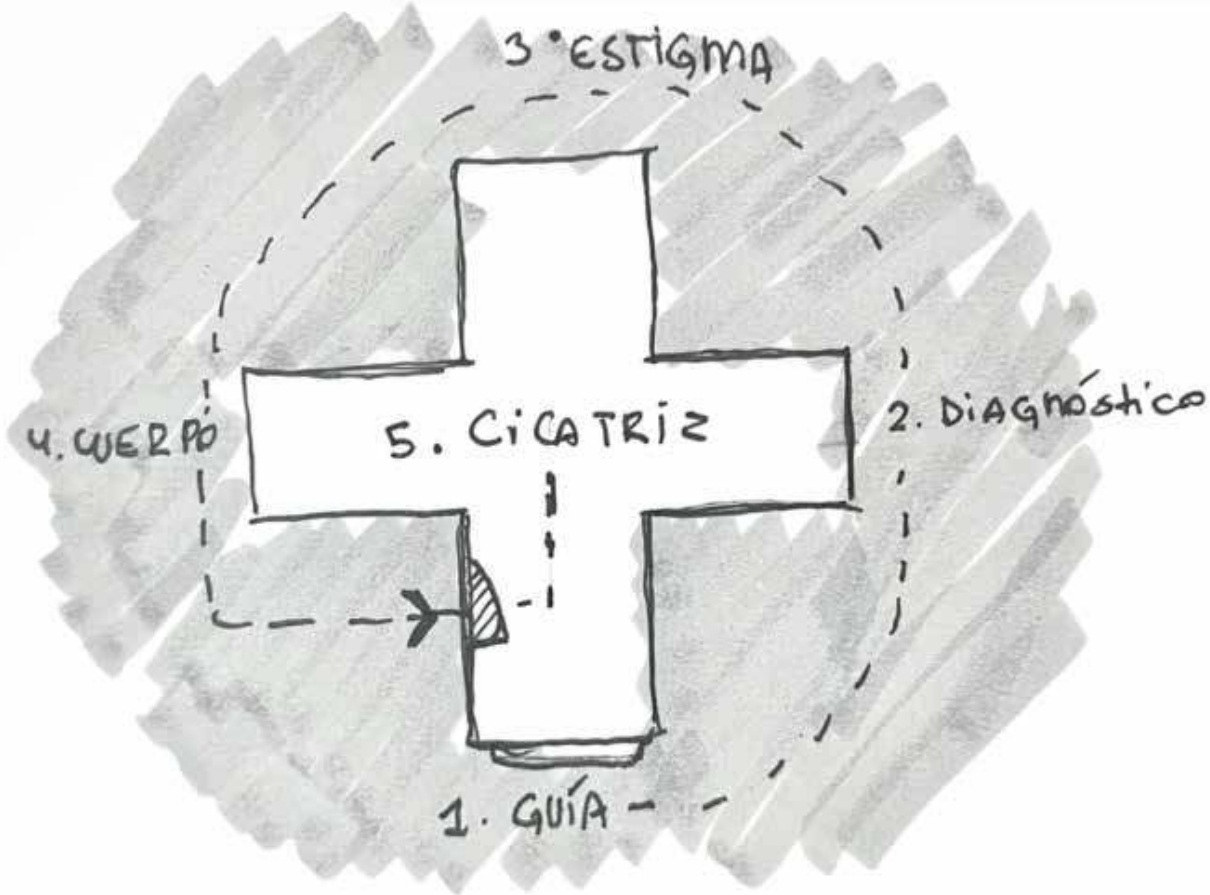


Figura 23. Croquis primeras exploraciones. Elaboración propia.

EJE INTERACTIVO / TECNOLÓGICO

Cómo funciona

Flujos de interacción

Los flujos de interacción permiten que la instalación responda directamente a la presencia del espectador. Cada eje trabaja con un tipo de detección distinto, de modo que gestos simples como acercarse o detenerse generan variaciones audiovisuales que acompañan el recorrido. La interacción funciona como un modo de lectura del cuerpo dentro del espacio.

En las estaciones de Estigma y Cuerpo, los sensores PIR registran la aparición del espectador y activan señales de audio asociadas a ese momento. En Diagnóstico, la detección se realiza mediante un sensor ultrasónico HC-SR04, que permite trabajar la distancia como parte del comportamiento expresivo.

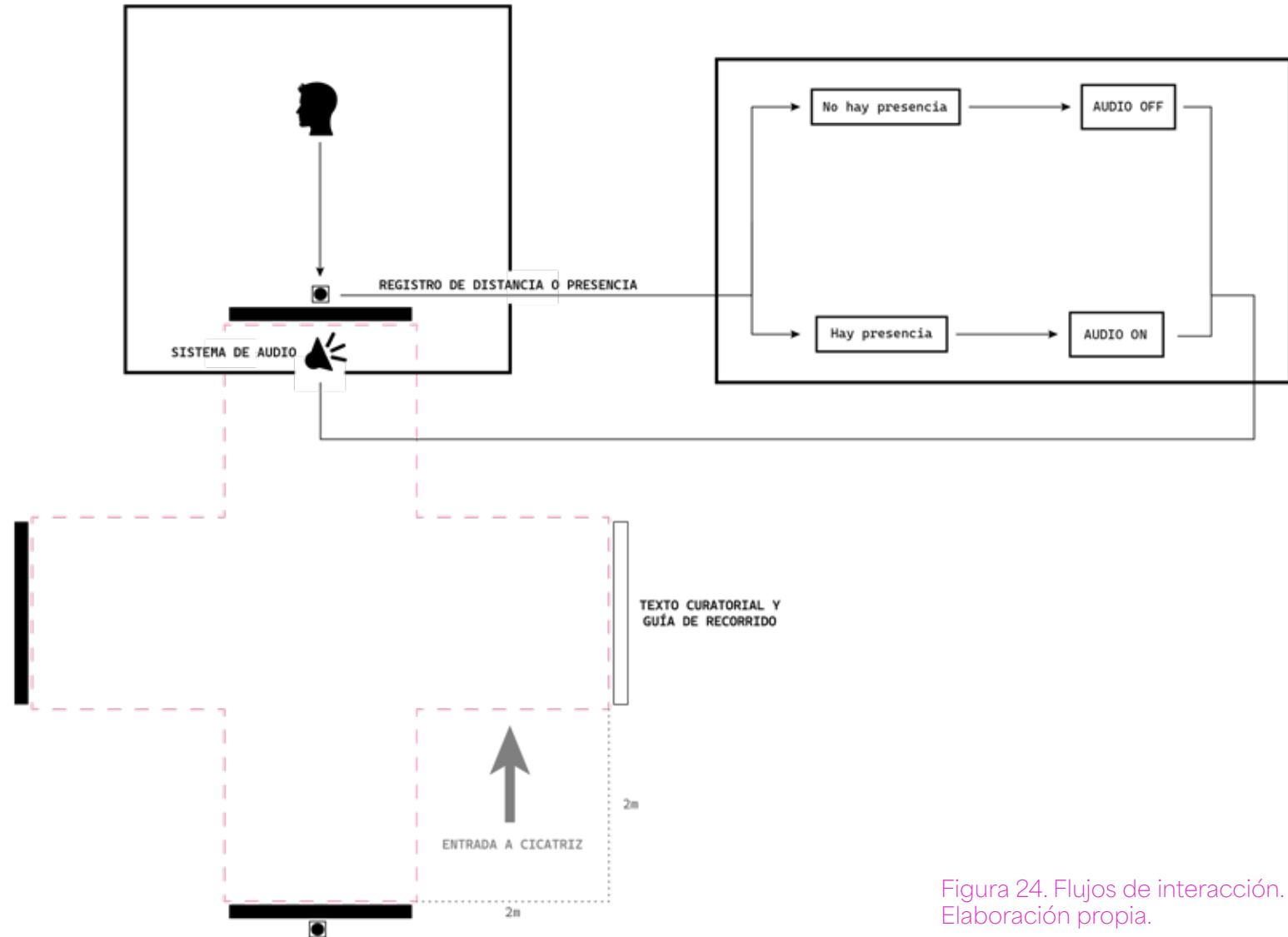


Figura 24. Flujos de interacción. Elaboración propia.

HC-SR04

En TouchDesigner, la lectura del HC-SR04 define un flujo en tiempo real. Cuando la distancia es menor o mayor a 300 cm, el sistema modifica parámetros visuales como opacidad, nitidez o distorsión y actualiza la pantalla inmediatamente. Esto permite que la imagen cambie según la proximidad del espectador y nunca permanezca completamente fija.

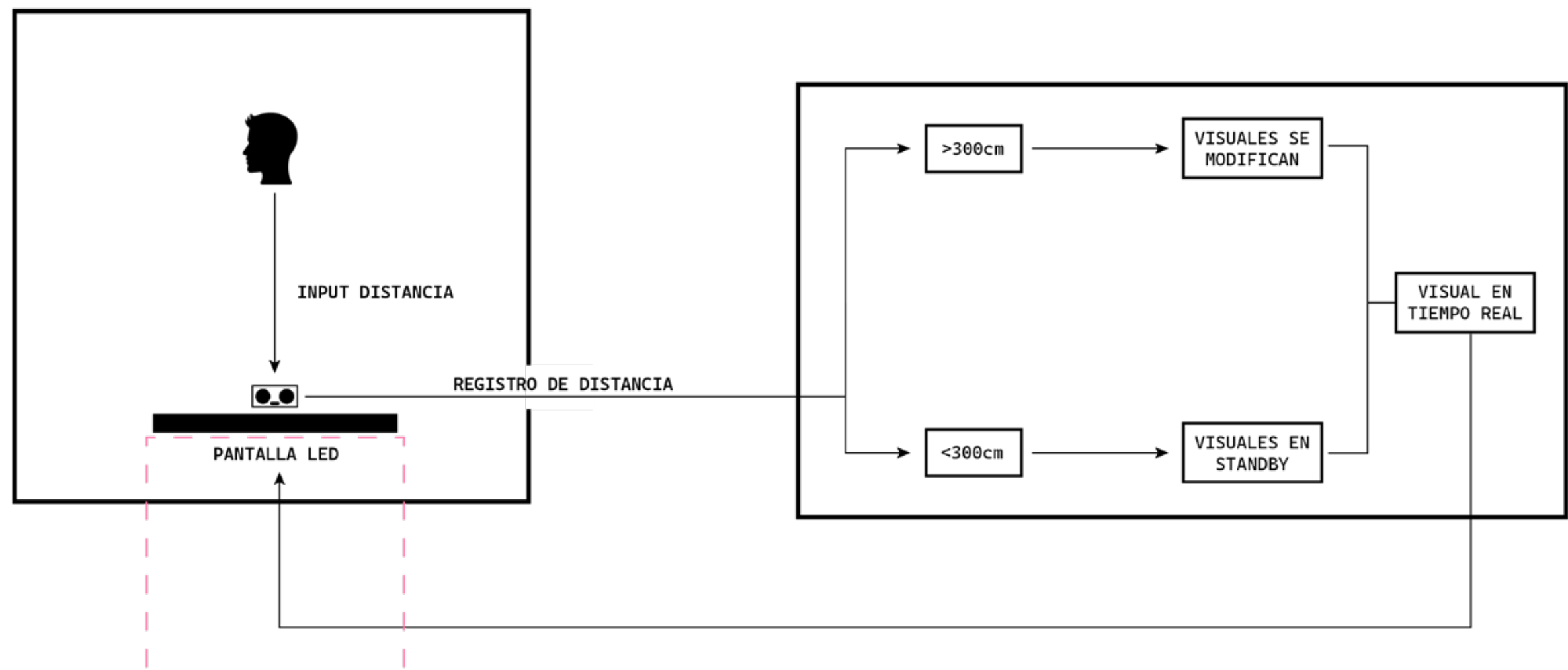


Figura 25. Flujos de interacción.
Elaboración propia.

Sensores

El circuito se organiza en torno a un Arduino Uno que actúa como el punto de encuentro entre los distintos sensores distribuidos en la instalación. Desde aquí se alimentan y coordinan dos sensores PIR y un HC-SR04, todos conectados a una misma línea de 5 V y a una masa común que asegura estabilidad en recorridos de cable más largos. Cada PIR registra la presencia de un cuerpo y envía esa señal directamente al Arduino, mientras que el HC-SR04 opera mediante un sistema de disparo y eco que permite medir distancia con precisión.

Comportamiento del sistema

El sistema se activa a partir de la presencia y el movimiento del espectador, quienes operan como detonantes directos de las variaciones audiovisuales de la instalación. Cada sensor cumple un rol específico dentro de este comportamiento: los PIR detectan irrupciones o apariciones súbitas, mientras que el HC-SR04 registra la distancia y permite interpretar acercamientos más graduales. Estas señales llegan al Arduino en tiempo real, que las procesa y las envía a TouchDesigner como datos continuos o binarios según el tipo de sensor.

En TouchDesigner, estos datos se traducen en modificaciones de la imagen y en ajustes sonoros que acompañan la atmósfera de cada estación. El sistema responde de manera inmediata, pero no rígida: cada parámetro está calibrado para que la reacción sea coherente con el tono emocional del eje temático donde ocurre. De este modo, el comportamiento técnico no funciona como un efecto aislado, sino como una extensión del relato.

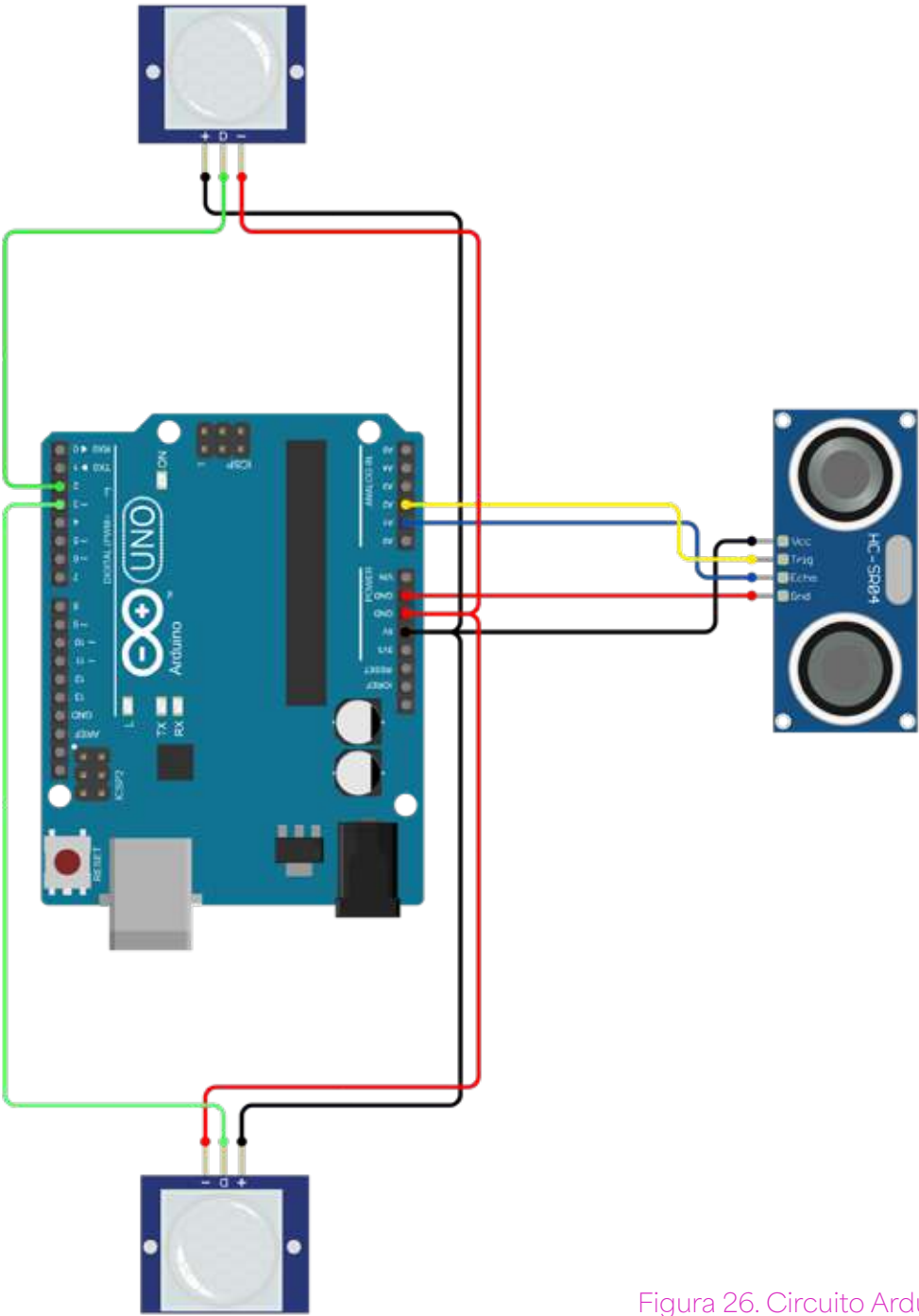


Figura 26. Circuito Arduino.
Elaboración propia.

LENGUAJE VISUAL DEL PROYECTO

CÓDIGOS FORMALES

Lenguajes desde la experiencia

La propuesta visual del proyecto se construye a partir de un conjunto de conceptos basados en los ejes temáticos que orientan la atmósfera, el tono y la materialidad de todas las piezas audiovisuales y espaciales. Estos conceptos funcionan como lineamientos que permiten articular la sensibilidad de los testimonios con un lenguaje visual coherente, capaz de transmitir las tensiones y transiciones que conforman la experiencia seropositiva.

Fragmentación:

Permite representar estados de confusión, ruptura y discontinuidad emocional. Se traduce en imágenes divididas, desfasadas o inestables, y en cortes abruptos que interrumpen la continuidad visual.

Distorsión:

Metáfora visual del impacto del diagnóstico y del efecto del estigma sobre la percepción del propio cuerpo. Se trabaja mediante variaciones de nitidez, interferencias, ruidos digitales y superposiciones.

Silencio visual:

Se construye a través de imágenes limpias, estables y de ritmo pausado. Actúa como contrapunto emocional frente a la intensidad de HERIDA.

Cuerpo como superficie:

El cuerpo aparece no como protagonista figurativo, sino como presencia simbólica. A través de siluetas, sombras o capas difusas, el cuerpo se convierte en territorio de vulnerabilidad, deseo y reconocimiento.

Interferencia:

Remite al funcionamiento del estigma: aquello que aparece y perturba sin aviso. Se expresa mediante saltos, duplicaciones, glitches y variaciones sonoras que irrumpen en momentos específicos.

Intimidad atmosférica:

El proyecto busca generar una cercanía emocional entre espectador y testimonios. Esto se logra a través de planos medios cortos, sonidos respirados, silencios prolongados y texturas suaves que sostienen la escucha.

Transparencia narrativa:

Cercanía emocional entre espectador y testimonios. Esto se logra a través de planos medios cortos, sonidos respirados, silencios prolongados y texturas suaves que sostienen la escucha.

Los códigos formales del proyecto se articulan desde la relación entre los conceptos que emergen de los testimonios y del análisis cualitativo. Organizan la traducción visual de los conceptos definidos en la etapa narrativa.

Estas decisiones establecen la estructura del conjunto audiovisual y permiten tener una relación coherente entre imagen, sonido, espacio y espectador.

Etapas 1: HERIDA

Imagen:
Fragmentación de la figura mediante duplicaciones, desplazamientos y cortes irregulares.
Distorsiones y variaciones de nitidez.
Superposiciones y transparencias para generar desorientación perceptiva.
Uso de composiciones verticales y planos medios cortos.
Texto integrado mediante subtítulos.

Color y luz:
Paleta fría de altos contrastes.
Iluminación intermitente, con zonas de sombra densa.

Sonido:
Respiraciones profundas, pulsos irregulares, capas sonoras superpuestas.
Fragmentos de voz tratados con interferencias.

Ritmo y temporalidad:
Cortes abruptos, secuencias breves y variaciones de velocidad.
Ritmo visual no lineal.

Etapas 2: CICATRIZ

Imagen:
Captura estable y limpia, sin intervención de distorsión.
Transiciones suaves entre escenas.
Texturas atmosféricas suaves para sostener una sensación de calma.
Texto integrado mediante subtítulos.

Color y luz:
Paleta cálida, homogénea y luminosa.
Luz difusa con blancos cálidos.

Sonido:
Voces claras sin interrupciones.
Presencia de silencios como espacio de contención.

Ritmo y temporalidad:
Secuencias largas con continuidad visual.

Referentes visuales por eje temático

Los referentes audiovisuales seleccionados permiten situar el proyecto dentro de un marco estético y expresivo que dialoga con prácticas contemporáneas del videoarte, la manipulación digital y la experimentación con la imagen. Cada referencia aporta un enfoque específico sobre fragmentación, superposición, distorsión o corporalidad, elementos fundamentales para construir la atmósfera visual de los ejes de HERIDA y CICATRIZ.

Estas obras no se integran como modelos a imitar, sino como puntos de análisis que orientan decisiones formales, rítmicas y conceptuales en la elaboración de las cápsulas audiovisuales.

REFERENTES VISUALES: DIAGNÓSTICO



Outer space (1999) - Peter Tscherkassy.

Obra audiovisual que consiste en la manipulación de rollos de video con superposiciones, logrando un efecto visual que genera incomodidad, además del audio que acompaña la obra con sonidos fuertes que transmiten una tensión entre el espectador y la misma obra audiovisual.



Silver (2011) - Takeshi Murata.

Toma extractos de una película de terror para transformarlos en una violenta manipulación digital.

La imagen constantemente se descompone y vuelve a reconstruirse, fluyendo entre la abstracción y el reconocimiento.

REFERENTES VISUALES: ESTIGMA



Película interactiva creada a partir de fragmentos de películas perdidas de los años 20, con superposición de escenas regrabadas por el autor.

La obra se caracteriza por abruptas transiciones entre las distintas escenas y cómo se entrelazan creando una sola narrativa.



Seances (2016) - Guy Maddin.



Obra audiovisual donde se tensionan dos perspectivas entre una pareja superponiendo ambas imágenes, exponiendo una dominancia entre ambos relatos.



Superimposition (1975) - Marjorie Keller.

REFERENTES VISUALES: CUERPO



Arreglo de diferentes cámaras componen una sola visual a partir de la unión de dos personas, enfatizándose en la artificialidad y la arbitrariedad de la identificación de personas en los medios masivos.



Redundant Assembly (2015) - Rafael Lozano.



Conjunto de videos compuestos de una bailarina detrás de un vidrio arenado.

El vidrio actúa como una barrera simbólica entre lo privado y lo público, desindividualizando el cuerpo y transformándolo en un símbolo.



Frosted-window dancing (2023) - Piotrek Naumowicz.

REFERENTES VISUALES: APOYO Y FUTURO



Capítulo enfocado en la profundidad de un personaje, principalmente se caracteriza por la iluminación, el tipo de enfoque de las escenas y cómo logra capturar las emociones del personaje.

*Euphoria (2021) -
Sam Levinson, Hunter Schafer.*



Proyecto chileno, expone manifiestos de la vivencia con VIH en el país con imágenes calmadas, colores cálidos y claridad visual, sin dejar de lado la profundidad narrativa del corto.

*Oceanos víricos (2020) -
Kevin Magne Tapia*

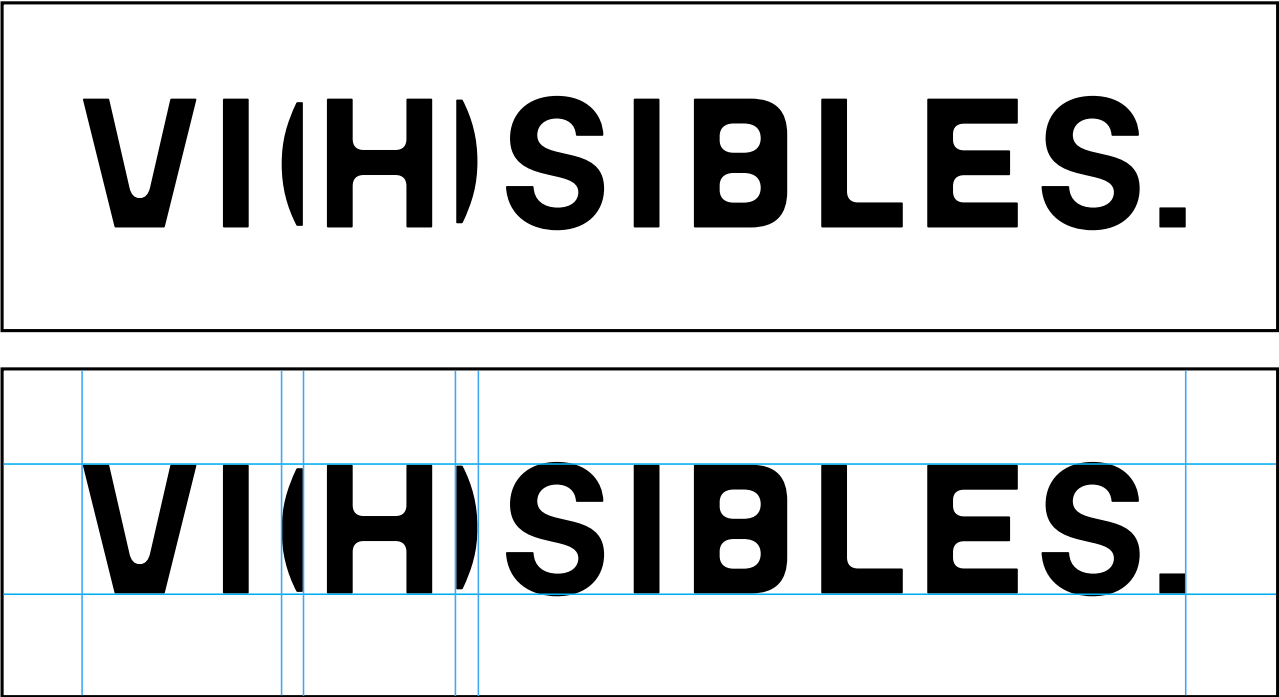
IDENTIDAD GRÁFICA

Recursos visuales

Logotipo y naming

El logotipo estructura su construcción tipográfica a partir de una composición que enfatiza presencia y afirmación. La adición del paréntesis (H) funciona como gesto identitario, aludiendo a las personas que viven con VIH integrando su presencia en el espacio desde la afirmación y no desde el estigma.

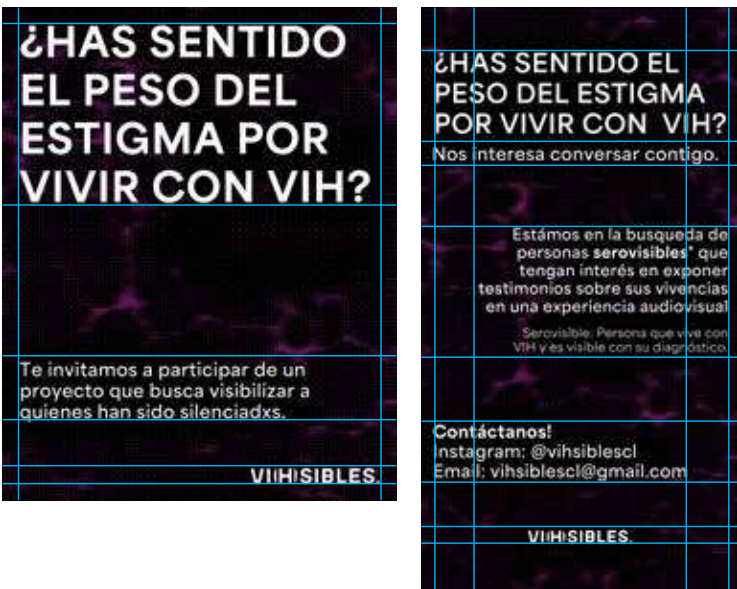
El nombre tensiona la palabra visibles, introduciendo una interrupción mínima pero significativa que propone una nueva lectura y desplaza el imaginario negativo asociado al virus.



Logotipo sobre paleta cromática.



Grilla RR.SS.



Paleta tipográfica.

AREA NORMAL EXTRABOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
WXYZ
1234567890

Area Normal SemiBold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Tratamiento de imagen.



Identidad de marca

La identidad gráfica del proyecto se sostiene en una paleta cromática vibrante y complementaria, que enfatiza magentas, verdes y violetas para expresar la rareza y la energía que atraviesan las personas visibles, sin perder legibilidad ni contraste.

La tipografía Area Normal, en pesos diferenciados, refuerza esta presencia afirmativa y permite jerarquizar la información con claridad.

El uso de grillas estructuradas pero con desplazamientos y cambios de ritmo en la lectura alude directamente al proyecto, un sistema ordenado que, sin dejar de ser legible, incorpora quiebres y desajustes que remiten a las fracturas y recomposiciones presentes en los testimonios.

Decisiones audiovisuales

Las decisiones audiovisuales del proyecto se construyen desde una intención sensible y no meramente técnica, cada elemento visual se organiza para sostener una emoción específica dentro del recorrido.

La paleta cromática, los niveles de luz y las texturas se definieron a partir de moodboards que ordenan sensaciones y atmósferas, permitiendo reconocer los estados que atraviesan los testimonios y traducirlos en códigos formales.

DIAGNÓSTICO.

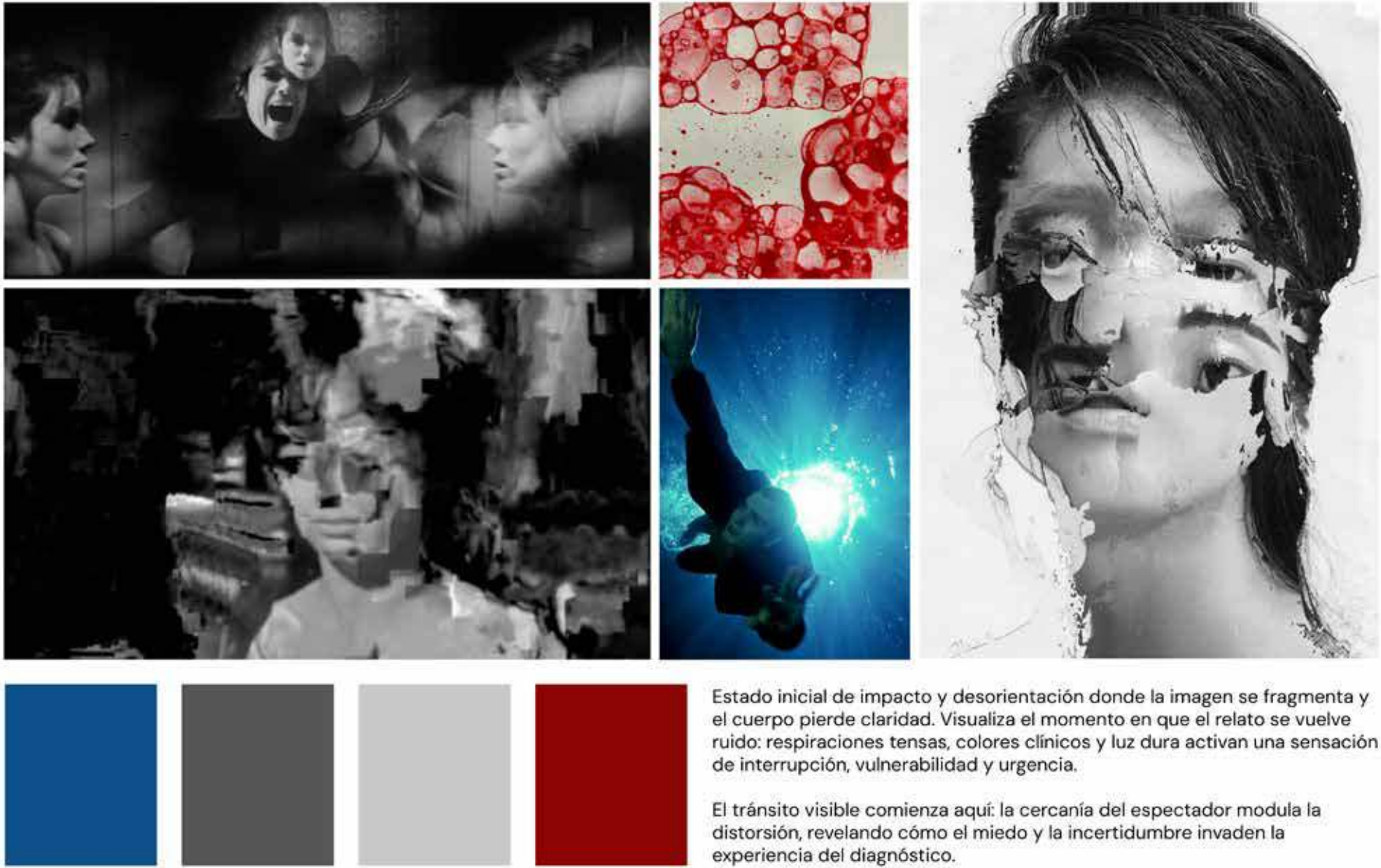


Figura 27. Moodboard audiovisual.
Elaboración propia.

STYLEFRAMES DIAGNÓSTICO

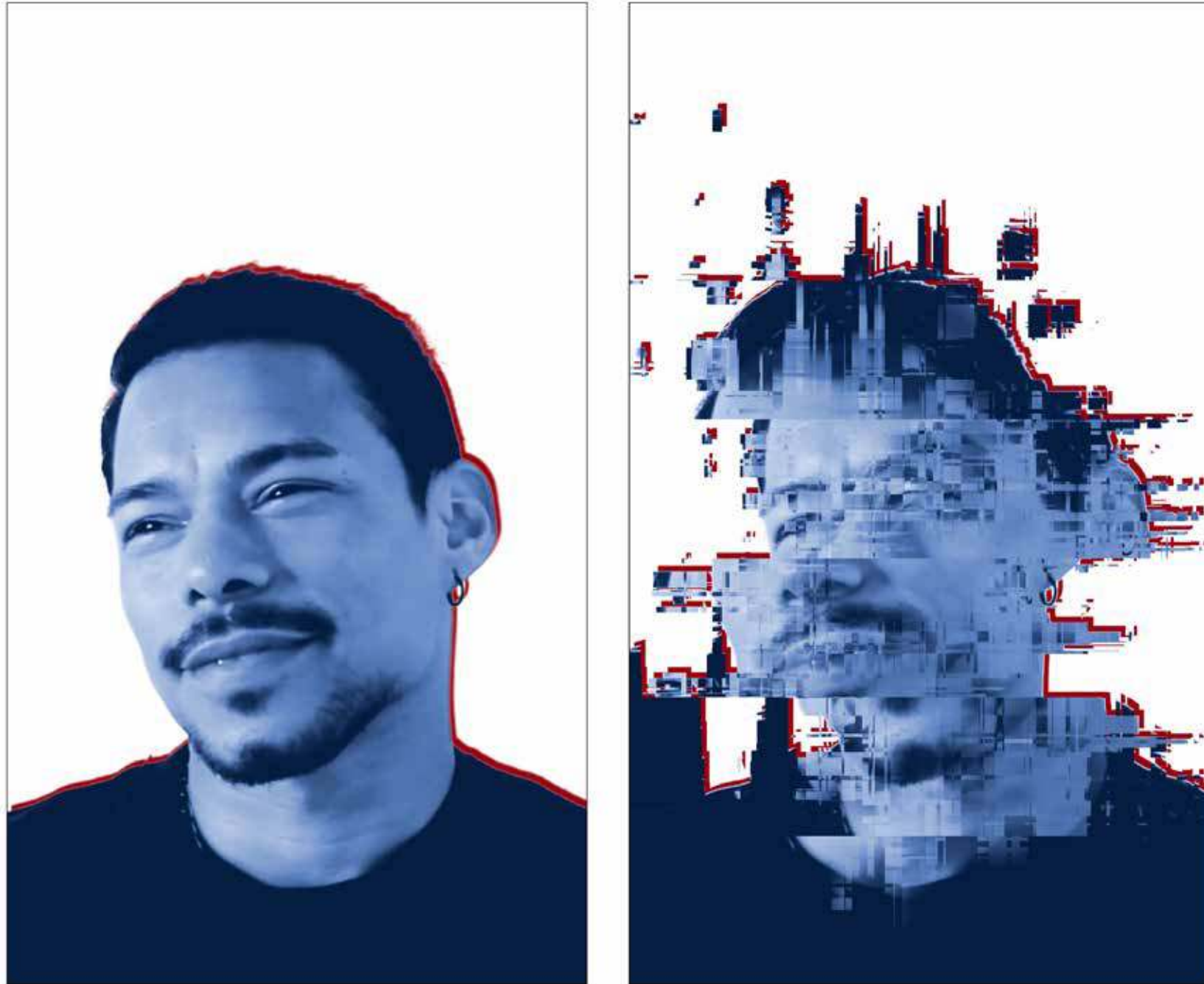
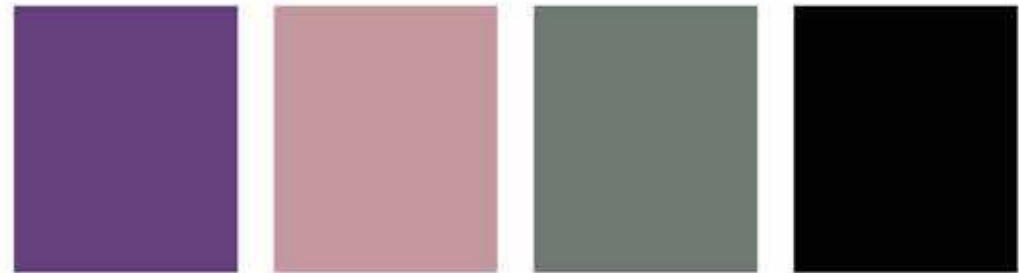


Figura 28. Styleframe audiovisual.
Elaboración propia.

ESTIGMA Y SILENCIO.



Figura 29. Moodboard audiovisual.
Elaboración propia.



Paisaje visual claro que se fractura al tocar temas sensibles, evocando las interrupciones emocionales que provoca el estigma. Superposiciones, sombras y texturas inestables encarnan el peso del silencio impuesto, mientras voces desordenadas construyen un ambiente incómodo e invasivo.

La estética subraya cómo el estigma opera como interferencia: algo que irrumpe, desordena y marca territorio dentro del cuerpo y la memoria.

STYLEFRAMES ESTIGMA



Figura 30. Styleframe
audiovisual.
Elaboración propia.

CUERPO Y VULNERABILIDAD.



Figura 31. Moodboard audiovisual.
Elaboración propia.



Una atmósfera blanda y difusa donde el cuerpo aparece como territorio en descubrimiento. Borrosidad, pulsaciones y transparencias dialogan con la intimidad que revelan los testimonios. La silueta del espectador se convierte en la puerta de acceso al relato, estableciendo una conexión corporal directa con la vulnerabilidad compartida.

Este eje comprende el cuerpo como espacio sensible, expuesto y también liberador, donde la fragilidad convive con el autoconocimiento.

STYLEFRAMES CUERPO



Figura 32. Styleframe
audiovisual.
Elaboración propia.

APOYO Y CONTENCIÓN / FUTURO Y REESCRITURA.

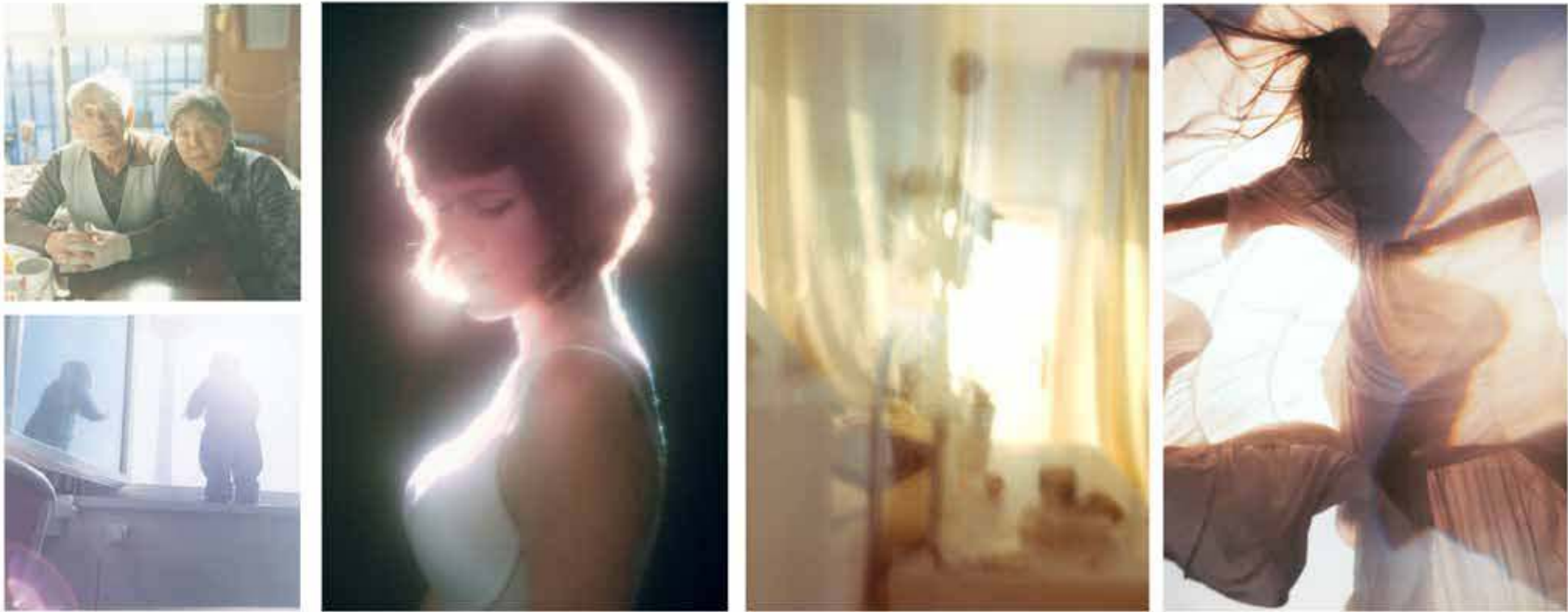


Figura 33. Moodboard audiovisual.
Elaboración propia.



Espacio donde la contención colectiva y la proyección hacia el mañana se entrelazan en un mismo gesto de reconstrucción. La atmósfera se vuelve clara, cálida y pausada, distanciándose del ruido emocional de la herida para abrir un territorio visual de calma y dignidad.

Estos ejes proponen una estética de reparación: luz suave, colores que evocan encuentro y materiales que respiran continuidad. La experiencia deja atrás la intervención directa para invitar a la contemplación, simbolizando un tránsito hacia la cicatriz como signo de vida, aprendizaje y permanencia.

STYLEFRAME APOYO Y FUTURO



Figura 34. Styleframe audiovisual.
Elaboración propia.

IMPLEMENTACIÓN

PLANIFICACIÓN DE RODAJES

Estrategia y coordinación

La planificación de rodajes se definió considerando tanto las necesidades técnicas del proyecto como la disponibilidad y ubicación de las personas entrevistadas.

En un comienzo, se planeó realizar todas las grabaciones de forma presencial en Santiago, sin embargo, la convocatoria recibió el interés de participantes residentes en Antofagasta y Puerto Montt. Esta respuesta permitió ampliar el alcance del proyecto y descentralizar el proceso, incorporando entrevistas remotas para asegurar que ninguna persona quedara fuera por razones geográficas. Esta decisión buscó sostener el principio de visibilidad en un sentido amplio, evitando limitar la participación únicamente a la capital.

Para las entrevistas presenciales se estableció un formato estándar de registro: grabación vertical, fondo blanco y plano medio corto. Esta configuración permite una manipulación más precisa en postproducción, facilita la integración del material dentro de la propuesta audiovisual y mantiene coherencia visual entre todos los registros. Las grabaciones se realizaron con cámara digital y un sistema de iluminación neutro, cuidando que los tonos y contrastes fueran adecuados para el posterior trabajo de edición.

Las sesiones presenciales se realizaron en dos lugares: la oficina de Fundación Chile Positivo y el domicilio de uno de los entrevistados, priorizando siempre comodidad, privacidad y acompañamiento emocional.

En el caso de las entrevistas remotas, se procuró replicar el formato visual dentro de las posibilidades técnicas de cada participante, guiando ajustes de encuadre, iluminación y estabilidad de imagen. Aunque estas sesiones presentan limitaciones propias de la grabación a distancia, su incorporación permitió ampliar la diversidad territorial de los testimonios y mantener coherencia con los criterios estéticos definidos.



Figura 35. Frames limpios de entrevistas.
Elaboración propia.

POSTPRODUCCIÓN

Edición del contenido

El proceso de edición organiza los testimonios como materia sensible. Las entrevistas, que originalmente duran entre 20 y 30 minutos, se condensan en cápsulas de 2 a 4 minutos, no para simplificarlas, sino para concentrar aquello que sostiene la experiencia emocional del proyecto. En esta etapa se organizan los núcleos discursivos, la duración de planos y los puntos de corte que articulan continuidad, interrupción o transición.

En After Effects se construye la visualidad que articula cada cápsula: capas que se fragmentan, variaciones de nitidez que aparecen y desaparecen, superposiciones que evocan interferencias y modulaciones lumínicas que acompañan el estado emocional del relato.

El sonido se trabaja como parte del montaje con voces limpias, respiraciones amplificadas, pulsos, silencios prolongados y pequeños ruidos de fricción sostienen la atmósfera de cada etapa.

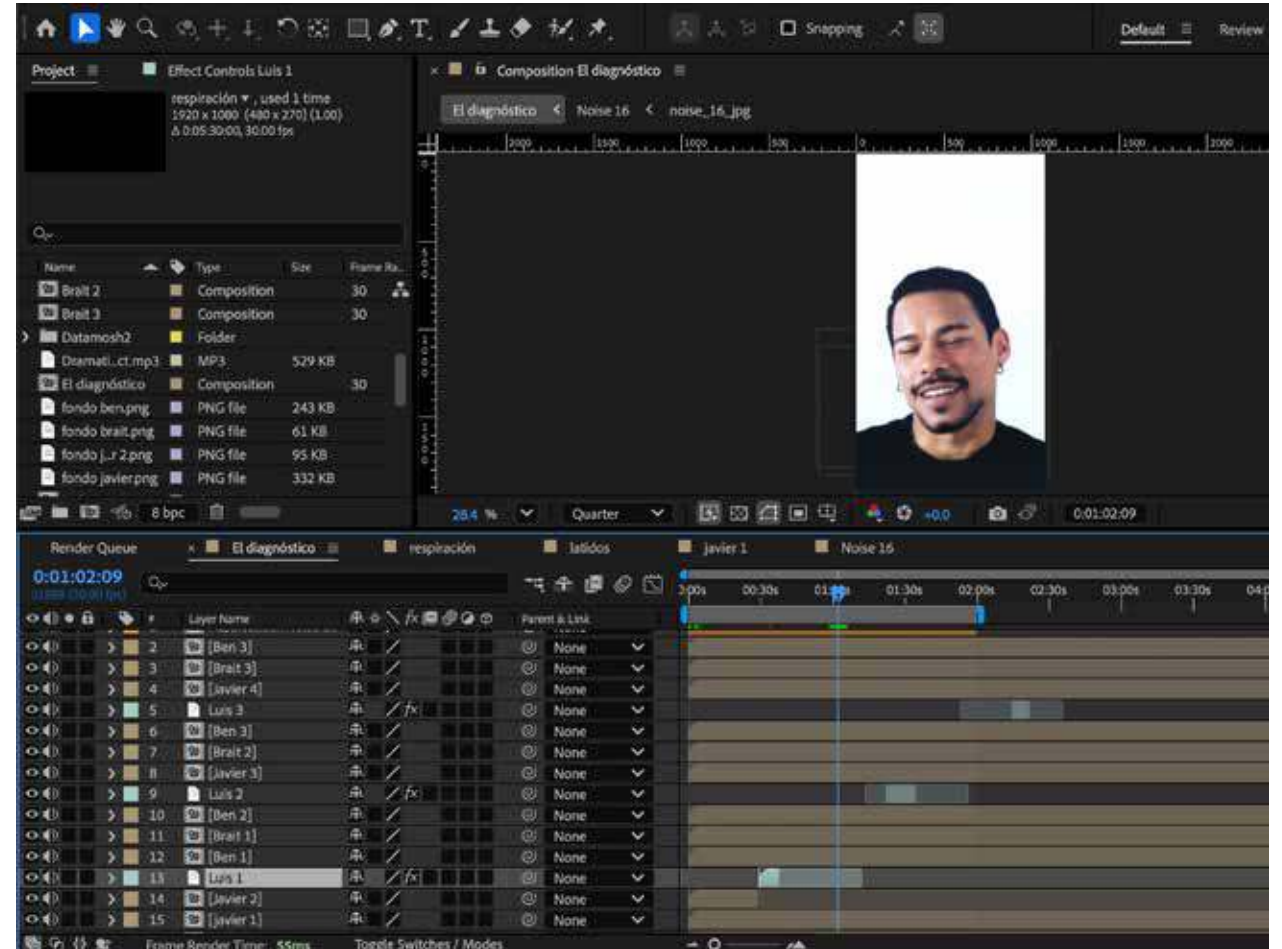


Figura 36. Flujo de trabajo en After Effects. Elaboración propia.

DESARROLLO INTERACTIVO

Lógica del sistema

TouchDesigner extiende este lenguaje hacia el espacio físico. La manipulación en tiempo real, ligada a la distancia o presencia del espectador alimentada por Arduino, introduce la posibilidad de que la imagen responda al cuerpo presente.

Opacidad, distorsión, desplazamiento y efectos visuales que se alinean con las decisiones gráficas se vuelven variables vivas que revelan la tensión entre visibilidad e invisibilización, eje central del proyecto.

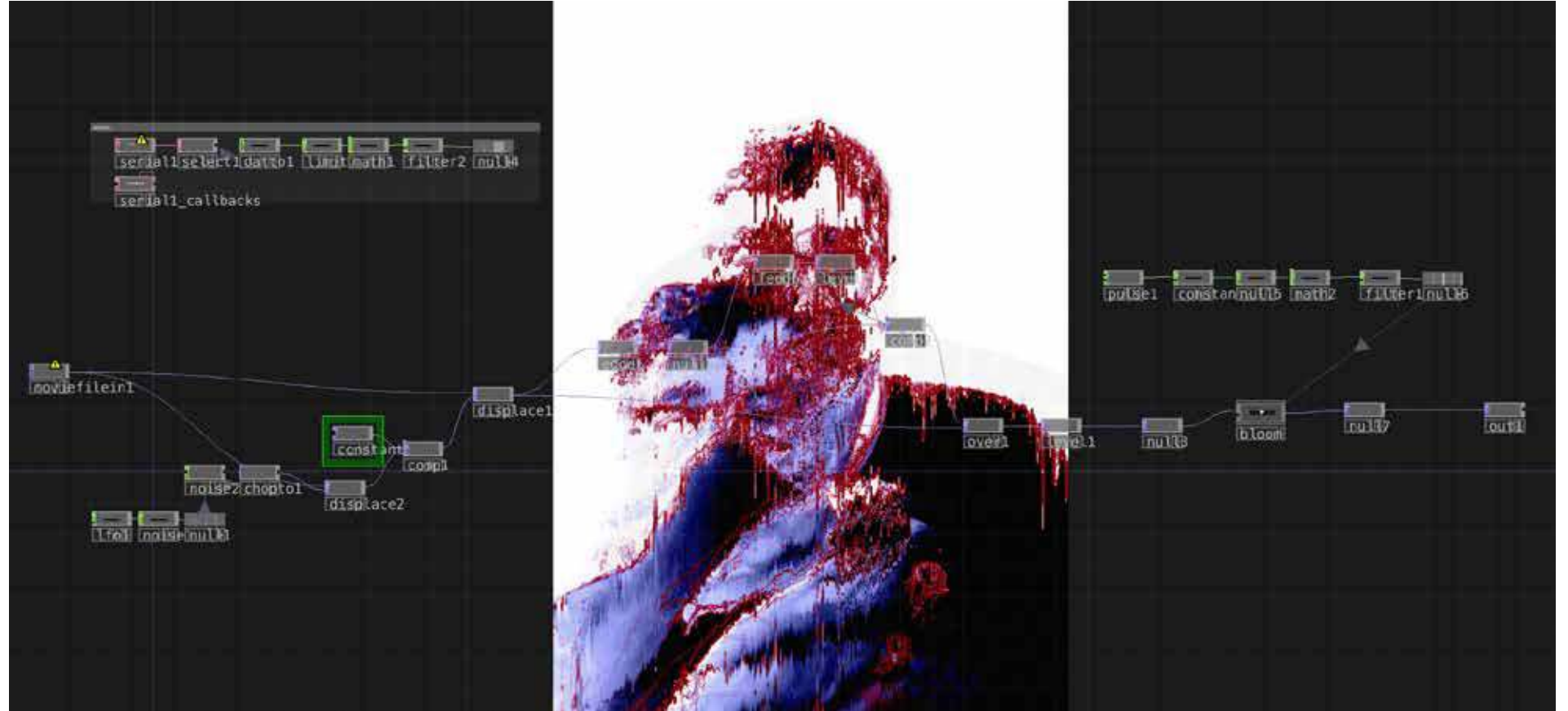


Figura 37. Flujo de trabajo en TouchDesigner. Elaboración propia.

PROPUESTA EXPOSITIVA

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Estructura espacial

La instalación se organiza a partir de una estructura con forma de cruz, concebida como un dispositivo espacial que articula el tránsito entre distintos estados emocionales vinculados a las vivencias del VIH en Chile.

Su disposición guía al espectador desde un recorrido externo, compuesto por cuerpos laterales que funcionan como estaciones individuales, hacia un espacio interior que concentra el cierre experiencial.

La forma de cruz no remite a lo religioso, sino que funciona como una alusión directa a la experiencia seropositiva: una figura de intersección y fractura donde convergen las tensiones, los silencios y las posibilidades de reconstrucción presentes en los testimonios recopilados.

ETAPAS

Secuencia emocional

HERIDA.

Herida corresponde al primer tramo del recorrido dentro de la instalación, ubicado en las alas externas de la estructura con forma de cruz. Esta etapa aborda el tránsito inicial entre el diagnóstico, el estigma y la relación con el cuerpo, explorando el impacto emocional y social del VIH desde la vulnerabilidad, el miedo y el silencio. Visualmente, se presenta como un espacio frío, duro e incómodo, donde la materialidad expuesta, esquinas rígidas, cableado visible y superficies metálicas, refuerzan una estética brutalista que enfatiza la crudeza del tema.

En cada eje temático se dispone una pantalla LED vertical acompañada de sensores y una pantalla secundaria con texto. La elección de la verticalidad proviene del estudio de referentes y busca generar una instancia más íntima y directa con los testimonios. Cada eje está diseñado para ser utilizado por una sola persona a la vez, permitiendo que el espectador se enfrente individualmente al relato y establezca un vínculo personal con la imagen y la voz. Esta disposición configura un espacio de reconocimiento e intimidad donde el cuerpo del espectador se vuelve parte de la lectura sensorial del estigma.

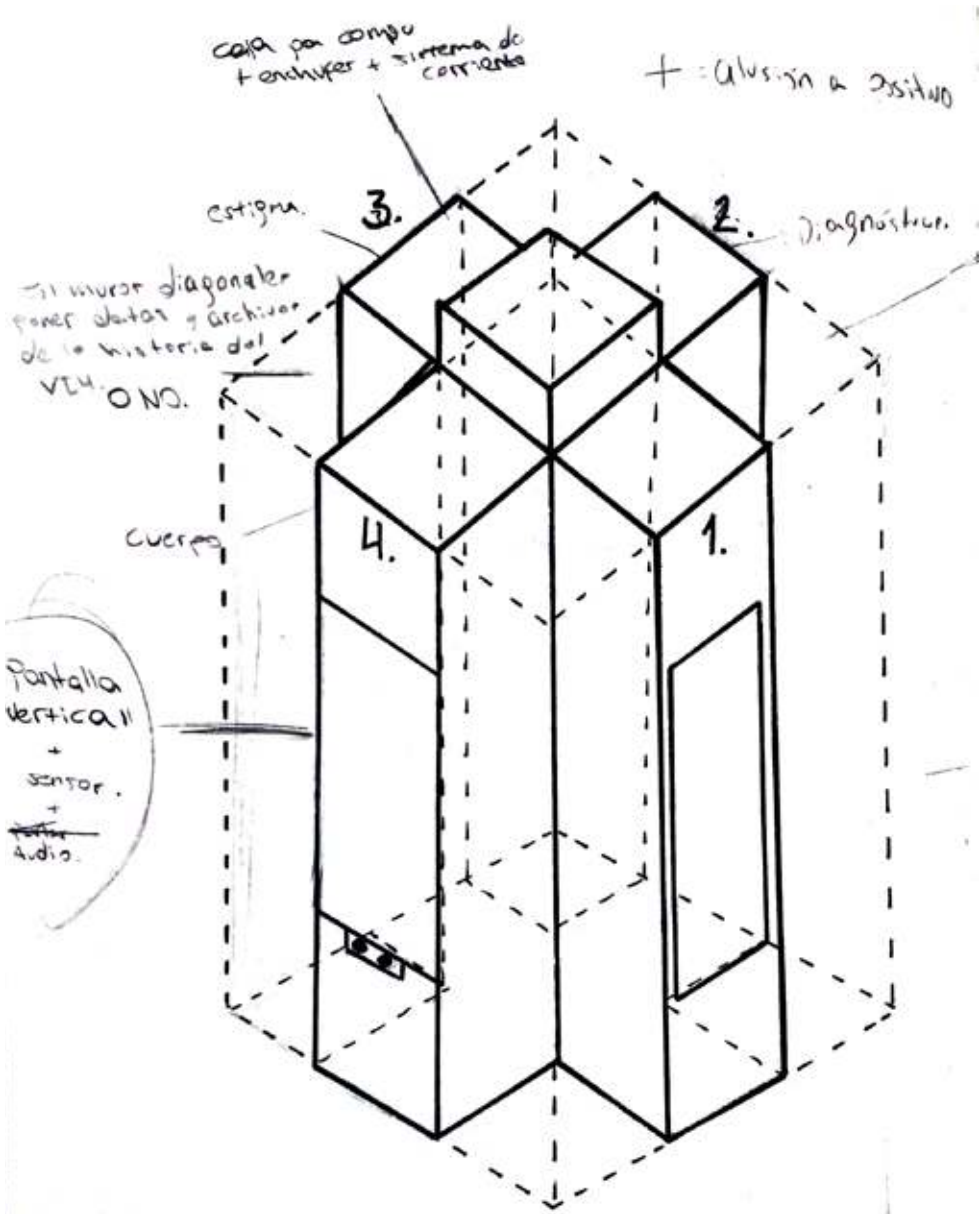


Figura 38. Croquis inicial instalación. Elaboración propia.

CICATRIZ.

Cicatriz se sitúa en el interior de la estructura y reúne los ejes de apoyo y futuro, proponiendo un desplazamiento desde la dureza inicial hacia la afectividad, la reconstrucción y la esperanza. En esta etapa, el espectador ingresa al corazón de la instalación, relacionándose de manera directa con el relato en un ambiente que invita a la calma y la reflexión.

Visualmente, el espacio se manifiesta mediante claridad, un ritmo visual más pausado y una iluminación cálida que funciona como afirmación de existencia y dignidad. A diferencia de Herida, aquí no existe interacción directa: el espectador deja de “intervenir” y pasa a observar, permitiendo que el silencio opere como un cierre de ciclo, ya no como censura, sino como un gesto de paz.

El módulo interior está pensado como un lugar cómodo y acogedor, donde las personas pueden recostarse para contemplar las visuales proyectadas. Con una capacidad máxima de tres personas, se configura un espacio íntimo de contemplación afectiva. Cicatriz busca concluir la experiencia desde la serenidad y la humanidad, mostrando que la vida con VIH continúa más allá del diagnóstico y abriendo un horizonte de futuro posible y sin miedo.



Figura 39. Croquis primeras exploraciones. Elaboración propia.

PLANIMETRÍAS

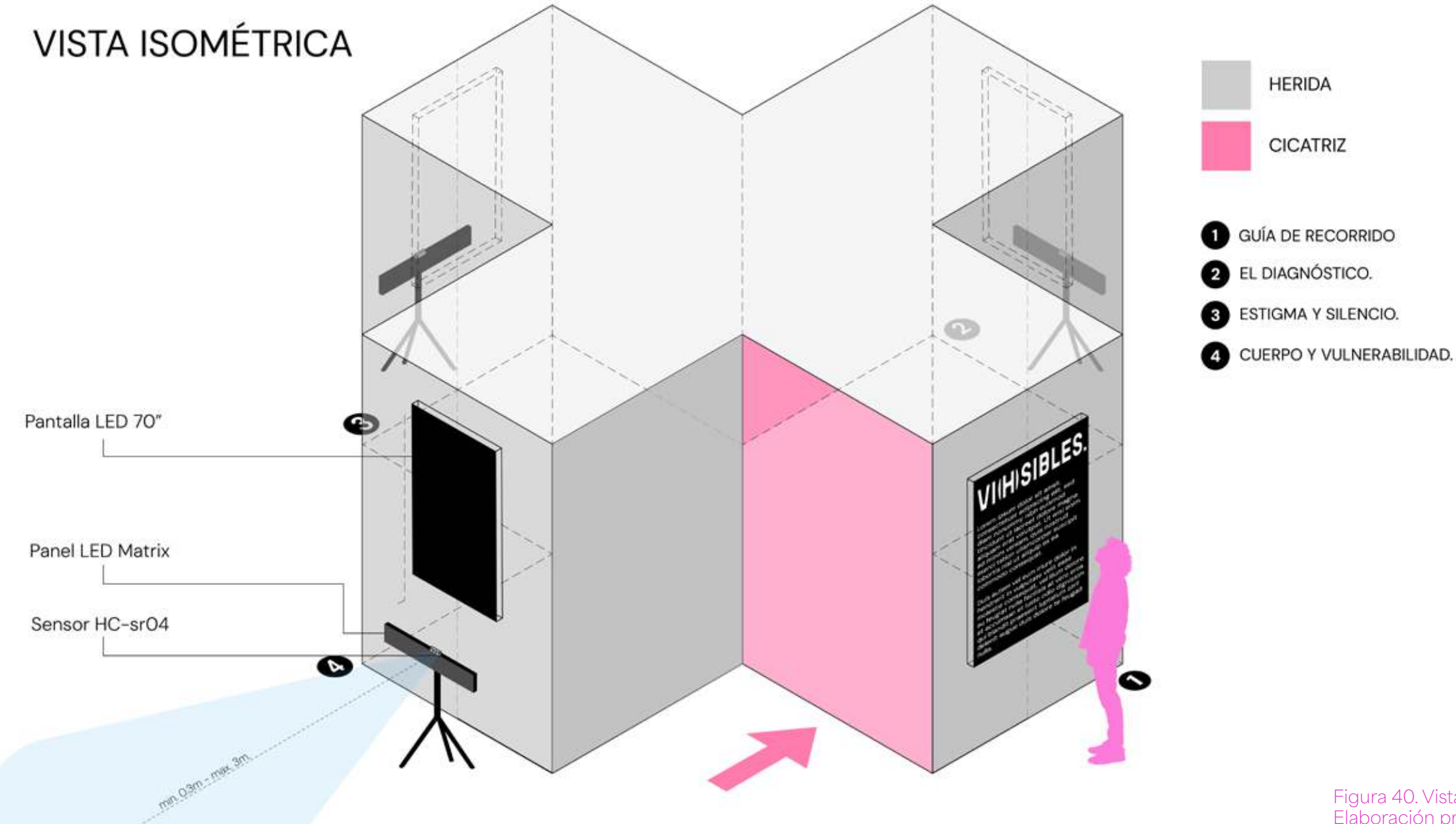
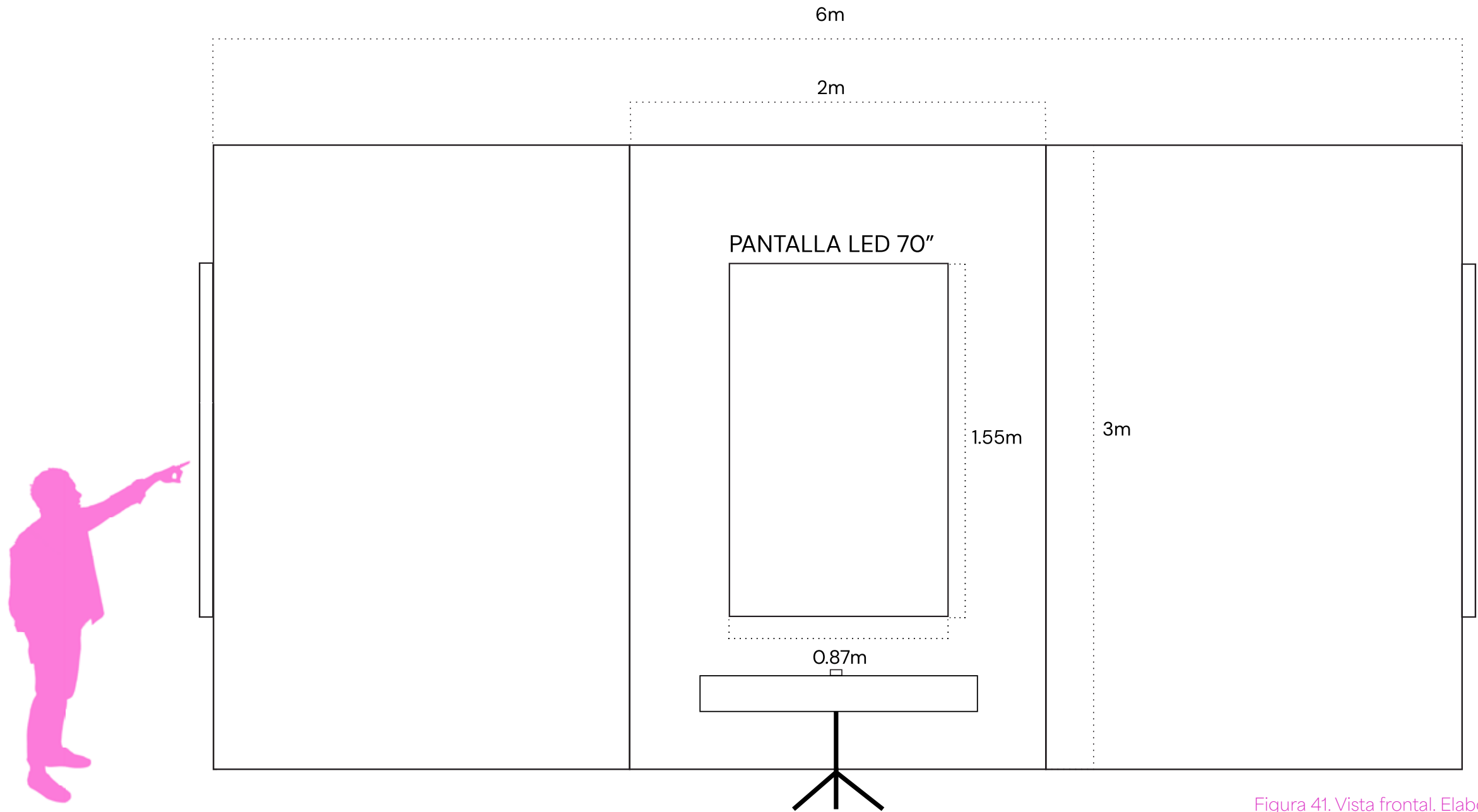
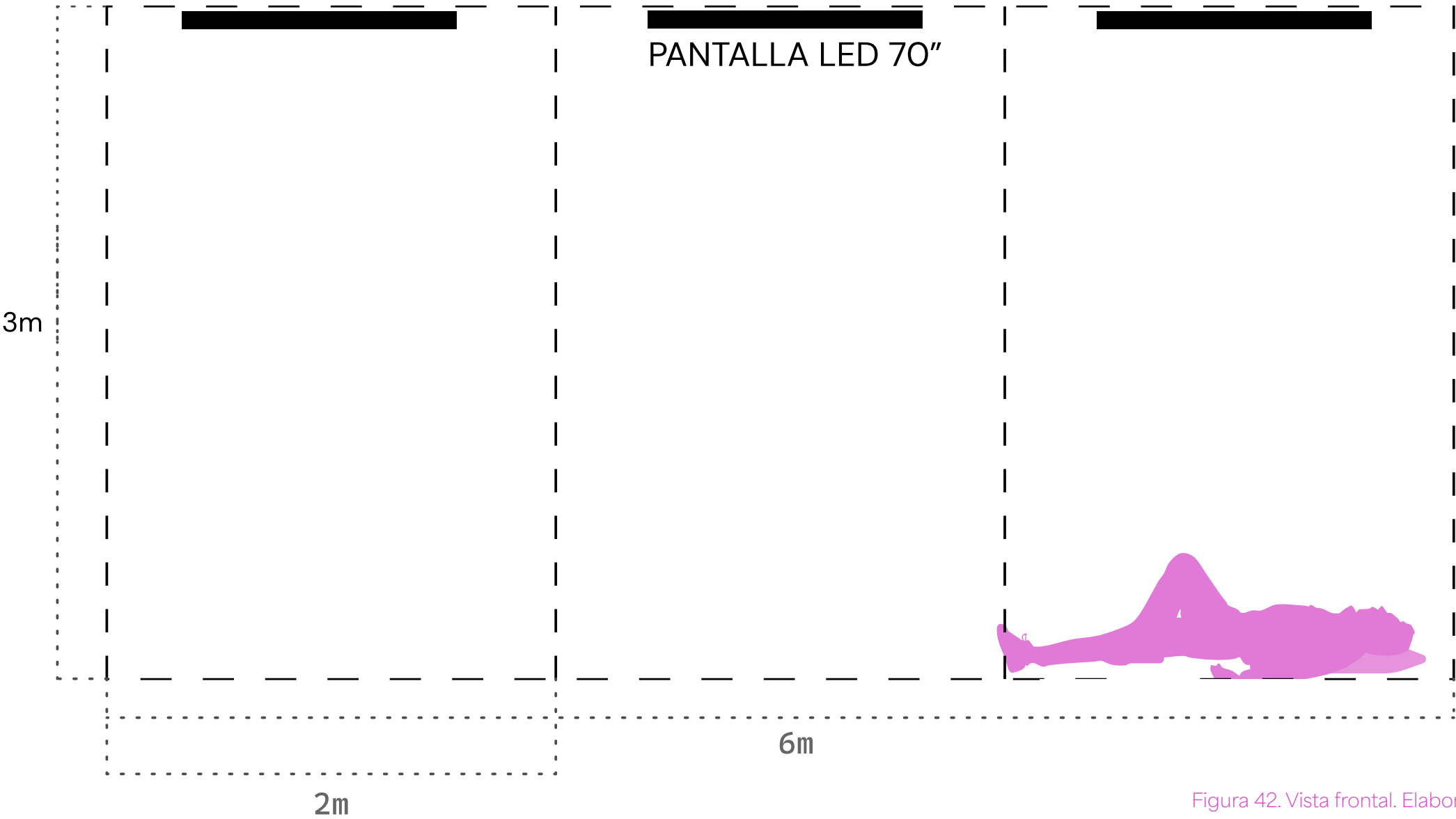


Figura 40. Vista isométrica.
Elaboración propia.

VISTA FRONTAL / HERIDA



VISTA FRONTAL / CICATRIZ



VISTA SUPERIOR

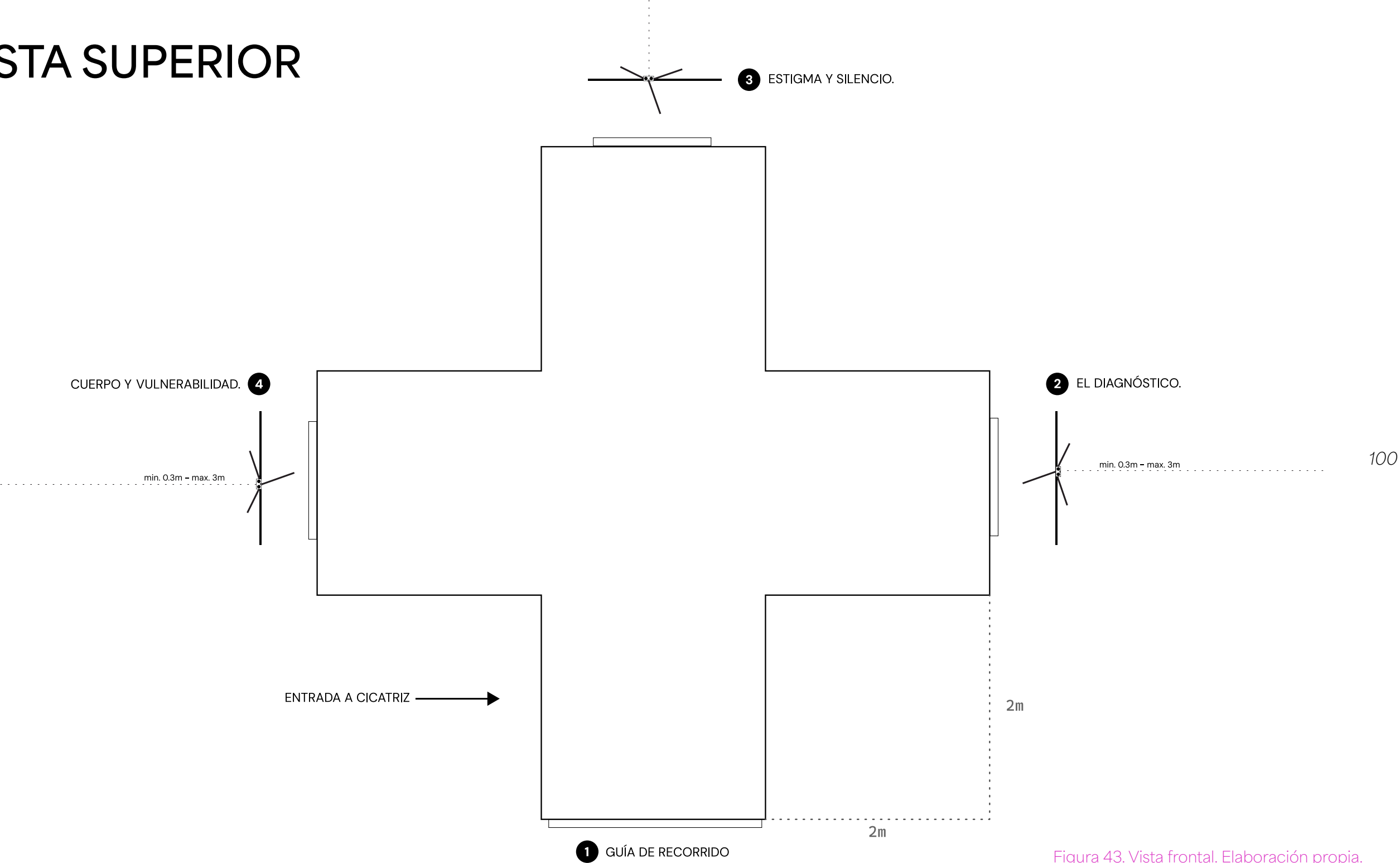


Figura 43. Vista frontal. Elaboración propia.

VISTA SUPERIOR / CICATRIZ

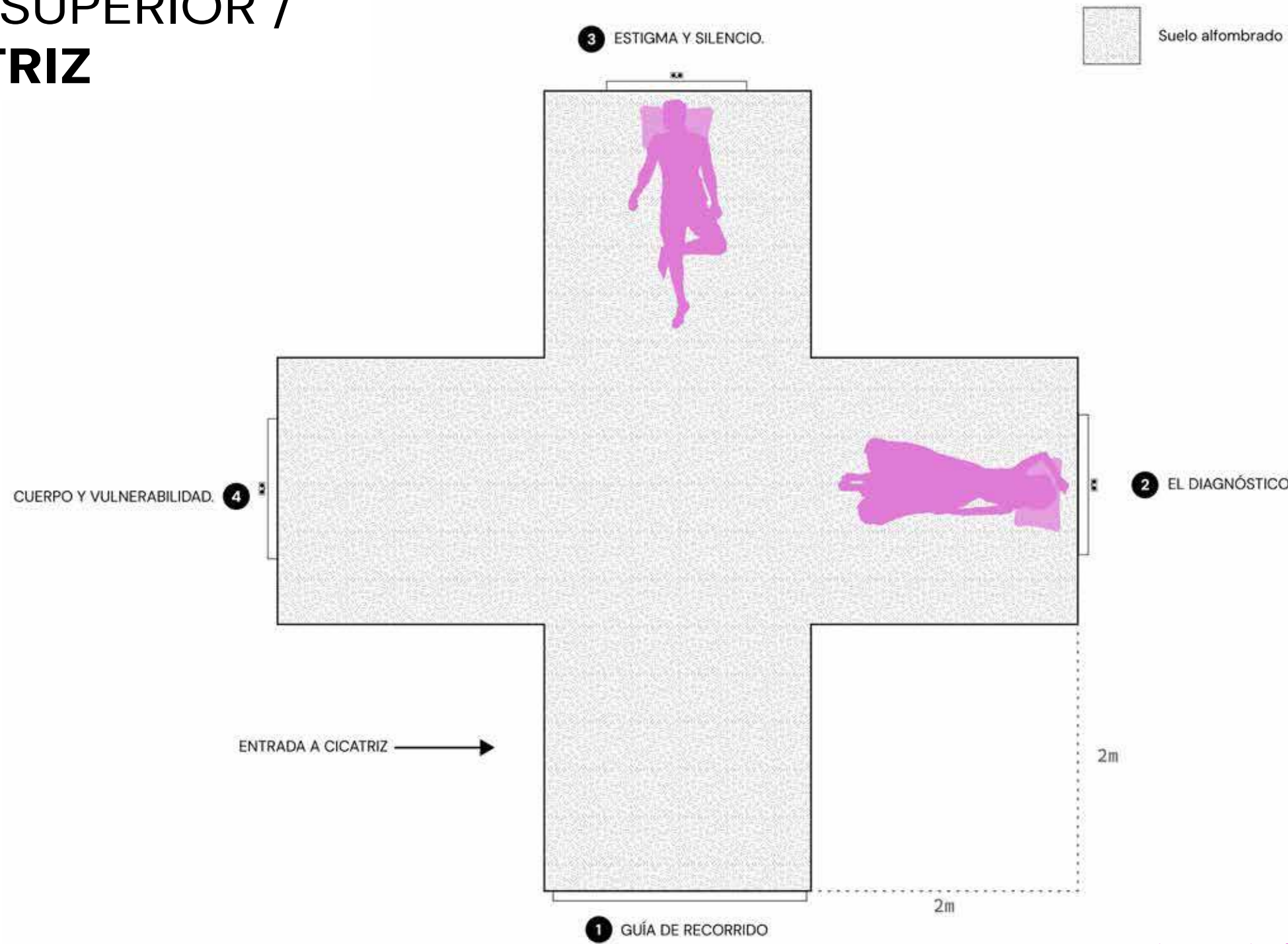


Figura 44. Vista frontal. Elaboración propia.

RENDER



DETALLES TÉCNICOS

Componentes y especificaciones

Construcción

La instalación se construye desde una lógica modular que organiza la estructura como un cuerpo que sostiene el tránsito emocional del proyecto. La forma de cruz, de 6 × 6 metros y 3 metros de altura, se compone de once muros: cuatro de acero perforado para las estaciones interactivas de HERIDA y siete paneles de MDF que cierran y contienen el espacio interior. Esta combinación equilibra rigidez y limpieza visual, permitiendo sostener dispositivos técnicos sin perder la atmósfera silenciosa que requiere CICATRIZ.

El armazón se resuelve con perfiles metálicos de 80×40×2 mm y refuerzos de 40×20×1,5 mm, unidos con pletinas y tornillería desmontable. Cada ala mantiene una dimensión estándar de 2 × 3 metros, facilitando repetición constructiva, orden y montaje.

En el interior, el cielo adquiere un rol central: tres pantallas LED de 70” se suspenden desde la estructura superior y cubren las tres alas de CICATRIZ. Esta elección asegura una visual nítida y estable para quienes se recuestan a mirar el contenido. El cableado queda oculto en la parte superior, preservando la intimidad del espacio.

En HERIDA, las estaciones integran un sensor ultrasónico HC-SR04 conectado a un Arduino, que registra la distancia del espectador y envía esos datos a TouchDesigner. Allí, la visual se ajusta en tiempo real mediante cambios de nitidez, opacidad o distorsión, convirtiendo la proximidad en un gesto que evidencia la tensión entre aparecer y desaparecer, núcleo del estigma que atraviesa el proyecto.

DIMENSIONES INSTALACIÓN	
PLANTA GENERAL	6m x 6m (forma cruz)
ALTURA MUROS	3m
ANCHO MUROS	2m
CANTIDAD DE MUROS	11

DETALLES INSTALACIÓN	
MUROS EN ZONAS CON PANTALLA	4 muros de acero al carbono perforado 3mm
MUROS EN ZONAS SIN PANTALLA	7 muros de MDF 9mm
ABERTURA HACIA CICATRIZ	Sin muro
SISTEMA PORTANTE	Steel frame soldado 80x40x2mm
SISTEMA SECUNDARIO	Perfilería 40x20x1.5mm
SOPORTE AUDIOVISUAL HERIDA	3 TV LED 70" Full HD
SOPORTE AUDIOVISUAL CICATRIZ	3 Pantallas LED 70" empotradas en cielo
INTERACCIÓN	Sensores HC-sr04, Arduino, webcam HD
SOFTWARE	TouchDesigner

DETALLES AUDIOVISUAL	
SOPORTE AUDIOVISUAL HERIDA	3 TV LED 70" Full HD
SOPORTE AUDIOVISUAL CICATRIZ	3 Pantallas LED 70" empotradas en cielo
INTERACCIÓN	Sensores HC-sr04, Arduino, webcam HD
SOFTWARE	TouchDesigner

VIABILIDAD DEL PROYECTO

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN

ESTRUCTURA PRINCIPAL (STEEL FRAME)			
TIPO	MATERIAL / MEDIDAS	UDS.	PRECIO
PERFILES ESTRUCTURALES	Perfil rectangular de acero al carbono 80 x 40 x 2 x 6000mm	8	\$196.028
SUBESTRUCTURA LIVIANA	Perfil rectangular de acero al carbono 40 x 20 x 1.5 x 6000mm	10	\$84.000
PLETINAS Y UNIONES	Pletina de acero al carbono 100 x 6 x 6000mm	4	\$137.000
PERNOS ESTRUCTURALES	Perno hexagonal M10 x 40-50mm	150	\$20.250
GOLLILLAS + TUERCAS	Tuerca con freno + gollilla plana M10	150	\$10.500
PLACAS BASE	Placa base de acero 100 x 100 x 6mm con perforación para nivelador M12	16	\$32.700
NIVELADORES M12	Perno nivelador M12 x 60mm	16	\$23.670
PANELES ZONA PANTALLAS	Acero al carbono 200 x 100cm x 2mm grosor	12	\$670.000
PANELES ZONA SIN PANTALLAS	MDF 9mm 122 x 244cm	15	\$225.000

AUDIOVISUAL / CICATRIZ.			
ELEMENTO	TIPO / MEDIDAS	UDS.	PRECIO
PANTALLAS	LED 70" Full HD	3	\$1.500.000
SOPORTES	VESA ESTANDAR	3	\$38.970
CIELO EMPOTRADO	MDF 19MM 152 x 244cm	3	\$45.000
SONIDO	Barra de sonido 30w	1	\$18.690
CABLEADO	HDMI 3 - 3m	3	\$8.100
CABLEADO	Alargador 6 tomas	1	\$12.990
CABLEADO	Canaletas PVC 2m	3	\$2.670
PC	Compartido con HERIDA.	1	\$0

AUDIOVISUAL / HERIDA.			
ELEMENTO	TIPO / MEDIDAS	UDS.	PRECIO
PANTALLAS	LED 70" Full HD, vertical	3	\$1.500.000
PANTALLAS TEXTO	PANEL LED MATRIX 8 x 32cm	3	\$32.700
SOPORTES	VESA ESTANDAR	3	\$38.970
SENSOR DE DISTANCIA	HC-sr04 (DIAGNÓSTICO)	1	\$2.590
SENSOR DE PRESENCIA	PIR (ESTIGMA Y CUERPO)	2	\$7.770
CÁMARA	Webcam HD (CUERPO)	1	\$19.990
ARDUINO	Arduino UNO R3	1	\$18.690
SONIDO	Barra de sonido 30W	3	\$119.970
CABLEADO	HDMI 3 - 5m	3	\$8.100
CABLEADO	USB para cámara / sensores	2	\$5.690
CABLEADO	Canaletas PVC 2m	5	\$4.450
CABLEADO	Alargador 6 tomas	1	\$12.990
PC	Intel i5, 16gb, NVIDIA GTX serie 1650 (mínimo)	1	\$550.000

TOTAL PROYECTO = \$5.347.478

VIABILIDAD

Fondos a postular

Producción de obras experimentales - Fondo Audiovisual 2026

financiamiento total o parcial para proyectos audiovisuales, tanto interactivos como no interactivos, que se caracterizan por contar con elementos relevantes de innovación y/o experimentación, sea en cuanto a sus técnicas narrativas, sus formas de expresión, sus mecánicas de conexión e interacción con su audiencia, su formato, su uso de herramientas tecnológicas u otros elementos centrales del proyecto.

Monto máximo por proyecto:
\$30.000.000

Fondo Audiovisual 2026

financia la producción y distribución de obras cinematográficas, creación de guiones, equipamiento, formación profesional, investigación y difusión de las nuevas tendencias creativas y de innovación tecnológica. Depende del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual. Líneas de la Convocatoria 2026: Becas Chile Crea, Formación grupal, Investigación, Distribución de cine, Difusión, exhibición e implementación audiovisual, Webseries, Producción audiovisual de obras experimentales, Producción de videojuegos, Producción audiovisual de cortometrajes, Guión original y adaptación literaria, Producción audiovisual de largometrajes, Producción audiovisual regional.

Monto por proyecto:
entre \$8.000.000 y \$335.000.000

Fondart Nacional 2026

financiamiento total o parcial para proyectos de circulación presencial en calidad de invitado para la exhibición de obras (muestras o exposiciones) y/o contenidos (charla o ponencia) ya producidos, y/o para participar en procesos de exploración cuyo objeto sea el intercambio de conocimientos, tales como: Asistencia a residencias artísticas, laboratorios experimentales, programas de observación artística (para el caso de Diseño), o mentorías (para el caso de Artesanía).

Monto máximo por proyecto:
\$18.000.000

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

La realización de este proyecto, y todo el proceso que implicó, me deja profundamente marcado respecto al rol que puede asumir el diseño cuando se trabaja desde un enfoque social. Este camino exigió una reflexión constante sobre mi propio lugar como diseñador y sobre las posibilidades reales de intervenir en problemáticas que afectan vidas concretas.

No fue un proceso fácil. Hubo momentos de frustración, desgaste y dudas, pero justamente esa dificultad me permitió poner a prueba mis capacidades y comprender la importancia de trabajar con rigor, método y sensibilidad. El resultado final tiene una fuerza que me enorgullece, no solo por lo que se logró materializar, sino por lo que aprendí en el recorrido.

A nivel emocional, el proyecto tuvo un impacto enorme. Pasé por rabias, tristeza y también por momentos de alegría y gratitud. Pude conocer a cuatro personas extraordinarias que confiaron en mí y aceptaron participar. Su disposición, sus historias y su generosidad hicieron posible este trabajo, sin ellas, nada habría tenido sentido.

El desafío fue grande, y decidí enfrentarlo poniendo sobre la mesa mis intereses que he adquirido a lo largo de mi formación y pude incorporar un interés más reciente en tecnologías contemporáneas. Me vi trabajando en áreas que nunca imaginé abordar como diseño espacial y diseño industrial, que no formaron parte de mi formación gráfica, pero que me permitieron comprender procesos propios de otras disciplinas y valorarlos de una manera distinta.

Gracias a este proyecto pude experimentar de forma activa lo que significa hacer diseño social, no sólo como un concepto, sino como una práctica concreta. Ver un resultado que responde a las expectativas que tenía al inicio del proceso, y que además aporta a un tema que me importa profundamente, confirma la relevancia que puede tener el diseño cuando se sitúa al servicio de lo humano y lo político.

Proyecciones:

A futuro me gustaría continuar con este proyecto: abrir nuevamente la convocatoria, sumar más testimonios y seguir construyendo comunidad. Mantengo la intención de seguir desarrollando VI(H)SIBLES hasta convertirlo en una experiencia real y accesible, capaz de visibilizar historias que han sido silenciadas de manera persistente.

Aspiro a que este trabajo pueda convertirse en una ofrenda para quienes más lo necesitan y en un espacio donde esas vidas, sus memorias y sus cuerpos, puedan aparecer con dignidad y presencia.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a todas las personas que han pasado por mi formación universitaria, quienes están y quienes ya no están. Guardo un pedazo de cada interacción conmigo.

Agradezco a mis amistades más cercanas dentro de estos 5 años en Diseño: Camila, Magdalena, Munir, Pablo, Cote, Paula. Gracias por estar ahí en cada triunfo y en cada fracaso, por el acompañamiento mutuo que tuvimos en este proceso y por las innumerables risas que compartimos.

Agradezco a Javier, por estar ahí, por tu valentía, tus consejos y las experiencias que hemos compartido, por ser una de mis mayores motivaciones para continuar con este proyecto cuando hubo momentos difíciles.

Agradezco a mis padres y a mi familia, por apoyarme en todo momento y permitirme desarrollarme en la persona que soy hoy. Sin ustedes nada de esto hubiera sido posible.

Quiero agradecer a Vicente, por acompañarme, quererme y alentarme cuando más lo necesité.

Finalmente quiero agradecer a cada persona que fue parte de este proyecto, a Nicolás de Fundación Chile Positivo, a Brait, Ben y Luis por confiar en mi visión. Y a todos los docentes que me han acompañado, enseñado y me han formado como diseñador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Apoyo Positivo. (s.f.). Diferencia entre contagio y transmisión. Recolectado el 19 de mayo, 2025, de <https://apoyopositivo.org/info-vih/diferencia-entre-contagio-y-transmision/>

Barrientos et al. (2012). Índice Compuesto de Estigma y Discriminación (ICED) hacia población gay, otros hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2015/01/%C3%8Dndice-Compuesto-de-Estigma-y-Discriminaci%C3%B3n-2012.pdf

Blamey, R., Sciaraffia, A., Piñera, C., Silva, M., Araya, X., Ceballos, M. E., Cortés, C. P., Twele, L., & Muñoz, R. (2024). Situación epidemiológica de VIH a nivel global y nacional: puesta al día. Revista Chilena de Infectología, 41(2), 248-258. <https://doi.org/10.4067/S0716-10182024000200248>

Carvajal, F. (2019). Pasados suspendidos. Estrategias represivas y tecnologías biopolíticas sobre las disidencias sexo-genéricas durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Páginas, 11(27). <https://doi.org/10.35305/rp.v11i27.366>

Contraloría General de la República de Chile. (2021). Informe Final N° 358-2021: Auditoría de eficacia de los mecanismos implementados por el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Salud, respecto de la prevención de la transmisión del VIH/SIDA. <https://www.contraloria.cl/web/cgr/auditorias/informes-de-auditoria/informes-de-auditoria-2021>

Contardo, Ó. (2011). Raro: Una historia gay en Chile. Editorial Planeta.

Errázuriz, P. Donoso, C. (1990). La manzana de Adán. Zona Editorial.

Ferrer, C. (2018, 31 de diciembre). Minsal lanza campaña para prevenir contagio del VIH y prepara despliegue en terreno para el verano. Emol. <https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/31/932667/Minsal-lanza-campana-para-prevenir-contagio-del-VIH-y-prepara-despliegue-en-terreno-para-el-verano.html>

Ferrer, L., Cianelli, R., & Bernales, M. (2009, enero). VIH y SIDA en Chile: desafíos para su prevención (Temas Agenda Pública, Serie No. 24) [Informe técnico]. Dirección de Asuntos Públicos, Pontificia Universidad Católica de Chile. <https://politicaspUBLICAS.uc.cl/web/content/uploads/2009/03/vih-y-sida-eb-chile-desafios-para-su-prevencion.pdf>

Ferrer Campos, P. (2024). The challenges of Chile to achieve control the HIV/AIDS pandemic the year 2030: A review. Medicine, 103(30), e38288. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000038288>

Guber, R. (2001). La etnografía: Método, campo y reflexividad. Grupo Editorial Norma.

Immersive experience. (s.f.). In ScienceDirect Topics. Elsevier. Recolectado el 29 de junio, 2025, de <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/immersive-experience#definition>

Keller, M. (1975). Superimposition. <https://film-makerscoop.com/catalogue/marjorie-keller-superimposition>

Kuhail, M. A., ElSayary, A., Farooq, S., & Alghamdi, A. (2022). Exploring Immersive Learning Experiences: A Survey. Informatics, 9(4), 75. <https://doi.org/10.3390/informatics9040075>

Lampert Grassi, M. P. (2019, junio). Programas de VIH/SIDA: 2000-2010. Prevención, vigilancia, pesquisa, tratamiento y control [Informe Asesoría Técnica Parlamentaria]. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/27410/1/BCN__2000_2010_programas_prevenccion_y_tratamiento_VIH_SIDA_FINAL.pdf

Levinson, S., & Schafer, H. (2021). Euphoria: F*ck Anyone Who's Not a Sea Blob. <https://www.youtube.com/watch?v=55LsT7JJhCI>

Lombó Fragueiro, C. (2021). Repercusiones del estigma en la calidad de vida de los adultos con VIH/SIDA: Una revisión sistemática. MLS Psychology Research, 4(1), 23-38. <https://doi.org/10.33000/mlspr.v4i1.606>

Lozano-Hemmer, R. (2015). Redundant Assembly. https://www.lozano-hemmer.com/redundant_assembly.php

Maddin, G. (2016). Seances. <https://collection.nfb.ca/interactive/seances>

Magne Tapia, K. (2021). Océanos víricos. <https://ondamedia.cl/show/oceanos-viricos>

Massarelli, V. (2010, 10 de diciembre). Campaña de prevención del VIH: Enfoques y creatividad. CIPER Chile. <https://www.ciperchile.cl/2010/12/10/campana-de-prevencion-del-vih-enfoques-y-creatividad/>

Millaleo, A. (2022). Epu Püllü, Epu Pillan y otras temáticas sexo-afectivas en contexto mapuche: Un acercamiento al Poyewün. Estudios atacameños, 68, e4716. <https://doi.org/10.22199/issn.0718-1043-2022-0014>

Ministerio de Salud de Chile. (s. f.). Minsal lanzó campaña para prevenir VIH/SIDA con amplia participación de la sociedad civil y pueblos indígenas [comunicado en línea]. Recolectado el 4 de junio, 2025, de <https://www.gob.cl/noticias/minsal-lanzo-campana-para-prevenir-vih-sida-con-amplia-participacion-de-la-sociedad-civil-y-pueblos-indigenas/>

Ministerio de Salud de Chile. Departamento Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS. (2019, 12 de junio). Plan nacional de prevención y control del VIH/SIDA e ITS 2018-2019 [PDF]. DIPRECE. https://diprece.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/06/2019.06.12_PLAN-NACIONAL-VIH-SIDA-E-ITS.pdf

Ministerio de Salud, Comisión Nacional de Sida. (s.f.). Resumen de las campañas de prevención del VIH/SIDA (1991-2009). Recolectado el 4 de junio, 2025, de <https://www.minsal.cl/portal/url/item/853849dda84deb30e04001011e015919.pdf>

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. (2023). Artes mediales: prácticas contemporáneas entre arte y tecnología. <https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/artes-mediales-practicas-contemporaneas-entre-arte-y-tecnologia/>

Minsal lanza campaña nacional de prevención del VIH/Sida 2009. (2009, 2 de noviembre). Emol. <https://www.emol.com/noticias/nacional/2009/11/02/382978/minsal-lanza-campana-nacional-de-prevencion-del-vihsida-2009.html>

Moggia, L. (2022). Representación en prensa escrita del VIH/sida en Sudamérica: un análisis de la base de datos Factiva (2014-2018) [Tesis de maestría, Universidad Autónoma de Barcelona]. <https://hdl.handle.net/10803/675850>

Murata, T. (2006). Untitled (Silver). <https://static-files.rhizome.org/Q2651/>

Naumowicz, P. (2023). Frosted-window dancing. <https://motionarray.com/stock-video/woman-dancing-behind-frosted-glass-280017/>

National Cancer Institute. (s.f.). Sistema inmunitario. En Diccionario del cáncer. Recolectado el 24 de mayo, 2025, de <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/sistema-inmunitario>

Obando Cid, A. C., & Vásquez Palma, O. A. (2020). La construcción del cuerpo del SIDA y sus estigmas. Polis (Santiago), 19(55), 140-161. <https://doi.org/10.32735/s0718-6568/2020-n55-1446>

111

Organización Mundial de la Salud. (s.f.). Infecciones de transmisión sexual. Recolectado el 24 de mayo, 2025, de https://www.who.int/es/health-topics/sexually-transmitted-infections#tab=tab_1

Organización Mundial de la Salud. (s.f.). Preguntas y respuestas sobre el VIH/Sida. World Health Organization. Recolectado el 24 de mayo, 2025, de <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/hiv-aids>

Scher, A. (2016). Estigma y discriminación hacia hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH) y mujeres trans: El impacto en la vulnerabilidad y riesgo frente al VIH/SIDA [Tesis de pregrado, Tulane University]. SIT Study Abroad. https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/2461

Tscherkassky, P. (1999). Outer Space. <https://dafilms.com/film/10972-outer-space>

UNAIDS. (2021). Global AIDS Strategy 2021–2026: End inequalities. End AIDS. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS.

UNAIDS. (s.f.). Frequently asked questions about HIV and AIDS. Recolectado el 13 de Abril, 2025, de <https://www.unaids.org/es/frequently-asked-questions-about-hiv-and-aids>

ANEXOS

Consentimiento informado

Documento de Consentimiento Informado:

Estimadx participante:

Te invitamos a participar en una entrevista en el marco del proyecto de título "VI(H)SIBLES", cuyo objetivo es visibilizar y reflexionar sobre los estigmas sociales e internalizados que enfrentan las personas que viven con VIH en Chile, particularmente dentro de la comunidad LGBTQ+.

La información que compartas contribuirá a la creación de material audiovisual inmersivo, que será expuesto públicamente en un espacio cultural (por definir). Este material estará compuesto por fragmentos de testimonios personales, que serán transformados visual y sonoramente en una instalación artística. El propósito no es identificar a las personas entrevistadas, sino abrir un diálogo social y cultural en torno a la discriminación y los imaginarios asociados al VIH dentro de nuestra propia comunidad.

¿Qué implica tu participación?

- La entrevista será grabada en audio y/o video.
- El registro podrá ser editado y adaptado con fines artísticos, sin alterar el sentido de tus palabras.
- El material será utilizado únicamente para fines de investigación académica y exhibición cultural asociados a este proyecto.
- No se utilizarán tus datos personales (nombre, dirección u otra información que permita identificarte), salvo que decidas explícitamente lo contrario.

Confidencialidad y resguardo:

- Los registros serán almacenados de manera segura y solo el equipo de investigación tendrá acceso a los archivos originales.
- El material público será editado de modo que tu identidad quede protegida, a menos que manifiestes tu deseo de aparecer visiblemente.
- En cualquier caso, se garantizará el respeto y dignidad hacia tu testimonio.

Guía de entrevistas

Guía entrevistas

1. ¿Cómo te describirías a tí mismx en pocas palabras?
2. ¿Qué significa para tí tu identidad dentro de la comunidad LGBTQ+?
3. ¿Cómo recuerdas el momento en que recibiste tu diagnóstico? ¿Qué emociones aparecieron en esa primera etapa?
4. ¿Buscaste apoyo en ese momento? ¿Dónde lo encontraste?
5. ¿En qué lugares (trabajo, salud, familia, amistades) sientes que has vivido el estigma de manera más fuerte?
6. ¿Recuerdas la primera vez que alguien te discriminó o te hizo sentir diferente por tu diagnóstico?
7. ¿Qué frases o actitudes se te han quedado grabadas?
8. ¿Has sentido tratos diferentes o discriminación dentro de la misma comunidad? ¿Dónde sientes que se encuentran?
9. ¿Cómo cambia el trato en el mundo de las citas cuando mencionas tu diagnóstico?
10. ¿Alguna vez has tenido que ocultar tu diagnóstico para evitar rechazo?
11. Desde el diagnóstico, ¿qué miedos cargaste contigo en silencio?
12. ¿Cómo cambió tu relación con tu cuerpo, el deseo o el placer?
13. ¿Alguna vez te has sentido culpable o "menos dignx" por vivir con VIH? ¿Cómo te sientes ahora?
14. ¿Qué cosas te mantienen en pié a pesar del estigma?
15. ¿Quiénes han sido tu mayor apoyo en este camino?
16. ¿Qué has aprendido sobre tí mismx viviendo con VIH?
17. ¿Cómo imaginas un futuro donde el estigma social no fuera un tema?

Transcripción entrevista Javier

¿Qué significa para tí tu identidad dentro de la comunidad LGBT?

Javier: Esto es chistoso igual, pero hubo mucho tiempo en el que creí que era hetero-passing, pero me han dicho que no, pero no se, es como piola, tranquila, pero me gusta como el activismo, no sé, como que la he apropiado un poco dentro de mí, la comunidad. Antes era como muy enclosetado y después ya como que comencé a liberarme un poco, como que traté de hacerlo parte de mí, osea, vivo como gay, pero trato igual de llevarlo a algo más crítico en ciertas situaciones.

¿Cómo más crítico?

J: No sé, por ejemplo como que todas mis amistades son básicamente de la comunidad o mujeres, es como gente que se relaciona entre ese círculo, pero no sé, en la universidad me ha tocado compartir con gente heterosexual, normalmente no es como que las evite pero no es como que no congeniamos, sino que, involucra gente como mis amigos que son gays, o que son mujeres igual, por lo general ese es mi círculo, pero en la universidad como he compartido con más gente heterosexual, y trato como de hablarles de los mismos temas que hablamos entre nosotros que creemos que son hablados como generalmente en la vida. Y después me doy cuenta que no es así y trato de comentar con ellos, como compartir esas experiencias.

yo: osea como que intentas expandir ese mundo.

J: si, como hay weas que son más controversiales o no sé, no se hablan tan comunmente fuera de la comunidad.

¿Cómo recuerdas el momento en que recibiste tu diagnóstico?

J: No sé... triste, no sé si triste, chocante.

yo: ¿Y cómo fue?

J: Estaba con mi mamá, me llamaron... diciendo que mi resultado había salido como alterado, que me iban a dar una segunda confirmación y que tenía que esperar los resultados, que me iban a llamar. Después un día me llamaron para decirme si podría ir al otro día a La Serena, porque soy de Ovalle y ahí estaba el centro, y dijeron que tenían mi resultado. Pregunté por qué no me decían altiro y dijeron que era confidencial y que se veía en el momento, así que le dije a mi mamá, le dije que era por eso, antes no le había dicho.

¿Qué emociones aparecieron en esa primera etapa?

J: Un... miedo... mucho miedo, era como miedo e incertidumbre, porque como que no sabía que eso iba a ser como, como mi vida desde ese momento. Me cuestionaba muchas cosas, en ese tiempo estaba recién saliendo del closet entonces también estaba recién conociendo a alguien y no sé, me daba miedo como sentirme excluido o como rechazado.

¿Y buscaste apoyo en ese momento?

J: eh en ese momento se enteraron mis papás, y tenía una amiga como a la que le iba contando en ese tiempo que estaba yendo

al doctor, como lo de que me habían dicho que tenía que ir a revisar mis exámenes, pero solamente sabían ellos, no le conté a nadie más porque en realidad como que no le había tomado mucha importancia porque no pensaba que lo iba a tener. Y ella fue como la primera que se enteró, fue mi primer apoyo, como que le conté altiro y después de una semana después le conté a mi grupo cercano de amigos.

¿y en algún momento tuviste miedo por el estigma quizás?

J: Si en realidad, ahora como que ya no me da tanto miedo como antes, pero igual siempre es como un miedo latente. Pero ya no es el mismo miedo de antes, antes me daba miedo sentirme rechazado en general, como que antes sentía que cualquier persona que supiera de mi diagnóstico como que iba a generar un rechazo hacia mí. Ahora ya no me da miedo ese rechazo, como que si es que alguien lo comprende bacán, si alguien no lo comprende como que intentaría explicar, y si no se puede como que.. listo. Pero me da miedo como en no sé, en un tema laborales porque trabajo en la salud, y sé que dentro de la misma salud me ha tocado con compañeros y me imagino que con gente que es más adulta que pueden sentir ese estigma y que pueda ocasionar algo que genere como un conflicto en mi vida, más allá de el rechazo de una persona es el hecho de que sea una situación que no fuera tan facil de salir de ahí.

¿has vivido el estigma directo en lugares de trabajo, familia, amistades?

J: No directo, no es como que pueda contar de mi experiencia y haya tenido una

situación de rechazo, pero sí me ha tocado situaciones en general como por ejemplo estoy recién conociendo a alguien, amigos o gente en un grupo y tiran comentarios que son desinformados, como hablar de sida o los “weones sidosos”, ahí siempre está ese apretón de guata, pero después es como ya, entiendo que no saben lo que están diciendo. Y una vez tuve una situación en la que más allá de estigma fue una persona que reveló mi diagnóstico sin mi consentimiento.

¿y qué te hizo sentir eso?

J: Fue como impotencia, decepción igual y rabia osea, en el momento, como que no sé... sentía que era algo que me pertenecía a mí, me sentí pasado a llevar.

¿Alguna vez hay alguna frase o actitud que te haya quedado grabada?

J: No sé si hay alguna situación en particular pero la frase “sidoso” es como muy... muy... como muy mal utilizada, siempre es como despectivo, como en varias situaciones he escuchado cosas como “me da miedo que este weon sea un sidoso” o alguien contando una experiencia, que se involucró con alguien y dicen no me di cuenta que tenía sus exámenes, cosas así. Ahí se utiliza más el término “sidoso”, esa es una palabra que no me gusta, yo la uso mucho como webeando, apropiándome, pero cuando se que hay alguien que no sabe o lo escucho en un contexto muy casual ahí como que me genera un poco de atrape, como no sé... me siento juzgado sin que me lo digan directamente, pero pienso como ya... si lo están diciendo así, me lo podrían decir a mí también.

¿Y dentro de la misma comunidad, que debería ser un espacio de apoyo o contención, pero has sentido discriminación o tratos diferentes?

J: Me pasa que a veces siento que dentro de la misma comunidad es más estigmatizadora que con personas heterosexuales, en base a mi experiencia y lo que he sentido. Es un pensamiento que nace más porque no sé, le he contado a gente heterosexual y gente gay de mi condición y no me he sentido juzgado, pero es en redes sociales como no sé.. en twitter, como cuando han salido noticias como por ejemplo, no sé cuándo fué pero cuando el Canuilef que era un periodista dijo que era VIH positivo publicamente fue muy comentado porque una persona que se había involucrado con él dijo que, todo muy desinformado, dijo que había compartido utensilios con él y que le había dado besos y que no le había dicho, ahí como que se generó un debate de si se debería decir el diagnóstico o no, o que la otra persona se tiene que cuidar por su cuenta y todo el tema. La cosa es que me metía a ver los comentarios para saber cómo era la opinión de la gente y muchas veces leía comentarios muy despectivos de gente que es de la misma comunidad más que de gente hetero.

¿Y por qué crees que pasa eso?

J: Yo creo que es por el mismo miedo, porque la enfermedad está asociada a la comunidad y yo creo que como se ha asociado tanto el VIH a la comunidad, en especial a la gay, se genera un rechazo, como que mientras uno no lo tenga es algo que lo ven como muy ajeno y no sé, como que se genera un miedo, porque no siento que sea como asco, sino que como se asocia al VIH con la comunidad gay, el hecho

de que te juzguen por ser gay y además por tener VIH es como un rechazo extra y quizás por eso se genera este rechazo dentro de la comunidad misma.

¿Alguna vez has mencionado tu diagnóstico en aplicaciones de citas o encuentros, has sentido un cambio en el trato?

J: Nunca lo he mencionado en aplicaciones, pero sí en persona, por lo menos nunca me ha tocado como un cambio, osea, en realidad sí siento el cambio las veces que lo he dicho, pero no es que me sienta como juzgado, sino que es como una apatía, como una falsa apatía, siento que paso a ser como un “pobrecito”, no es que me vean diferente como con asco pero si es como si es un trato diferente como oh que pena, y eso no sé si sea algo malo pero si siento que comienzan a verme como una persona diferente y lo que yo quiero es no ser diferente, solo que tengo una enfermedad, pero no sé, como que mejoran su trato, son mas cuidadosos con el tema, y no es que me moleste, es como si no me juzgaran pero igual me siento juzgado.

¿y cuando has notado ese cambio, qué has sentido, que piensas?

J: Me limito un poco, pienso si debí haberlo dicho o quizás no ahora y era mejor después o buscar otra instancia, no sé... es como un rechazo, como que me retrae un poco.

Yo: ¿Alguna vez has tenido que ocultar tu diagnóstico para evitar el rechazo?

J: Al principio, siempre, como que cuando estaba recién aceptando un poco mi diagnóstico. Porque mi círculo cercano era el que sabía, de a poco empecé a contárselo

a otras personas, y era como, no sé, los comentarios que te mencionaba recién como de “sidoso”, porque ahora a pesar de ese comentario ahora como que si lo puedo decir porque mi fin, o sea, como que me gusta informar más al respecto. Antes no po, antes me daba como miedo, osea, si es que escuchaba ese comentario decía como “ya, no le puedo contar a esa persona porque me va a juzgar”, en cambio ahora como el juzgar ya no me da miedo es como, ya, si me juzga puedo enseñarle a esa persona, pero al principio sí siempre, muchas veces hay mucha gente a la que no le conté porque habían dicho algun comentario y yo decía no es como alguien de confianza ni que le podía contar, o quizás le podría contar a otras personas.

Yo: como que en volá no te sentías seguro, como en defensa?

J: Sí.

Desde que te diagnosticaron con VIH, ¿Hay algún miedo que cargaste contigo en silencio?

J: Em, no sé si en silencio pero miedos muchos, como había dicho de que me juzgaran, como no sé, enfermar a mi pareja, que es como algo que siempre he temido. Ahora estoy indetectable y se que es algo que no pasaría, pero igual siempre está ese miedo latente, porque me sentiría como responsable, me adjudicaría la responsabilidad y es como lo que me pasa. En silencio es más como con mis abuelos, todo mi proceso que ya son 5 años desde que tengo VIH, y son una parte muy importante de mi vida, toda mi experiencia me hubiera gustado vivirla con ellos, porque mi mamá

siempre me apoyó y todavía lo hace, nunca me sentí juzgado por ella, pero en el momento no lo sentía, ahora me doy cuenta ya que no se lo he contado a mis abuelos, pero se que si se los hubiera contado en un principio me hubieran apoyado, pero al principio si lo sentía, tenía ese miedo como, porque eran tan importantes para mí me daba miedo como de que quizás al contarles se alejaran de mí y sería algo que me dolería mucho, por eso prefería mantenerlo en silencio. Me hubiese gustado vivir todo mi proceso en conjunto con ellos, siento que hubiera sido como más ameno. Justo ahora hace dos meses falleció mi abuelo entonces nunca le pude contar, estaba dentro de mis planes contarle.

Yo: Que bueno que sea parte de tus planes contarle, que quisieras hacerlo.

J: Sí, es que ya es algo que es parte de mí, es algo que he intentado instaurar en mi vida, no quiero verlo como ajeno, y tampoco es algo que le debería contar a todos así como presentarme “hola tengo VIH”, pero si es algo que no sé, como contarle naturalmente por ejemplo me preguntan “oye por qué estás tomando esas pastillas?” y decir “noo, es que tengo VIH”, que no sea un impedimento contarle y tener que hablar del tema sino que sea algo más natural, más tranquilo, no algo que sé que pueda generar un rechazo o que sea un tema.

¿Sientes que cambió tu relación con tu cuerpo como el deseo, el placer?

J: Claramente, tuve VIH porque era una persona muy promiscua y después de eso sí generó como un rechazo a involucrarme sexualmente con otras personas, al principio me costaba, no podía, me ponía muy nervioso. Y no podía concretar nada porque no sentía el deseo de hacerlo, como que si lo tenía antes pero cuando llegaba el momento me cohibía, no sé, como que me bloqueaba.

¿Y por qué crees que te pasaba eso?

J: Por lo mismo osea, pensaba si debería contarle a esta persona, va a generar un rechazo, o cuando ya lo contaba pensaba no sé, le doy asco, quizás tienen miedo. Trataba de pensar en lo que la otra persona pensaba en ese momento, como qué estará pensando sobre mí, en esos momento eran comentarios negativos, como no sé, pensaba que se querían ir o que no sabían como decirme que en realidad no querían hacer nada y que estaban siguiendo por obligación.

¿Alguna vez te has sentido culpable, o menos digno por vivir con VIH?

J: Sí, osea, mucho más antes que ahora, pero igual siempre está ese bichito que te pesa un poco, pero es por lo mismo, como que la sociedad se encarga de generarte ese rechazo o sentimiento de culpa, no sé como “ya pero él no se cuidó”, o no sé, como digo, a veces leo algunas cosas online y antes me afectaban mucho, ahora no me afectan tanto pero igual como que me genera un cuestionamiento, no sé, me siento mal, pero ya ahora como lo he trabajado ya no lo siento

tanto, pero igual siempre está presente, me dá como lata, me cuestiono muchas cosas como “puta, por qué no me cuidé”, o “por qué no hice esto, fui weon”, pero ya después se me pasa, antes no po, era muy presente y estaba constantemente culpandome a mi mismo, de que lo que tenía era mi culpa, que en realidad si es mi responsabilidad, pero lo veía como algo malo, como un sentimiento negativo.

Y ahora cómo te sientes con eso? sigues asociandolo a algo negativo?

J: No, lo acepto, ya me di cuenta de que es algo que es parte de mí y que probablemente mientras no exista una cura seguirá siendolo hasta que me muera, es algo que ya está, no es como que pueda quitármelo así que toca aceptarlo, y no lo veo como en el mal plan, sino porque lo he aceptado porque quiero, porque me acepto a mí en realidad. No es como que me vea como Javier con VIH, sino que Javier + VIH y mil otras cosas más que tengo como alergias, etc, no lo veo como una parte de mi personalidad, sino que es parte de algo que está nomas.

¿Qué cosas te han mantenido en pié a pesar del estigma, qué cosas te hacen sentir mejor?

J: Mis amigos, porque a diferencia de otras personas que sí he sentido como esta falsa apatía como verme como pobrecito, tratarme diferente. Cuando se lo conté a mis amigos no les importó, pero no en el mal sentido, sino que no le dieron más importancia de la que se debería dar, fue como “ah ya y cómo estás”, sentí que fue genuina su reacción y eso me hizo entender de que si alguien me rechazaba iba a ser por desinformación, pero no por ser una persona menos querida o

como alguien que debiera ser rechazado. Me di cuenta que ellos me aceptaron porque me querían, pero no necesariamente por eso, sino que me aceptaron porque no lo vieron como algo malo, no fue como que lo hicieran por obligación, como “ya somos sus amigos así que hay que aceptarlo”, sino que sentí que fue como “está bien, somos tus amigos, te queremos pero no tiene nada de malo”, no sentí que haya sido un “oye como estai, pobrecito, tenemos que preocuparnos más del javier”, sino que sentí que no le dieron tanta importancia pero eso era lo que quería, no quería sentirme más revictimizando la situación.

y quienes sientes que han sido tu mayor apoyo en este camino?

J: Mi mamá, el pablo, mi mejor amigo. Y en realidad todo mi círculo cercano, la paula, la mari, la alexia.

¿Sientes que has aprendido algo sobre ti mismo?

J: A aceptarme, al ser algo que no puedo cambiar, ya está ahí, es como la aceptación nomás, antes en general no me aceptaba, en general siempre está esa no aceptación hacia uno mismo, y cuando me di cuenta que esto es algo que no puedo cambiar de mí, no sé si me ví obligado pero fue como “ya, tengo que aceptarlo”, y en realidad me di cuenta que puede ser así con otras cosas, como que me dio esta capacidad de comprensión también.

¿Cómo imaginas un futuro en donde el estigma social o internalizado no fuera un tema?

J: ya esto es muy mamón, no sé, es como lo que siempre he querido, igual he tenido este cambio de pensamiento como más activista, muy pro aceptarlo y compartirlo con otras personas, la experiencia y todo el tema, que igual nace como de la obligación de, porque o lo acepto, o vivo ocultándolo por siempre, y a veces no sé, porque a veces me siento con la obligación de compartir mi diagnóstico y en eso me gustaría que no fuera siempre así, que fuera algo más natural, nunca cuando lo digo es natural, sino que nace desde una necesidad de que la otra persona sepa, siento que si no hubiera el estigma no existiría esa presión. Me gustaría tener esa misma sensación de una persona que no sé, tiene diabetes o cualquier wea que es para toda la vida, que no cargan con esa culpa de rechazo, como ese miedo. Porque yo digo ahora que lo acepto y todo el tema, pero igual el miedo siempre va a estar a sentirse rechazado, y sería bacan que ya no existiera ese miedo constante.

**Si pudieras dejar un mensaje en esta obra,
qué te gustaría que el público no olvidara?**

J: Bueno, para las personas que viven con VIH, se que es una situación difícil, y probablemente suene pesado o poco esperanzador pero siempre va a estar ahí, es un peso con el que uno siempre va a cargar, pero hay que tratar de apoyarse, porque a veces ni en tus familiares o amigos te vas a poder apoyar, a diferencia de lo que me pasó a mí, pero hay que buscar redes de apoyo, porque siempre hay, en un momento pensé que no había nada más allá de mis amistades o familiares, pero me dí cuenta de que existen muchas redes de apoyo, y bueno, que estas redes ya sean amistades, familiares u otras instancias, te ayudan a cargar con este peso, el peso siempre va a ser el mismo, pero hay muchas formas de que ese peso sea cargado también por otras personas, o sea, no es como que carguen con ese peso pero si te ayudan a que sea más liviano.

Para las personas que no tienen VIH, informarse y no vernos como algo ajeno también, entender de que si vas a juzgar a alguien o decir un comentario desinformado, entender que es algo que te puede pasar a tí o puedes estar compartiendo con alguien que lo tiene y que no es una situación agradable, hay que ser un poco más empáticos y conscientes, es algo que le puede pasar a cualquier persona, es algo muy impredecible, y que sean más empáticos con las personas que tienen a su alrededor.